Estilo UERJ

Simulado 5 Resolução

Gabarito, a armadilha de cada questão, o dado que decide e o raciocínio completo, alternativa por alternativa.

80 questões

15 de outubro de 2026

ANTES DE CORRIGIR

Como usar esta resolução

Corrija olhando primeiro a coluna da arma. O que interessa não é o total de acertos, é em qual armadilha você caiu.

ARMA DA BANCA	O QUE FAZ	QUESTÕES	ONDE ESTÃO
Rótulo verdadeiro	um dado real do paciente puxa para a doença de manual errada	24	3, 4, 8, 18, 22, 25, 26, 27, 28, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 56, 60, 62, 68, 70, 74, 75, 77
Negativo no meio	o discriminante é um dado negativo no meio do caso	7	10, 12, 15, 30, 51, 61, 64
Dado omitido	o achado mais famoso foi retirado	7	7, 9, 11, 14, 19, 45, 72
Droga a deduzir	a droga em uso não é nomeada	4	16, 39, 50, 71
Grade X / Y	alternativa composta em que uma metade não basta	12	1, 6, 13, 24, 32, 33, 34, 36, 38, 66, 67, 73
Qualificador	o comando restringe o que se pede	4	20, 23, 55, 59
Limiar	um ponto de corte ou janela decide	10	2, 17, 31, 40, 49, 53, 57, 65, 78, 79
Omissão	a resposta certa é não fazer, ou o degrau mais simples	7	29, 52, 54, 58, 63, 69, 76
Cronologia	o tempo entre os eventos decide	5	5, 21, 35, 37, 80

O que cada arma treina em você

- **Rótulo verdadeiro, negativo no meio, dado omitido:** a leitura em modo confirmação, a sua maior causa de erro de identificação.
- **Grade X / Y e qualificador:** a alternativa aceita pela metade e o comando lido pela metade.
- **Limiar, cronologia e omissão:** a regra aplicada sem checar a condição que a habilita, e o exame ou tratamento a mais, o seu padrão dominante em 15/10/2026.
- **Droga a deduzir:** a droga em uso que decide e não vem nomeada.

Todas as questões têm uma única alternativa defensável pela diretriz citada. Se discordar de alguma, anote: discutir o gabarito é o melhor treino.

GABARITO

Respostas

1 **A**	2 **C**	3 **D**	4 **A**	5 **A**	6 **B**	7 **B**	8 **B**	9 **D**	10 **A**
11 **A**	12 **B**	13 **C**	14 **A**	15 **D**	16 **A**	17 **C**	18 **D**	19 **C**	20 **D**
21 **D**	22 **C**	23 **A**	24 **C**	25 **A**	26 **B**	27 **C**	28 **C**	29 **B**	30 **C**
31 **A**	32 **D**	33 **D**	34 **D**	35 **D**	36 **D**	37 **A**	38 **D**	39 **B**	40 **D**
41 **B**	42 **B**	43 **D**	44 **D**	45 **C**	46 **B**	47 **B**	48 **D**	49 **B**	50 **A**
51 **A**	52 **B**	53 **C**	54 **A**	55 **A**	56 **A**	57 **B**	58 **C**	59 **D**	60 **C**
61 **B**	62 **B**	63 **B**	64 **B**	65 **C**	66 **D**	67 **D**	68 **A**	69 **A**	70 **C**
71 **A**	72 **C**	73 **A**	74 **B**	75 **C**	76 **C**	77 **A**	78 **C**	79 **B**	80 **C**

A cor ao lado de cada letra é a da arma da banca, como na tabela anterior. Distribuição: A 21, B 20, C 20, D 19.

RESOLUÇÃO

Questão por questão

1

Neurologia · Trombose venosa cerebral com infarto hemorrágico e crise: heparina plena já e droga anticrise indicada, a exceção da crise sintomática aguda

Grade X / Y

Gabarito A

Mulher de 33 anos, com dois abortamentos de primeiro trimestre e trombose venosa profunda há 3 anos (tratada por 6 meses), chega com cefaleia progressiva há 5 dias e, hoje, crise focal motora no membro superior direito, com recuperação. Exame: sonolenta, papiledema bilateral, paresia leve no membro superior direito. RM com venografia: trombose do seio sagital superior e de veias corticais, com infarto venoso hemorrágico frontoparietal esquerdo de 3 cm. Anticoagulante lúpico positivo, anticardiolipina IgG 80 GPL e anti-beta-2-glicoproteína I IgG 70 U, persistentes após 12 semanas. Plaquetas 180.000/mm³, sódio 138 mEq/L, glicemia 92 mg/dL. Quanto à anticoagulação neste momento e à droga anticrise, a conduta mais adequada é, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

com infarto venoso hemorrágico frontoparietal esquerdo de 3 cm

Resolução. As duas metades têm um reflexo errado. Na primeira, o infarto hemorrágico assusta e faz adiar a anticoagulação, mas na TVC o sangramento é consequência da hipertensão venosa e só a recanalização o resolve: heparina plena começa já, e adiar aumenta a progressão do trombo. Na segunda, depois de tanta crise sintomática aguda que não pede droga anticrise (hiponatremia, abstinência alcoólica, hipoglicemia), a tentação é não tratar esta também. Mas a TVC é a exceção reconhecida: crise precoce com lesão supratentorial (infarto hemorrágico cortical de 3 cm) tem risco alto de recorrência nas primeiras semanas, e uma nova crise num cérebro com hemorragia e hipertensão venosa piora o desfecho; as diretrizes recomendam droga anticrise nesse cenário, por tempo limitado. O que não se faz é anticrise profilática na TVC sem crise. Sódio e glicemia normais afastam causa metabólica. Os anticorpos antifosfolípides definem a anticoagulação de longo prazo (varfarina), que não é o que se pergunta.

A) Heparina plena / iniciar anticrise CORRETA

Correta. Heparina plena desde já apesar do infarto hemorrágico, e droga anticrise porque houve crise com lesão supratentorial na TVC.

B) Heparina plena / sem anticrise ARMADILHA

Errada na segunda metade, e é a armadilha. Sem anticrise seria o certo na TVC sem crise, ou na crise sintomática aguda de causa metabólica ou tóxica já corrigida; a crise com lesão hemorrágica supratentorial na TVC tem indicação.

C) Adiar por 2 semanas / iniciar anticrise

Errada na primeira metade. Adiar a anticoagulação pela hemorragia é o erro que a diretriz combate; a droga anticrise está indicada.

D) Adiar por 2 semanas / sem anticrise

Errada nas duas metades. Adiar a heparina deixa o trombo progredir, e a crise com lesão supratentorial na TVC pede droga anticrise.

Para levar. TVC: heparina plena mesmo com infarto hemorrágico. Crise na TVC com lesão supratentorial é a exceção à regra da crise sintomática aguda: droga anticrise por tempo limitado; sem crise, não há profilaxia.

ESO 2017 (guideline on cerebral venous thrombosis); AHA 2024 (scientific statement em trombose venosa cerebral).

2

Nefrologia · Acidose lática por metformina com vômitos · delta/delta revelando alcalose metabólica associada

Limiar **Gabarito C**

Mulher de 67 anos, com diabetes tipo 2 em uso de metformina 2 g/dia e doença renal crônica (creatinina basal de 1,4 mg/dL), tem vômitos incoercíveis há quatro dias por gastroenterite, com ingestão mínima. Exame: sonolenta, PA 92/58 mmHg, FC 114 bpm, mucosas secas. Exames: pH 7,36, pCO2 40 mmHg, bicarbonato 22 mEq/L, sódio 138 mEq/L, cloro 88 mEq/L, potássio 3,2 mEq/L, albumina 4,0 g/dL, lactato 13,6 mmol/L, glicemia 172 mg/dL, beta-hidroxibutirato 0,4 mmol/L, creatinina 2,9 mg/dL. O distúrbio ácido-base é:

O DADO QUE DECIDE

sódio 138 mEq/L, cloro 88 mEq/L

Resolução. pH de 7,36 e bicarbonato de 22, quase normais, fazem parecer que não há distúrbio, ou que há uma acidose leve bem compensada. O ânion gap revela o resto: 138 - (88 + 22) = 28, com albumina normal, 16 acima do normal de 12, sobretudo por ácido lático (13,6 mmol/L) acumulado pela hipoperfusão e pela metformina numa função renal que caiu. Cada mEq de ânion não medido deveria consumir cerca de um mEq de bicarbonato: o esperado seria 24 - 16 = 8, e o bicarbonato está em 22. A razão delta/delta (16 ÷ 2 = 8, muito acima de 2) mostra que havia bicarbonato a mais antes da acidose: alcalose metabólica concomitante, pelos vômitos (perda de HCl, com cloro de 88 e potássio de 3,2). A pCO2 de 40 está dentro do esperado para o bicarbonato de 22 (Winters: 1,5 × 22 + 8 = 41 ± 2), sem distúrbio respiratório. É a dupla de quem vomita por dias e entra em choque.

A) Ausência de distúrbio relevante
Errada. pH e bicarbonato normais não excluem distúrbio: com ânion gap de 28 há uma acidose metabólica mascarada por uma alcalose.

B) Acidose lática com acidose hiperclorêmica
Errada. Acidose hiperclorêmica associada daria delta/delta abaixo de 1 e cloro alto; aqui o cloro está baixo.

C) Acidose lática com alcalose metabólica CORRETA
Correta. Ânion gap alto por lactato, delta/delta muito acima de 2 e cloro baixo após vômitos: acidose lática associada a alcalose metabólica.

D) Acidose lática isolada compensada ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Uma acidose lática isolada com ânion gap 16 acima do normal deixaria o bicarbonato perto de 8; o bicarbonato de 22 exige um processo alcalinizante somado.

Para levar. Com ânion gap alto, compare o aumento do gap com a queda do bicarbonato: delta/delta acima de 2 indica alcalose metabólica associada; abaixo de 1, acidose hiperclorêmica associada.

Kraut e Madias, NEJM 2014 (Lactic acidosis); Berend, de Vries e Gans, NEJM 2014 (Physiological approach to assessment of acid-base disturbances); KDIGO 2022 (Diabetes Management in CKD), metformina na DRC.

---

3 Hematologia · Leucemia mieloide crônica x reação leucemoide após pneumonia: basofilia e baço decidem

Rótulo verdadeiro **Gabarito D**

Mulher de 47 anos, tratada há 3 semanas com amoxicilina-clavulanato por pneumonia comunitária, com melhora da febre e da tosse, retorna porque o hemograma de controle mostrou leucocitose. Refere saciedade precoce e sudorese noturna há 3 meses, desde antes da pneumonia. Exame: afebril, baço palpável a 10 cm do rebordo costal. Hemograma: Hb 10,9 g/dL, leucócitos 156.000/mm³ com mielócitos 14%, metamielócitos 9%, bastões 12%, segmentados 48%, basófilos 7%, eosinófilos 5% e blastos 2%; plaquetas 640.000/mm³. PCR 1,2 mg/dL. O exame que confirma o diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

basófilos 7%

Resolução. A pneumonia recente é verdadeira, e leucocitose com desvio à esquerda depois de infecção puxa para reação leucemoide, com busca de foco persistente. Os dados que decidem não pertencem a infecção: basofilia de 7% (a reação leucemoide não produz basófilos), eosinofilia, trombocitose, esplenomegalia de 10 cm e sintomas que começaram antes da pneumonia, com PCR já normalizada. Leucocitose acima de 100.000 com todo o espectro de maturação granulocítica, predomínio de mielócitos e segmentados e poucos blastos é leucemia mieloide crônica em fase crônica. O diagnóstico se confirma pelo BCR-ABL1 no sangue periférico (PCR quantitativo ou FISH); o mielograma com cariótipo entra depois para definir a fase e anomalias adicionais. A fosfatase alcalina leucocitária baixa sugere LMC, mas não confirma, e o JAK2 é das neoplasias mieloproliferativas Filadélfia negativas.

A) Fosfatase alcalina leucocitária
Errada. A fosfatase alcalina leucocitária baixa é sugestiva, mas inespecífica e abandonada; não confirma o diagnóstico.

B) Pesquisa de JAK2 V617F
Errada. JAK2 investiga policitemia vera, trombocitemia e mielofibrose; leucocitose com basofilia e mielócitos é LMC até prova em contrário.

C) Hemoculturas e nova radiografia ARMADILHA
Errada. É a armadilha: reação leucemoide não dá basofilia nem baço de 10 cm, e a PCR já normalizou.

D) Pesquisa de BCR-ABL1 no sangue CORRETA
Correta. Leucocitose com mielócitos, basofilia, trombocitose e esplenomegalia volumosa: LMC, confirmada pelo BCR-ABL1 no sangue periférico.

Para levar. Leucocitose com desvio até mielócitos, basofilia e esplenomegalia volumosa é LMC, mesmo após infecção: confirma-se com BCR-ABL1 no sangue (PCR ou FISH).

ELN 2020 recommendations for CML (Hochhaus et al., Leukemia 2020); NCCN Chronic Myeloid Leukemia 2025.

---

4 Endocrinologia · Tireotoxicose sob pembrolizumabe: tireoidite destrutiva, não iodo do contraste

Rótulo verdadeiro **Gabarito A**

Mulher de 61 anos, com adenocarcinoma de pulmão metastático, iniciou pembrolizumabe há seis semanas; fez tomografia de estadiamento com contraste iodado há quatro semanas. Refere palpitações e insônia há dez dias. Sem doença tireoidiana prévia. Exame: FC 108 bpm, PA 128/80 mmHg, tremor fino, tireoide de volume normal, indolor, sem nódulos, sem sopro, sem oftalmopatia. Exames: TSH 0,02 µUI/mL, T4 livre 2,4 ng/dL (0,8 a 1,8), T3 total 182 ng/dL, TRAb negativo, anti-TPO positivo, cortisol às 8 horas 16 µg/dL, sódio 138 mEq/L. Ultrassonografia: tireoide heterogênea, sem nódulos, com fluxo reduzido. O mecanismo mais provável da tireotoxicose é:

O DADO QUE DECIDE

tireoide de volume normal, indolor, sem nódulos

Resolução. O contraste iodado recente é um rótulo verdadeiro, e o efeito Jod-Basedow é lembrado como causa de tireotoxicose depois de tomografia. Mas ele depende de uma glândula com autonomia prévia (bócio nodular) ou Graves latente, e esta tireoide é de volume normal, sem nódulos, com TRAb negativo. O cenário é o evento endócrino mais comum do anti-PD-1: tireoidite destrutiva indolor, nas primeiras semanas a meses, mais frequente com anti-TPO positivo, e com fluxo reduzido ao ultrassom. A fase tireotóxica é transitória e costuma evoluir para hipotireoidismo em semanas. Trata-se com betabloqueador, sem tionamida, mantendo a imunoterapia nos graus 1 e 2 e repetindo a função tireoidiana em duas a três semanas.

A) Destruição folicular inflamatória CORRETA
Correta. Tireoidite destrutiva por anti-PD-1: glândula normal, indolor, anti-TPO positivo, TRAb negativo e fluxo reduzido.

B) Anticorpo estimulador do receptor de TSH
Errada. Seria Graves, com TRAb positivo, sopro, fluxo aumentado ou oftalmopatia; é rara sob anti-PD-1.

C) Síntese induzida pelo iodo do contraste ARMADILHA
Errada. Jod-Basedow exige bócio nodular ou Graves latente; tireoide normal sem nódulos e com fluxo reduzido não o sustenta.

D) Autonomia de nódulo tireoidiano
Errada. Nódulo autônomo apareceria ao exame ou ao ultrassom, que não mostram nódulos.

Para levar. Tireotoxicose nas primeiras semanas de anti-PD-1 é tireoidite destrutiva: betabloqueador, sem tionamida, mantendo a imunoterapia e vigiando a virada para hipotireoidismo.

ASCO Guideline: Management of Immune-Related Adverse Events 2021; ESMO Guideline on toxicities from immunotherapy 2022; ATA Hyperthyroidism Guidelines 2016.

---

5 Infectologia · Exposição sexual nas últimas 72 horas na consulta de PrEP: PEP antes, PrEP em seguida

Cronologia **Gabarito A**

Homem de 24 anos, que faz sexo com homens, procura o serviço para iniciar PrEP. Relata múltiplas parcerias e uso irregular de preservativo; teve gonorreia há 4 meses. Há 36 horas teve relação anal receptiva sem preservativo com parceria de sorologia desconhecida. Está assintomático. Teste rápido anti-HIV não reagente, creatinina 0,8 mg/dL (clearance estimado acima de 90 mL/min), HBsAg não reagente, VDRL não reagente. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

Há 36 horas teve relação anal receptiva sem preservativo

Resolução. O paciente tem todas as indicações de PrEP e o teste é não reagente, e a regra correta de não adiar a PrEP puxa para iniciá-la hoje. O tempo da última exposição muda o que se faz primeiro: 36 horas está dentro da janela de 72 horas da profilaxia pós-exposição, e a PrEP iniciada agora não protege de uma exposição que já ocorreu (o esquema de duas drogas também é insuficiente como tratamento de uma infecção já em curso). Por isso se inicia a PEP com três drogas (tenofovir, lamivudina e dolutegravir) por 28 dias e, ao final, com novo teste não reagente, faz-se a transição direta para a PrEP, sem intervalo. Esperar 30 dias sem nada perde a janela da PEP e mantém a exposição.

A) PEP por 28 dias e transição direta para PrEP CORRETA
Correta. Exposição há 36 horas pede PEP por 28 dias, emendando a PrEP sem intervalo ao final, com novo teste.

B) Iniciar PrEP hoje, sem PEP ARMADILHA
Errada. É a armadilha: PrEP no mesmo dia seria a conduta sem exposição nas últimas 72 horas; com exposição há 36 horas, a PEP vem primeiro.

C) PEP e reavaliar a PrEP em 3 meses
Errada. Acerta a PEP, mas reavaliar a PrEP só em 3 meses deixa sem proteção uma pessoa com risco contínuo.

D) Repetir o teste em 30 dias, sem medicação
Errada. Esperar sem profilaxia perde a janela de 72 horas da PEP e adia a PrEP sem motivo.

Para levar. Na consulta de PrEP, exposição de risco nas últimas 72 horas manda iniciar PEP por 28 dias e fazer a transição direta para PrEP ao final.

PCDT para Profilaxia Pós-Exposição (PEP) de Risco à Infecção pelo HIV, IST e Hepatites Virais (MS, 2021); PCDT para Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) de Risco à Infecção pelo HIV (MS, 2022).

---

6 Oncologia · Sedação paliativa para sintoma refratário: midazolam titulado de forma proporcional, e não morfina

Grade X / Y **Gabarito B**

Homem de 58 anos com carcinoma epidermoide de pulmão em progressão após todas as linhas de tratamento está internado em cuidados paliativos exclusivos, com prognóstico estimado em horas a poucos dias (PPS 10%). Há 2 dias tem dispneia e agitação que persistem apesar de morfina subcutânea titulada, haloperidol, oxigênio e

tratamento das causas reversíveis, com sofrimento intenso. Quando lúcido, expressou o desejo de não sofrer no fim, e a família concorda com sedação paliativa. Quanto ao fármaco e à forma de titulação, a conduta mais adequada é, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

persistem apesar de morfina subcutânea titulada, haloperidol, oxigênio e tratamento das causas reversíveis

Resolução. Ele aprendeu que morfina é o remédio da dispneia no fim de vida, e a grade usa isso: aumentar a morfina até o doente dormir parece sedação. Mas opioide não é sedativo confiável, e escalá-lo para rebaixar a consciência causa neurotoxicidade (mioclonias, agitação) sem sedar. Sedação paliativa é indicada para sintoma refratário em doente com prognóstico de horas a dias e com consentimento, e o fármaco de primeira escolha é o midazolam, por via subcutânea ou intravenosa, mantendo a morfina na dose que controla a dispneia. A titulação é proporcional: a menor dose que alivia o sofrimento, e não uma dose fixa para produzir inconsciência imediata, o que separa sedação paliativa de eutanásia.

A) Morfina em doses crescentes / titulação proporcional ARMADILHA
Errada. É a isca: a morfina segue para a dispneia, mas não é droga de sedação, e doses crescentes causam neurotoxicidade.

B) Midazolam / titulação proporcional CORRETA
Correta. Midazolam titulado até o alívio do sofrimento, mantendo a morfina na dose sintomática.

C) Midazolam / dose para inconsciência imediata
Errada. O fármaco está certo, mas a sedação paliativa é proporcional ao sintoma; mirar inconsciência imediata em dose fixa descaracteriza a intenção.

D) Morfina em doses crescentes / dose para inconsciência imediata
Errada nas duas metades: droga inadequada e intenção de produzir inconsciência em vez de aliviar.

Para levar. Sedação paliativa: sintoma refratário, prognóstico de horas a dias e consentimento; midazolam titulado de forma proporcional, sem retirar o opioide sintomático.

EAPC recommended framework for the use of sedation in palliative care (2009); ESMO Clinical Practice Guidelines on palliative sedation (2014); Resolução CFM 1.805/2006

---

7 Cardiologia · Cardiopatia carcinoide: insuficiência tricúspide com sinal de Rivero-Carvallo

Dado omitido **Gabarito B**

Homem de 61 anos, com tumor neuroendócrino de íleo e múltiplas metástases hepáticas diagnosticados há 3 anos, em uso de octreotida de depósito, refere edema progressivo de membros inferiores e aumento do volume abdominal há 4 meses, sem ortopneia nem dispneia paroxística noturna. Exame: PA 118×72 mmHg, FC 88 bpm, turgência jugular a 45 graus, hepatomegalia, ascite e edema, pulmões limpos. Albumina 3,9 g/dL. Ecocardiograma de 2 anos atrás: câmaras e valvas normais, sem forame oval patente. O achado auscultatório mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

sem forame oval patente

Resolução. A banca não nomeou a síndrome carcinoide nem deu o 5-HIAA, mas tumor neuroendócrino de íleo com metástases hepáticas é exatamente o cenário em que a serotonina chega à circulação sistêmica sem passar pelo fígado. Ela produz placas fibrosas no endocárdio do coração direito, e a lesão dominante é a insuficiência tricúspide (com estenose e insuficiência pulmonar menos frequentes); as valvas esquerdas são poupadas porque o pulmão inativa a serotonina, salvo com forame oval patente, metástase pulmonar ou secreção muito alta. Por isso o 'sem forame oval patente' no ecocardiograma antigo importa. O sopro da insuficiência tricúspide é holossistólico na borda esternal esquerda baixa e aumenta na inspiração (sinal de Rivero-Carvallo), porque a inspiração aumenta o retorno venoso ao lado direito. Congestão sistêmica com pulmão limpo e albumina normal confirma a origem cardíaca direita da ascite.

A) Sistólico ejetivo aórtico com B2 hipofonética
Errada. Sistólico ejetivo aórtico com B2 hipofonética é estenose aórtica grave, lesão esquerda que o carcinoide raramente produz.

B) Holossistólico paraesternal baixo, maior na inspiração CORRETA
Correta. Placas carcinoides na tricúspide dão insuficiência tricúspide, cujo sopro aumenta na inspiração (Rivero-Carvallo).

C) Ruflar diastólico apical com estalido de abertura
Errada. Ruflar com estalido é estenose mitral reumática, lesão esquerda e de outra etiologia.

D) Holossistólico apical irradiado para a axila ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. Holossistólico apical para a axila é insuficiência mitral, lesão esquerda que o carcinoide poupa quando não há shunt nem metástase pulmonar.

Para levar. Cardiopatia carcinoide é do coração direito: insuficiência tricúspide (holossistólico em borda esternal esquerda baixa que aumenta na inspiração) e lesões pulmonares; o lado esquerdo só é atingido com forame oval patente, metástase pulmonar ou secreção muito alta.

ESC/EACTS 2021 (valvular heart disease); Davar et al., JACC 2017 (expert statement on carcinoid heart disease); ENETS 2022 (guidance paper on carcinoid syndrome and carcinoid heart disease)

8

Reumatologia · Candidata a teriparatida com fosfatase alcalina alta de origem óssea: doença de Paget

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Mulher de 72 anos é encaminhada para iniciar teriparatida. Teve três fraturas vertebrais por fragilidade (T7, T11 e L1) nos últimos 2 anos, a última durante o uso regular de alendronato por 4 anos, e tem T-escore de -3,4 em coluna lombar e -2,9 em colo femoral. Refere dor surda e contínua na coxa esquerda, pior à noite, há 1 ano, e notou a perna esquerda mais arqueada. Exame físico: arqueamento anterolateral do fêmur esquerdo, com calor local discreto. Exames: cálcio 9,6 mg/dL, fósforo 3,4 mg/dL, 25-hidroxivitamina D 38 ng/mL, PTH 44 pg/mL, creatinina 0,8 mg/dL, fosfatase alcalina 390 U/L (VR até 120), GGT 28 U/L (VR até 40), eletroforese de proteínas sem pico monoclonal. Radiografia do fêmur esquerdo: espessamento cortical, trabeculado grosseiro e áreas líticas e escleróticas, sem traço de fratura. Antes de definir o tratamento, o exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

fosfatase alcalina 390 U/L (VR até 120), GGT 28 U/L (VR até 40)

Resolução. Dor na coxa em usuária de alendronato puxa para fratura femoral atípica, e a ressonância parece o exame natural; as fraturas vertebrais puxam direto para a teriparatida. Mas a fratura atípica não eleva a fosfatase alcalina e não arqueia o osso; aqui a fosfatase está três vezes acima com GGT normal (origem óssea), há calor e arqueamento, e a radiografia mostra espessamento cortical com trabeculado grosseiro e áreas mistas: é doença de Paget. Antes de tratar, a cintilografia óssea mapeia a extensão da doença (que pode ser poliostótica e atingir crânio, coluna e pelve) e orienta radiografias dos sítios captantes. O achado muda o plano: teriparatida é contraindicada na doença de Paget e na fosfatase alcalina alta sem explicação, pelo risco de osteossarcoma. O zoledronato em dose única trata a doença de Paget ativa e também serve à osteoporose de risco muito alto, ou se considera romosozumabe conforme o risco cardiovascular.

A) Biópsia da lesão femoral
Errada. O diagnóstico de Paget é radiológico e cintilográfico; biópsia fica para suspeita de transformação sarcomatosa (dor nova intensa, massa, lise agressiva).

B) Cintilografia óssea de corpo inteiro CORRETA
Correta. Fosfatase alcalina óssea alta com radiografia de Paget pede cintilografia para mapear a extensão, e a doença contraindica a teriparatida.

C) Ressonância magnética do fêmur ARMADILHA
Errada. Seria o exame para fratura atípica com radiografia normal e dor na coxa; aqui não há traço de fratura e o quadro é de Paget.

D) Fosfatase alcalina óssea específica
Errada. A GGT normal já indica que a fosfatase alcalina é óssea; a dosagem específica não acrescenta.

Para levar. Fosfatase alcalina alta sem explicação contraindica teriparatida: com GGT normal, investigue Paget com radiografia e cintilografia. Zoledronato trata Paget e osteoporose ao mesmo tempo.

Endocrine Society 2014 Clinical Practice Guideline for Paget's disease of bone; Manual Brasileiro de Osteoporose: orientações práticas (2021); bula da teriparatida (contraindicações).

9

Pneumologia · Fibrose de terços superiores sem exposição identificada: lavado linfocítico e três densidades apontam PH fibrótica, não FPI

Dado omitido | Gabarito D

Homem de 66 anos, engenheiro aposentado, ex-tabagista (25 maços-ano, parou há 20 anos), tem dispneia progressiva e tosse seca há 3 anos. Nega contato com aves, mofo visível em casa, umidificador, edredom ou travesseiro de penas, exposição ocupacional e uso de amiodarona, nitrofurantoína ou metotrexato. Nega Raynaud, artralgia, fraqueza muscular e refluxo. Exame: estertores em velcro bilaterais, baqueteamento digital, SpO2 93% em ar ambiente. TCAR: reticulado com bronquiectasias de tração e faveolamento, mais extenso nos terços superiores e médios e ao longo dos feixes broncovasculares centrais, sem linfonodomegalia; nas bases, lóbulos de atenuação reduzida que escurecem na expiração, lado a lado com áreas de vidro fosco e de parênquima normal. FAN, fator reumatoide, anti-CCP, anti-Scl-70 e painel de miosite negativos. Lavado broncoalveolar: 34% de linfócitos, relação CD4/CD8 de 0,9, culturas negativas. CVF 66% do previsto, DLCO 48%. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

Lavado broncoalveolar: 34% de linfócitos

Resolução. Homem idoso, ex-tabagista, com velcro, baqueteamento e faveolamento, que nega qualquer exposição, tem o perfil da fibrose pulmonar idiopática, e a exposição negada parece encerrar a pneumonite de hipersensibilidade. Mas o antígeno não é identificado em até metade dos casos de PH, e o dado que faltou não derruba o diagnóstico quando a imagem e o lavado o sustentam. A distribuição não é a da FPI (basal e subpleural): a fibrose predomina nos terços superiores e médios e acompanha os feixes centrais, e nas bases há o sinal das três densidades (lóbulos com aprisionamento, vidro fosco e parênquima normal). O lavado com 34% de linfócitos vai contra FPI, em que a linfocitose acima de 30% é incomum e motiva rever o diagnóstico. A relação CD4/CD8 de 0,9 e a ausência de linfonodomegalia afastam a sarcoidose, e as sorologias negativas sem sinais sistêmicos afastam a colagenose. Firmada a PH fibrótica, a busca do antígeno continua (mofo oculto, ar-condicionado, penas em outro ambiente), e o diagnóstico muda o prognóstico e o tratamento.

A) Sarcoidose pulmonar fibrótica
Errada. Sarcoidose também dá fibrose de terços superiores e lavado linfocítico, mas com relação CD4/CD8 alta (acima de 3,5), linfonodos hilares e mediastinais e distribuição peri-hilar; aqui a relação é 0,9 e não há linfonodomegalia.

B) PINE fibrótica associada a colagenose
Errada. PINE de colagenose seria a resposta com Raynaud, artrite, fraqueza ou autoanticorpos; sorologias negativas e ausência de sinais sistêmicos derrubam, e a PINE poupa o espaço subpleural sem faveolamento extenso.

C) Fibrose pulmonar idiopática ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. FPI seria a resposta com predomínio basal e subpleural, sem aprisionamento lobular e com lavado sem linfocitose; a exposição negada não basta para chamar de idiopática.

D) Pneumonite de hipersensibilidade fibrótica CORRETA
Correta. Fibrose de terços superiores e centrais, sinal das três densidades e lavado com 34% de linfócitos: PH fibrótica, mesmo sem antígeno identificado.

Para levar. Exposição negada não exclui pneumonite de hipersensibilidade: fibrose de terços superiores, sinal das três densidades e linfocitose no lavado acima de 30% apontam PH fibrótica, e não FPI.

ATS/JRS/ALAT 2020 (diagnóstico de pneumonite de hipersensibilidade); CHEST 2021 (diagnóstico e avaliação da pneumonite de hipersensibilidade); ATS/ERS/JRS/ALAT 2022 (FPI e fibrose pulmonar progressiva)

---

10 Hepatologia · Nódulo LI-RADS 5 em cirrótico: carcinoma hepatocelular sem biópsia, mesmo com alfafetoproteína normal

Negativo no meio | Gabarito A

Homem de 63 anos com cirrose por vírus C (Child-Pugh A5), com resposta virológica sustentada há 4 anos, está em rastreamento semestral. A ultrassonografia mostrou nódulo novo. RM com contraste extracelular: nódulo de 2,4 cm no segmento VIII com hiper-realce arterial não periférico, washout não periférico na fase portal e cápsula realçada na fase tardia; sem invasão vascular e sem outras lesões. Alfafetoproteína 5 ng/mL. Plaquetas 112.000/mm³, bilirrubina 1,0 mg/dL, ECOG 0. A conclusão diagnóstica mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

hiper-realce arterial não periférico, washout não periférico na fase portal

Resolução. Alfafetoproteína normal e a ideia de que câncer precisa de histologia levam à biópsia, o degrau a mais. No cirrótico, a população em que o critério foi validado, nódulo de 10 mm ou mais com hiper-realce arterial não periférico e washout não periférico, com ou sem cápsula, é LI-RADS 5 e diagnostica carcinoma hepatocelular sem biópsia. A alfafetoproteína é normal em 30 a 40% dos casos e não entra no critério. A biópsia aqui só acrescenta risco de sangramento e de implante no trajeto e pode dar falso negativo. É o oposto do nódulo com o mesmo padrão em fígado sem cirrose, em que adenoma e metástase imitam o achado e a histologia é necessária. Segue-se o estadiamento (BCLC) para ressecção, ablação ou transplante.

A) Carcinoma hepatocelular, dispensa biópsia CORRETA

Correta. Cirrótico com nódulo de 2,4 cm, hiper-realce arterial e washout não periféricos e cápsula: LI-RADS 5, carcinoma hepatocelular sem biópsia.

B) Nódulo indeterminado, exige biópsia ARMADILHA

Errada. É a isca: biópsia fica para LI-RADS 4, LR-M ou nódulo em fígado sem cirrose; alfafetoproteína normal não rebaixa o LI-RADS 5.

C) Nódulo displásico, repetir RM em 3 meses

Errada. Nódulo displásico não tem washout com cápsula; repetir imagem em 3 meses é para nódulo menor que 1 cm ou indeterminado.

D) Colangiocarcinoma, exige biópsia

Errada. Colangiocarcinoma tem realce periférico em alvo e progressivo (LR-M); aqui o padrão é não periférico.

Para levar. No cirrótico, nódulo de 1 cm ou mais com hiper-realce arterial e washout não periféricos é carcinoma hepatocelular sem biópsia; alfafetoproteína não entra no critério.

AASLD Practice Guidance on prevention, diagnosis and treatment of hepatocellular carcinoma (2023); ACR LI-RADS v2018

11

Hematologia · Doença de von Willebrand com TTPa normal: o escore de sangramento indica a dosagem do fator

Dado omitido · Gabarito A

Mulher de 24 anos procura o clínico antes de extração de terceiros molares. Desde a menarca tem menstruações de 8 dias com coágulos, já usou sulfato ferroso duas vezes e sangrou por 2 dias após amigdalectomia na infância. Tem equimoses fáceis. A mãe "sangra muito no dentista". Não usa medicamentos. Exames: Hb 11,1 g/dL, ferritina 9 ng/mL, plaquetas 260.000/mm³, INR 1,0, TTPa 32 s (controle 30 s), fibrinogênio 290 mg/dL. Escore de sangramento ISTH-BAT de 7. O próximo exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

Escore de sangramento ISTH-BAT de 7

Resolução. O dado omitido de propósito é o TTPa alargado, que o candidato associa à doença de von Willebrand e que aqui está normal; daí a tentação de liberar a extração com coagulograma normal. Na doença de von Willebrand tipo 1, a mais comum, o fator VIII costuma ficar acima de 40%, e o TTPa só se alarga quando ele cai abaixo disso. O que decide é a clínica: sangramento mucocutâneo desde a infância, menorragia com ferropenia, sangramento pós-amigdalectomia, mãe com sangramento dentário e escore

ISTH-BAT de 7 (6 ou mais é anormal na mulher). A diretriz de 2021 indica dosar o antígeno do fator de von Willebrand, a atividade plaquetária (GPIbM ou cofator de ristocetina) e o fator VIII. O tempo de sangramento é pouco sensível e abandonado, e a deficiência de fator XI alongaria o TTPa.

A) Fator de von Willebrand e FVIII CORRETA
Correta. Sangramento mucocutâneo com escore ISTH-BAT de 7 e história familiar: antígeno e atividade do fator de von Willebrand com fator VIII, mesmo com TTPa normal.

B) Dosagem da atividade do fator XI
Errada. A deficiência de fator XI dá sangramento pós-procedimento, mas alongaria o TTPa, e o padrão aqui é mucocutâneo.

C) Tempo de sangramento de Ivy
Errada. O tempo de sangramento é pouco sensível e reprodutível e foi abandonado na investigação de von Willebrand.

D) Nenhum, o coagulograma é normal ARMADILHA
Errada. É a armadilha: TTPa normal não afasta von Willebrand tipo 1, e o escore de sangramento já é anormal.

Para levar. TTPa normal não afasta doença de von Willebrand: com sangramento mucocutâneo e escore ISTH-BAT alterado, dose antígeno, atividade do fator e fator VIII.

ASH/ISTH/NHF/WFH 2021 guidelines on the diagnosis of von Willebrand disease.

12

Nefrologia · Síndrome nefrótica com anti-PLA2R positivo sem dados atípicos · membranosa primária sem biópsia

Negativo no meio

Gabarito B

Homem de 52 anos tem edema progressivo há dois meses. Não é diabético, não usa anti-inflamatório nem outras medicações e nega perda de peso. Exame: PA 132/84 mmHg, edema 3+. Exames: albumina 2,3 g/dL, proteinúria de 24 h de 6,8 g, creatinina 0,9 mg/dL (TFGe de 96 mL/min/1,73 m²), urina com 4 hemácias por campo, sem cilindros; anti-PLA2R 180 RU/mL (positivo acima de 20); FAN, HBsAg, anti-HCV, anti-HIV e VDRL negativos; C3 e C4 normais; eletroforese de proteínas sem pico monoclonal; rastreamento oncológico para a idade em dia e normal. Em relação à biópsia renal, a conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

Não é diabético

Resolução. Síndrome nefrótica no adulto evoca biópsia renal no automático, e é o degrau a mais que ele costuma subir. Mas a KDIGO 2021 admite o diagnóstico de nefropatia membranosa sem biópsia quando o anti-PLA2R é positivo num quadro nefrótico compatível, desde que nada sugira outra doença ou uma segunda lesão: diabetes (que poderia somar doença renal do diabetes), TFGe reduzida ou em queda rápida, sedimento ativo, sorologias ou complemento alterados, gamopatia. Este paciente não tem nenhum deles: não é diabético, TFGe de 96, sedimento brando, sorologias e complemento normais, sem pico monoclonal. A especificidade do anti-PLA2R para membranosa primária passa de 95%, e o título também tem valor prognóstico. A conduta é suporte (bloqueio do SRAA, diurético, estatina, avaliar anticoagulação pela albumina) e estratificar o risco de progressão para decidir a imunossupressão, monitorando o anti-PLA2R.

A) Realizar antes de qualquer tratamento ARMADILHA

Errada, é a armadilha. Seria a conduta com diabetes, TFGe reduzida, sedimento ativo, anti-PLA2R negativo ou suspeita de causa secundária; nenhum desses está presente.

B) Dispensar neste momento CORRETA

Correta. Anti-PLA2R positivo com síndrome nefrótica e ausência de dados atípicos permite o diagnóstico de membranosa primária sem biópsia.

C) Realizar se anti-THSD7A positivo

Errada. O anti-THSD7A marca uma minoria de membranosas PLA2R negativas e se associa a neoplasia; não condiciona a biópsia num paciente PLA2R positivo.

D) Realizar após seis meses de IECA

Errada. Não há por que adiar uma biópsia indicada, nem fazê-la depois de seis meses se o diagnóstico já está estabelecido; ela entra se a evolução fugir do esperado.

Para levar. Síndrome nefrótica com anti-PLA2R positivo, TFGe preservada, sem diabetes e sem sinal de doença secundária: membranosa primária sem biópsia; biopsie quando algo não encaixa.

KDIGO 2021 (Glomerular Diseases), capítulo de nefropatia membranosa; Bobart et al., Kidney Int 2019 (anti-PLA2R e dispensa da biópsia).

---

13 Neurologia · HSA aneurismática sem crise: nimodipina oral desde a admissão e sem anticrise profilático

Grade X / Y **Gabarito C**

Mulher de 49 anos, tabagista, chega ao PS 3 horas após cefaleia súbita e explosiva durante esforço evacuatório, com vômitos e síncope breve, sem abalos presenciados pelo marido. Exame: Glasgow 15, rigidez de nuca, sem déficit focal, PA 158/92 mmHg. TC de crânio sem contraste: hemorragia subaracnóidea em cisternas da base e fissura sylviana esquerda, sem hematoma e sem hidrocefalia. Angiotomografia: aneurisma de 7 mm na artéria comunicante posterior esquerda, com embolização programada para as próximas horas. Além do controle pressórico e da analgesia, quanto à nimodipina e à profilaxia de crises, a conduta mais adequada é, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

sem abalos presenciados pelo marido

Resolução. A nimodipina está certa, e é a metade que ele acerta; a armadilha mora na segunda metade. Nimodipina oral (60 mg de 4/4 h por 21 dias) começa na admissão de toda HSA aneurismática, não quando aparece vasoespasmo: ela melhora o desfecho funcional e reduz a isquemia cerebral tardia sem reverter o espasmo angiográfico. Profilaxia anticrise de rotina não é recomendada em quem não teve crise, e a fenitoína em particular se associa a pior desfecho cognitivo e funcional (AHA/ASA 2023, recomendação contra). A síncope no ictus é queda transitória de fluxo pelo pico de pressão intracraniana, e o marido não viu abalos: não é crise. Anticrise entra se houver crise clínica, e uma profilaxia curta pode ser discutida apenas em casos de alto risco (hematoma, infarto, aneurisma de ACM), o que não é o caso.

A) Só se houver vasoespasmo / sem anticrise
Errada na primeira metade. Nimodipina é preventiva e se inicia na admissão; esperar vasoespasmo perde o benefício. Sem anticrise está certo.

B) Só se houver vasoespasmo / fenitoína profilática
Errada nas duas metades. Atrasa a nimodipina e indica fenitoína que a diretriz desaconselha.

C) Nimodipina oral desde já / sem anticrise CORRETA
Correta. Nimodipina oral desde a admissão por 21 dias e nenhuma profilaxia anticrise em quem não teve crise.

D) Nimodipina oral desde já / fenitoína profilática ARMADILHA
Errada na segunda metade, e é a armadilha. A nimodipina está certa, mas a fenitoína profilática piora o desfecho e não está indicada sem crise.

Para levar. HSA aneurismática: nimodipina oral 60 mg de 4/4 h por 21 dias desde a admissão; sem crise, sem anticrise (fenitoína profilática piora o desfecho).

AHA/ASA 2023 (hemorragia subaracnóidea aneurismática); Neurocritical Care Society 2023.

---

14 Infectologia · Hanseníase neural pura no diabético: nervo espessado sem lesão de pele e com baciloscopia negativa

Dado omitido **Gabarito A**

Homem de 49 anos, pedreiro, natural de Imperatriz (MA), com diabetes tipo 2 há 6 anos em uso de metformina (HbA1c 7,4%), procura atendimento por dormência na borda medial da mão esquerda e no dorso do pé direito há 8 meses, com fraqueza progressiva para segurar ferramentas e tropeços frequentes com o pé direito. Nega queimação nos pés, febre ou perda de peso. Exame: sem manchas, placas ou nódulos em toda a pele; atrofia dos interósseos e garra do 4º e 5º dedos à esquerda; pé caído à direita; hipoestesia térmica e dolorosa no território do ulnar esquerdo e do fibular comum direito; nervo ulnar esquerdo no cotovelo e fibular comum direito na cabeça da fíbula espessados e dolorosos à palpação; aquileus presentes e simétricos; vibração normal nos hálux. Glicemia de jejum 132 mg/dL, creatinina 0,9 mg/dL, VHS 18 mm. Baciloscopia de raspado intradérmico de lóbulos e cotovelos: negativa. O diagnóstico mais provável é:

> O DADO QUE DECIDE
> *nervo ulnar esquerdo no cotovelo e fibular comum direito na cabeça da fíbula espessados e dolorosos à palpação*

Resolução. O diabético com déficit de nervos isolados leva à mononeuropatia diabética, e a ausência de qualquer lesão de pele parece afastar a hanseníase, cuja imagem mais lembrada é a mancha com alteração de sensibilidade. Mas a forma neural pura existe e não é rara nas áreas endêmicas, e o Maranhão está entre as de maior endemia: acomete troncos nervosos sem lesão cutânea e costuma ter baciloscopia negativa. O dado que decide é o espessamento doloroso dos nervos nos pontos de predileção (ulnar no cotovelo, fibular na cabeça da fíbula), que não ocorre na neuropatia diabética, na vasculite nem na compressão simples. O padrão também não é o do diabetes: a polineuropatia diabética é simétrica e distal, com aquileus abolidos e vibração reduzida, e aqui aquileus e vibração estão preservados, com perda térmica e dolorosa no território de cada nervo. A eletroneuromiografia documenta a mononeuropatia múltipla, e a biópsia de nervo confirma quando necessário. O tratamento é a poliquimioterapia, com prednisona para a neurite com déficit recente e prevenção de incapacidades.

A) Hanseníase neural pura CORRETA

Correta. Mononeuropatia múltipla com nervos espessados e dolorosos nos pontos de predileção, perda térmica e procedência endêmica, sem lesão de pele: forma neural pura.

B) Mononeuropatia múltipla diabética ARMADILHA

Errada. É a armadilha: o diabetes pode causar mononeuropatias, mas não espessa nervos, e o diabetes controlado, com aquileus e vibração preservados, não sustenta o quadro.

C) Mononeurite múltipla por vasculite

Errada. Vasculite faz mononeurite múltipla dolorosa e de instalação rápida, com sintomas sistêmicos e provas inflamatórias altas, e não espessa o nervo; a VHS é de 18 mm.

D) Neuropatias compressivas ulnar e fibular

Errada. Compressão no cotovelo e na cabeça da fíbula explicaria a topografia de cada nervo, mas não o espessamento doloroso nem dois nervos de lados opostos com perda térmica.

Para levar. Nervo espessado e doloroso à palpação, com perda térmica no seu território, em procedente de área endêmica, é hanseníase mesmo sem mancha e com baciloscopia negativa (forma neural pura).

Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Hanseníase (MS, 2022); Diretrizes para Vigilância, Atenção e Eliminação da Hanseníase como Problema de Saúde Pública (MS, 2016).

15

Endocrinologia · Diabetes tipo 1 com queda da necessidade de insulina: Addison na síndrome poliglandular

Negativo no meio

Gabarito D

Mulher de 26 anos, com diabetes tipo 1 há 12 anos e hipotireoidismo por Hashimoto em levotiroxina, usa glargina e asparte. Nos últimos três meses teve hipoglicemias frequentes e reduziu por conta própria a insulina total de 46 para 30 UI/dia; perdeu 4 kg, com náuseas e cansaço. Nega diarreia, distensão abdominal, esteatorreia ou mudança na dieta; não pratica exercício novo e não usa álcool. Técnica e locais de aplicação adequados, sem lipo-hipertrofia. Exame: PA 96/62 mmHg deitada e 82/54 mmHg em pé, abdome indolor, sem bócio. Exames: HbA1c 6,4% (era 7,8%), sódio 132 mEq/L, potássio 5,3 mEq/L, creatinina 0,8 mg/dL, TSH 2,1 µUI/mL, hemoglobina 12,8 g/dL, ferritina 64 ng/mL. A causa mais provável da queda da necessidade de insulina é:

O DADO QUE DECIDE

Nega diarreia, distensão abdominal, esteatorreia ou mudança na dieta

Resolução. Diabetes tipo 1 com hipoglicemias novas, perda de peso e outra doença autoimune evoca doença celíaca, a associação mais rastreada no tipo 1, que reduz a absorção de carboidrato. O negativo no meio do caso a enfraquece: nada de diarreia, distensão ou esteatorreia, e ferritina e hemoglobina sem ferropenia. O que sobra explica tudo: hipotensão postural, sódio baixo e potássio alto, com a necessidade de insulina caindo porque falta cortisol, hormônio contrarregulador que se opõe à insulina. É insuficiência adrenal primária autoimune, e com Hashimoto e diabetes tipo 1 configura síndrome poliglandular tipo 2. O próximo passo é cortisol e ACTH, com hidrocortisona sem demora se houver instabilidade.

A) Gastroparesia diabética

Errada. Causa hipoglicemia pós-prandial imprevisível, com plenitude e vômitos, mas não hiponatremia, hipercalemia e hipotensão postural.

B) Doença celíaca ARMADILHA

Errada. Seria a causa com diarreia, distensão, ferropenia ou anticorpo antitransglutaminase positivo; não explica hipercalemia nem hipotensão postural.

C) Hipotireoidismo mal controlado

Errada. O TSH está normal; hipotireoidismo reduz pouco a necessidade de insulina e não causa hipercalemia nem hipotensão postural.

D) Insuficiência adrenal primária CORRETA

Correta. Queda da necessidade de insulina com hipotensão postural, hiponatremia e hipercalemia em portadora de autoimunidade é Addison.

Para levar. Diabetes tipo 1 com hipoglicemias novas e queda da dose de insulina: pense em insuficiência adrenal (SPA2) e em doença celíaca; eletrólitos e pressão postural separam as duas.

Endocrine Society, Primary Adrenal Insufficiency 2016; ADA Standards of Care 2026, seção 4 (rastreio de doenças autoimunes no tipo 1).

---

16 Reumatologia · Lúpus induzido por hidralazina a deduzir: o autoanticorpo esperado

Droga a deduzir **Gabarito A**

Homem de 69 anos, preto, com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, usa há 14 meses sacubitril-valsartana, carvedilol, espironolactona, furosemida e a associação de nitrato com vasodilatador arterial direto. Há 5 semanas apresenta febre baixa, artralgia de mãos e punhos e dor torácica pleurítica. Nega fotossensibilidade, úlceras orais, alopecia, edema novo e alterações urinárias. Exame físico: T 37,8 °C, atrito pleural em base esquerda, artrite em 2 metacarpofalângicas, sem lesões cutâneas. Exames: Hb 12,6 g/dL, leucócitos 4.200/mm³, plaquetas 210.000/mm³, creatinina 1,1 mg/dL, EAS normal, C3 e C4 normais, FAN 1:640 com padrão nuclear homogêneo. Radiografia: pequeno derrame pleural à esquerda. O autoanticorpo mais provavelmente reagente neste paciente é:

O DADO QUE DECIDE

a associação de nitrato com vasodilatador arterial direto

Resolução. FAN em título alto com padrão homogêneo, serosite e artrite levam ao lúpus e ao anti-DNA nativo, que é o anticorpo ligado a esse padrão. Mas o paciente é homem, de 69 anos, e usa há mais de 1 ano a associação de nitrato com vasodilatador arterial direto, que é a hidralazina, uma das drogas que mais induzem lúpus. Os negativos completam o retrato do lúpus induzido: sem nefrite (EAS normal), sem lesão cutânea ou de mucosa, sem citopenia relevante e com complemento normal. Nesse quadro, o anticorpo esperado é o anti-histona, presente em mais de 90% dos casos por hidralazina e procainamida, com anti-DNA nativo e anti-Sm em geral negativos. A conduta é suspender a hidralazina (substituindo-a no esquema da insuficiência cardíaca) e tratar a serosite com AINE ou corticoide em dose baixa por curto período; o quadro regride em semanas a meses.

A) Anti-histona CORRETA

Correta. Lúpus induzido por hidralazina, com serosite e artrite, sem rim e com complemento normal: o anticorpo esperado é o anti-histona.

B) Anti-Sm

Errada. O anti-Sm é específico do lúpus idiopático e praticamente não ocorre no induzido por droga.

C) Anti-Ro/SSA

Errada. O anti-Ro aparece no lúpus cutâneo subagudo induzido por drogas como tiazídicos e terbinafina, com lesões anulares fotossensíveis, ausentes aqui.

D) Anti-DNA nativo ARMADILHA

Errada. O anti-DNA nativo acompanha o lúpus idiopático com nefrite e complemento baixo; no induzido por hidralazina costuma ser negativo (é mais visto no induzido por anti-TNF).

Para levar. Serosite e artrite com FAN homogêneo em idoso que usa hidralazina, sem rim e com complemento normal, é lúpus induzido: anti-histona positivo, e a conduta é suspender a droga.

EULAR/ACR 2019 classification criteria for SLE (exigem afastar causa alternativa); Kelley & Firestein's Textbook of Rheumatology, 11ª ed. (2021); AHA/ACC/HFSA 2022 Guideline for the Management of Heart Failure (hidralazina-nitrato).

17

Medicina baseada em evidências · Ensaio de não inferioridade: intervalo de confiança contra a margem

Limiar **Gabarito C**

Ensaio clínico de não inferioridade comparou um anticoagulante oral novo à varfarina na prevenção de AVC na fibrilação atrial. A margem de não inferioridade pré-especificada foi de 1,38 para a razão de riscos (hazard ratio). O resultado foi hazard ratio de 0,88, com intervalo de confiança de 95% de 0,75 a 1,03 na análise por protocolo e de 0,77 a 1,06 por intenção de tratar. A conclusão correta é que o novo anticoagulante é:

O DADO QUE DECIDE

A margem de não inferioridade pré-especificada foi de 1,38

Resolução. Quem lê com a lógica do ensaio de superioridade vê o intervalo cruzando 1 e conclui que não há diferença ou que o estudo é inconclusivo. Mas a pergunta de um ensaio de não inferioridade é outra: o limite superior do intervalo de confiança fica abaixo da margem pré-especificada? Aqui, 1,03 e 1,06 estão abaixo de 1,38, nas duas análises (por protocolo e por intenção de tratar, que devem concordar): a droga é não inferior. Como o intervalo inclui 1, superioridade não foi demonstrada; seria se o limite superior ficasse abaixo de 1. Equivalência exigiria margem nos dois lados, o que o desenho não testou.

A) Superior à varfarina

Errada. Superioridade exigiria o limite superior abaixo de 1; o hazard ratio pontual de 0,88 sozinho não basta.

B) Equivalente à varfarina

Errada. Equivalência exige o intervalo inteiro dentro de uma margem bilateral; o estudo testou só um lado.

C) Não inferior, sem superioridade demonstrada CORRETA

Correta. Limite superior (1,03 e 1,06) abaixo da margem de 1,38 nas duas análises, e intervalo que inclui 1: não inferior, sem superioridade.

D) Inconclusivo, pois o intervalo cruza 1 ARMADILHA

Errada, e é a armadilha. Cruzar 1 decide superioridade; não inferioridade se julga pelo limite superior contra a margem de 1,38.

Para levar. Não inferioridade: compare o limite superior do intervalo de confiança com a margem pré-especificada, nas análises por protocolo e por intenção de tratar; superioridade exige que ele fique abaixo de 1.

CONSORT 2010, extensão para ensaios de não inferioridade e equivalência (JAMA 2012); FDA 2016 (Non-Inferiority Clinical Trials)

---

18 Cardiologia · Cardite reumática aguda: sopro de Carey Coombs x estenose mitral

Rótulo verdadeiro **Gabarito D**

Rapaz de 17 anos procura atendimento por dor e edema que migram entre joelhos, tornozelos e cotovelos há 10 dias, febre de até 38,5 °C e cansaço. Teve faringite não tratada 3 semanas antes. Exame: Tax 37,4 °C, FC 118 bpm, sopro holossistólico apical irradiado para a axila e sopro mesodiastólico curto, de baixa frequência, no ápice, sem estalido de abertura e sem reforço pré-sistólico. ASLO 820 UI/mL, VHS 92 mm/h, intervalo PR de 220 ms. Ecocardiograma: espessamento discreto dos folhetos mitrais com insuficiência moderada, sem fusão comissural, área valvar normal. O sopro diastólico corresponde a:

> O DADO QUE DECIDE
>
> *sem fusão comissural, área valvar normal*

Resolução. Febre reumática com sopro diastólico apical é a associação decorada com estenose mitral, e é a armadilha. Mas a estenose mitral reumática exige fusão comissural, que leva anos a décadas de surtos, e o ecocardiograma mostra comissuras livres e área normal, três semanas após a faringite. O sopro mesodiastólico curto, de baixa frequência, sem estalido, na cardite aguda é o sopro de Carey Coombs: valvulite com edema dos folhetos somado ao hiperfluxo diastólico pela insuficiência mitral. Ele desaparece com a regressão da cardite. Austin Flint é o ruflar apical da insuficiência aórtica grave, e Graham Steell é o diastólico pulmonar da hipertensão pulmonar.

A) Sopro de Graham Steell

Errada. Graham Steell é o diastólico em borda esternal esquerda alta da insuficiência pulmonar por hipertensão pulmonar.

B) Sopro de Austin Flint

Errada. Austin Flint é o ruflar apical da insuficiência aórtica grave, pelo jato regurgitante sobre o folheto anterior mitral; não há insuficiência aórtica.

C) Estenose mitral reumática ARMADILHA

Errada, e é a armadilha. Estenose mitral é sequela tardia, com fusão comissural, estalido de abertura e área reduzida; aqui as comissuras são livres e a área é normal.

D) Sopro de Carey Coombs CORRETA

Correta. Mesodiastólico apical curto e sem estalido na cardite aguda, com valvulite mitral e insuficiência moderada: Carey Coombs.

Para levar. Sopro diastólico apical na febre reumática aguda é Carey Coombs (valvulite, transitório); estenose mitral é sequela de anos, com fusão comissural e estalido. Austin Flint é da IAo grave; Graham Steell, da hipertensão pulmonar.

Diretrizes Brasileiras de Febre Reumática (SBC 2009); AHA 2015 (critérios de Jones revisados); WHF 2023 (rheumatic heart disease)

19

Gastroenterologia · Doença celíaca com anti-transglutaminase IgA negativo: dosar IgA total antes de confiar no resultado

Dado omitido **Gabarito C**

Mulher de 27 anos tem anemia ferropriva refratária a ferro oral há 2 anos, distensão abdominal e evacuações amolecidas. Teve três episódios de sinusite bacteriana e duas giardíases tratadas nos últimos 3 anos. Mãe com tireoidite de Hashimoto. Exame: IMC 19 kg/m², palidez, sem outras alterações. Exames: hemoglobina 9,8 g/dL, ferritina 6 ng/mL, albumina 3,8 g/dL; anti-transglutaminase IgA de 0,4 U/mL (negativo abaixo de 7), colhido em dieta habitual com glúten. Para interpretar corretamente esse resultado, o exame necessário é:

O DADO QUE DECIDE

três episódios de sinusite bacteriana e duas giardíases

Resolução. Anti-transglutaminase IgA negativo em dieta com glúten parece afastar celíaca, e quem ainda suspeita pede biópsia ou HLA, o degrau seguinte. Mas o caso esconde a pista de deficiência seletiva de IgA: sinusites bacterianas de repetição e giardíase recorrente, próprias dessa imunodeficiência, que é de 10 a 15 vezes mais frequente em celíacos. Sem IgA, o anticorpo da classe IgA dá falso negativo. Por isso o anti-tTG IgA sempre se interpreta junto com a IgA sérica total; se ela estiver baixa, usam-se testes IgG (anti-tTG IgG ou antigliadina deamidada IgG) e, com alta suspeita, biópsia duodenal. HLA serve para excluir, e não para confirmar, e o antiendomísio IgA tem o mesmo defeito do anti-tTG IgA.

A) Anti-endomísio IgA

Errada. O antiendomísio também é da classe IgA e sofre o mesmo falso negativo na deficiência de IgA.

B) HLA-DQ2 e DQ8

Errada. HLA-DQ2 e DQ8 têm alto valor preditivo negativo, mas são positivos em cerca de 30% da população; não interpretam o anticorpo IgA.

C) IgA sérica total CORRETA

Correta. Infecções sinopulmonares e giardíase de repetição sugerem deficiência de IgA, que torna falso negativo o anti-tTG IgA; dosa-se a IgA total.

D) Biópsia duodenal ARMADILHA

Errada. É a isca de quem faz mais: com alta suspeita a biópsia virá, mas a pergunta é como interpretar o anticorpo negativo, e isso depende da IgA total.

Para levar. Anti-transglutaminase IgA só vale com IgA total normal; se baixa, testes IgG e biópsia.

ACG Clinical Guidelines: Diagnosis and Management of Celiac Disease (2023); European Society for the Study of Coeliac Disease guideline (2019)

---

20 Infectologia · Profilaxias primárias na aids com CD4 abaixo de 100: tuberculose sim, MAC não

Qualificador **Gabarito D**

Homem de 30 anos recebe hoje o diagnóstico de HIV na UBS. Está assintomático: nega tosse, febre, sudorese noturna e perda de peso. Exame físico normal. Radiografia de tórax normal. CD4 80 células/mm³, carga viral 180.000 cópias/mL, IgG para toxoplasmose reagente, VDRL não reagente, antígeno criptocócico sérico não reagente, HBsAg não reagente, anti-HBs negativo. Nunca tratou tuberculose nem teve contato conhecido. Inicia hoje tenofovir, lamivudina e dolutegravir e sulfametoxazol-trimetoprima. Além do sulfametoxazol-trimetoprima, a profilaxia indicada agora é:

O DADO QUE DECIDE

CD4 80 células/mm³

Resolução. Com CD4 baixo, a lista de profilaxias vem à cabeça de uma vez, e a azitromicina para o complexo Mycobacterium avium é a mais lembrada depois do sulfametoxazol-trimetoprima, que já cobre pneumocistose e toxoplasmose. O comando pede o que falta além dele. A profilaxia de MAC só se discute com CD4 abaixo de 50, e a diretriz americana a dispensa mesmo nessa faixa em quem inicia TARV de imediato; com CD4 de 80, não há indicação. O antígeno criptocócico não reagente dispensa fluconazol. Já a tuberculose segue regra própria do Ministério da Saúde: pessoa com HIV e CD4 de 350 ou menos tem indicação de tratamento preventivo sem necessidade de prova tuberculínica ou IGRA, desde que a TB ativa esteja afastada, como aqui (sem sintomas e radiografia normal). O esquema pode ser isoniazida com rifapentina (3HP) ou isoniazida isolada por 6 a 9 meses.

A) Nenhuma profilaxia adicional
Errada. Seria a resposta com CD4 acima de 350 e prova tuberculínica negativa; com CD4 de 80, o tratamento preventivo da TB está indicado.

B) Fluconazol diário
Errada. Fluconazol preemptivo é para antígeno criptocócico sérico reagente com CD4 baixo; o antígeno é não reagente.

C) Azitromicina semanal ARMADILHA
Errada. É a armadilha: azitromicina para MAC só se discute com CD4 abaixo de 50; com CD4 de 80 e TARV iniciada hoje, não há indicação.

D) Tratamento preventivo da tuberculose CORRETA
Correta. CD4 de 350 ou menos, TB ativa afastada: tratamento preventivo da tuberculose sem necessidade de PT ou IGRA.

Para levar. Pessoa com HIV e CD4 de 350 ou menos, sem TB ativa, faz tratamento preventivo da TB sem PT ou IGRA; profilaxia de MAC só se discute com CD4 abaixo de 50.

PCDT para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos (MS, 2024); Protocolo de Vigilância da Infecção Latente pelo M. tuberculosis no Brasil (MS, 2022).

---

21 Hematologia · Hemólise 8 dias após transfusão em multípara: reação hemolítica tardia por aloanticorpo

Cronologia **Gabarito D**

Mulher de 44 anos, com 3 gestações prévias, recebeu 2 concentrados de hemácias compatíveis há 8 dias, durante histerectomia por miomatose com sangramento. Teve alta no 3º dia com Hb de 10,1 g/dL. Hoje retorna com icterícia, urina escura e cansaço. Desde a alta usa dipirona e cefalexina por infecção da ferida operatória. Exames: Hb 7,4 g/dL, reticulócitos 6%, LDH 820 U/L, bilirrubina indireta 3,6 mg/dL, haptoglobina indetectável, Coombs direto positivo (IgG), esfregaço com esferócitos e sem esquizócitos. A pesquisa de anticorpos irregulares é positiva para anti-Jka, ausente na amostra pré-transfusional. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

anti-Jka, ausente na amostra pré-transfusional

Resolução. Coombs direto IgG positivo com esferócitos é a assinatura da anemia hemolítica autoimune quente, e a cefalexina oferece uma segunda isca, a hemólise imune por droga. A cronologia decide: hemólise extravascular entre 3 e 14 dias após transfusão, num paciente previamente sensibilizado (três gestações), é a resposta anamnéstica a um antígeno eritrocitário do doador. O anticorpo estava em título indetectável na prova pré-transfusional e reapareceu após a reexposição, e a prova é o anti-Jka novo, ausente antes. Os anticorpos do sistema Kidd são os mais associados a essa reação porque caem rapidamente a níveis indetectáveis. A reação aguda por ABO acontece em minutos a horas, com hemólise intravascular. A conduta é registrar o anticorpo e transfundir, quando necessário, hemácias Jk(a) negativas.

A) Reação hemolítica aguda por ABO
Errada. A reação ABO ocorre em minutos a horas da transfusão, com hemólise intravascular, febre e hipotensão, não após 8 dias.

B) Anemia hemolítica autoimune quente ARMADILHA
Errada. É a armadilha: o Coombs IgG e os esferócitos estão lá, mas um aloanticorpo novo contra antígeno do doador 8 dias após transfusão não é autoanticorpo.

C) Hemólise imune induzida por cefalexina
Errada. Hemólise por cefalosporina é rara, mais associada à ceftriaxona, e não explicaria o aloanticorpo anti-Jka.

D) Reação hemolítica transfusional tardia CORRETA
Correta. Hemólise com Coombs positivo 8 dias após transfusão, em sensibilizada por gestações, com anti-Jka novo: reação hemolítica tardia.

Para levar. Hemólise extravascular 3 a 14 dias após transfusão, com Coombs IgG positivo e aloanticorpo novo (Kidd é o mais traiçoeiro), é reação hemolítica tardia; registrar o anticorpo e dar hemácias antígeno-negativas.

ANVISA, Marco conceitual e operacional de hemovigilância (2015); AABB Technical Manual, 21ª edição (2023).

22

Nefrologia · Piora da creatinina durante a descongestão da IC aguda · natriurese adequada e manutenção do diurético

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Homem de 70 anos, com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida (FE 25%), está no terceiro dia de internação por descompensação com congestão e perfusão preservada. Recebe furosemida 80 mg IV de 12 em 12 horas e perdeu 3 kg, mas ainda tem turgência jugular, estertores em bases e edema 2+. Exame: PA 112/70 mmHg, FC 84 bpm, extremidades quentes, enchimento capilar normal. Exames: creatinina de 1,3 mg/dL na admissão para 1,7 mg/dL hoje, potássio 4,2 mEq/L, lactato 1,1 mmol/L; sódio urinário colhido duas horas após a dose de furosemida de 96 mEq/L, com diurese de 2.400 mL nas últimas 24 horas. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

sódio urinário colhido duas horas após a dose de furosemida de 96 mEq/L

Resolução. Creatinina subindo 0,4 mg/dL no meio da diureticoterapia preenche a definição de piora da função renal, e o reflexo é reduzir ou suspender o diurético para proteger o rim. Mas a piora da função renal durante uma descongestão eficaz não tem o prognóstico ruim da que ocorre com congestão persistente: ela reflete hemoconcentração e queda da pressão de enchimento, não lesão do rim. O que importa é se o diurético está funcionando, e a ESC dá o número: sódio urinário acima de 50 a 70 mEq/L duas horas após a dose (aqui 96) e diurese acima de 100 a 150 mL/h nas primeiras horas indicam resposta adequada. Com congestão residual, perfusão preservada e lactato normal, a conduta é manter a furosemida até a descongestão completa, porque a alta ainda congesto é o que mais leva a reinternação e morte. Dobutamina é para baixo débito com hipoperfusão, que não existe aqui.

A) Suspender a furosemida e hidratar
Errada. Suspender e hidratar um paciente ainda congesto agrava a congestão venosa renal, que é ela mesma causa de piora da função; só caberia com hipovolemia.

B) Reduzir a furosemida pela metade ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Reduzir pela creatinina deixa o paciente congesto; com natriurese adequada e congestão residual, a dose deve ser mantida.

C) Manter a furosemida até a descongestão CORRETA
Correta. Piora da creatinina com resposta natriurética adequada e congestão residual: manter o diurético até a euvolemia.

D) Iniciar dobutamina
Errada. O inotrópico é para o perfil frio com hipoperfusão; as extremidades estão quentes e o lactato é normal.

Para levar. Na IC aguda, creatinina subindo com natriurese adequada e congestão residual não é motivo para reduzir o diurético; o alvo é a descongestão completa.

ESC 2021 (Insuficiência cardíaca), com atualização 2023; Mullens et al., Eur J Heart Fail 2019 (posição da HFA sobre diuréticos na IC); Diretriz Brasileira de IC Crônica e Aguda (SBC 2018).

23

Neurologia · Anticorpo antiamiloide na doença de Alzheimer: anticoagulação como exclusão

Qualificador **Gabarito A**

Na doença de Alzheimer em fase de comprometimento cognitivo leve, com patologia amiloide confirmada e demais critérios preenchidos, a condição que, isoladamente, contraindica o uso de anticorpo antiamiloide (lecanemabe ou donanemabe) pelas recomendações de uso apropriado é:

O DADO QUE DECIDE

isoladamente, contraindica

Resolução. O principal efeito adverso dos anticorpos antiamiloide é a ARIA (edema e micro-hemorragias relacionados à imagem), que pode virar hemorragia grave. Por isso as recomendações de uso apropriado excluem pacientes em anticoagulação, além de mais de 4 micro-hemorragias, siderose superficial, hemorragia prévia e lesões extensas de substância branca. O APOE ε4 aumenta o risco de ARIA e precisa ser genotipado e discutido, mas a heterozigose não exclui; a homozigose tem o maior risco e é pesada caso a caso. Não há limite superior de idade nos estudos (incluíram até 85 a 90 anos), e o uso de inibidor da colinesterase é permitido e frequente. O qualificador 'isoladamente' é o que separa o fator que exclui do que só aumenta o risco.

A) Uso de anticoagulante oral CORRETA
Correta. Anticoagulação é critério de exclusão pelo risco de hemorragia associada à ARIA.

B) Idade acima de 75 anos
Errada. Os estudos incluíram pacientes até 85 a 90 anos, e a idade sozinha não exclui.

C) Uso de donepezila
Errada. Inibidor da colinesterase pode ser mantido com o anticorpo antiamiloide.

D) Heterozigose para APOE ε4 ARMADILHA
Errada, é a armadilha. APOE ε4 aumenta o risco de ARIA e exige discussão, mas a heterozigose sozinha não contraindica.

Para levar. Anticorpo antiamiloide: só em comprometimento cognitivo leve ou demência leve com amiloide confirmado; anticoagulação e mais de 4 micro-hemorragias excluem; APOE ε4 aumenta risco e se discute.

Cummings et al., J Prev Alz Dis 2023 (lecanemabe) e 2025 (donanemabe), recomendações de uso apropriado; ANVISA 2025.

24

Grade X / Y **Gabarito C**

Reumatologia · Artrite reativa pós-clamídia: tratar a uretrite por 7 dias e a artrite com AINE

Homem de 24 anos procura atendimento por dor e edema no joelho esquerdo e no tornozelo direito há 10 dias, dor no calcanhar direito ao caminhar e olhos vermelhos sem perda visual. Há 4 semanas teve ardor ao urinar e secreção uretral clara, não tratados, que persistem leves. Tem parceira nova há 2 meses, sem preservativo. Exame físico: T 37,6 °C, artrite de joelho esquerdo e tornozelo direito, entesite do tendão de Aquiles direito, conjuntivite bilateral, sem lesões de pele ou mucosas. Exames: VHS 48 mm/h, PCR 5,2 mg/dL, HLA-B27 reagente, teste de amplificação de ácidos nucleicos na urina positivo para Chlamydia trachomatis e negativo para gonococo, anti-HIV e VDRL não reagentes. Líquido sinovial inflamatório, sem cristais, com Gram e cultura negativos. Quanto ao antimicrobiano e ao tratamento da artrite, a conduta mais adequada é, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

secreção uretral clara, não tratados, que persistem leves

Resolução. A artrite, a entesite e a conjuntivite após uretrite com HLA-B27 reagente fecham artrite reativa; a dúvida é o antibiótico. O apressado acredita que tratar a bactéria por meses trata a artrite, mas antibiótico prolongado não muda o curso da artrite reativa aguda. O que existe aqui é uma infecção por clamídia ainda ativa, documentada pelo teste de amplificação e pelos sintomas uretrais, e ela deve ser tratada como qualquer uretrite: doxiciclina 100 mg de 12/12 horas por 7 dias, com tratamento da parceira e rastreio de outras IST. A artrite aguda se trata com AINE em dose plena, com corticoide intra-articular para a articulação mais inflamada se necessário. Sulfassalazina fica para a artrite que persiste além de 3 a 6 meses.

A) Doxiciclina por 3 meses / AINE ARMADILHA
Errada na primeira metade. O AINE está certo, mas antibiótico por 3 meses não altera a artrite reativa aguda e só acumula efeitos adversos.

B) Doxiciclina por 3 meses / sulfassalazina
Errada nas duas metades. Antibiótico prolongado e droga modificadora antes do tempo: tratamento a mais nas duas decisões.

C) Doxiciclina por 7 dias / AINE CORRETA
Correta. A clamídia ativa é tratada como uretrite, por 7 dias e com a parceira, e a artrite aguda com AINE.

D) Doxiciclina por 7 dias / sulfassalazina
Errada na segunda metade. O antibiótico está certo, mas a sulfassalazina é para artrite crônica, acima de 3 a 6 meses; na fase aguda o AINE resolve.

Para levar. Artrite reativa: trate a infecção que ainda existe pelo esquema padrão (com parceria) e a artrite com AINE; antibiótico prolongado não muda a artrite e DMARD é para doença crônica.

CDC Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines 2021; Ministério da Saúde, PCDT para Atenção Integral às Pessoas com IST (2022); Kelley & Firestein's Textbook of Rheumatology, 11ª ed. (2021).

25 Pneumologia · Pneumotórax de repetição com cistos pulmonares difusos: VEGF-D antes da biópsia na linfangioleiomiomatose

Rótulo verdadeiro **Gabarito A**

Mulher de 36 anos, tabagista (8 maços-ano), teve há 3 semanas o segundo pneumotórax espontâneo, à direita, tratado com drenagem torácica; o primeiro foi à esquerda, há 1 ano. Refere dispneia aos grandes esforços há 2 anos, atribuída a asma, sem melhora com broncodilatador. Nega lesões de pele, convulsões, doença renal e história familiar de pneumotórax. Exame: SpO2 96% em ar ambiente, sem pápulas faciais nem angiofibromas, murmúrio discretamente reduzido à direita. TCAR após a reexpansão: dezenas de cistos de paredes finas, redondos e de tamanho uniforme (2 a 10 mm), distribuídos difusamente do ápice às bases, incluindo os seios costofrênicos, sem nódulos e sem vidro fosco. TC de abdome e pelve sem angiomiolipoma renal, sem linfonodomegalia e sem ascite. Espirometria: VEF1/CVF 0,66; DLCO 61% do previsto. Para confirmar o diagnóstico, o próximo exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

distribuídos difusamente do ápice às bases, incluindo os seios costofrênicos, sem nódulos

Resolução. Tabagismo com cistos pulmonares lembra histiocitose de células de Langerhans, cuja confirmação costuma exigir biópsia, e a criobiópsia parece o passo natural. Mas a histiocitose dá cistos irregulares e bizarros, com nódulos, nos terços superiores e médios, poupando os seios costofrênicos; aqui os cistos são redondos, uniformes, difusos até as bases e sem nódulos, numa mulher jovem com pneumotórax de repetição e obstrução: linfangioleiomiomatose. Sem angiomiolipoma, esclerose tuberosa, quilotórax ou linfangioleiomioma, a TC característica ainda não fecha o diagnóstico clínico, e a diretriz ATS/JRS indica dosar o VEGF-D sérico antes de qualquer biópsia: 800 pg/mL ou mais, com TC compatível, confirma LAM com especificidade próxima de 100%. Só se o VEGF-D vier abaixo disso a biópsia transbrônquica é o passo seguinte. O diagnóstico importa porque abre a indicação de sirolimo diante de queda funcional, e o segundo pneumotórax já indica pleurodese.

A) Dosagem sérica de VEGF-D CORRETA

Correta. TC característica de LAM sem achado extrapulmonar confirmatório: VEGF-D sérico de 800 pg/mL ou mais confirma o diagnóstico sem biópsia.

B) Criobiópsia transbrônquica ARMADILHA

Errada, e é a armadilha. Biópsia transbrônquica é o passo depois de VEGF-D abaixo de 800 pg/mL, ou o exame da histiocitose de Langerhans com nódulos e cistos irregulares poupando as bases; aqui o exame não invasivo vem antes.

C) Dosagem de alfa-1 antitripsina

Errada. Alfa-1 antitripsina investiga enfisema panlobular basal, que são áreas de destruição sem parede; cistos de paredes finas e uniformes não são enfisema.

D) Pesquisa de mutação do gene FLCN

Errada. FLCN é o teste da síndrome de Birt-Hogg-Dubé, com cistos basais, subpleurais e paramediastinais de formato lentiforme, fibrofoliculomas e história familiar; os cistos aqui são difusos e redondos, sem pele ou família sugestivas.

Para levar. Cistos pulmonares difusos, redondos e uniformes em mulher com pneumotórax de repetição: linfangioleiomiomatose. Sem angiomiolipoma ou esclerose tuberosa, dosar VEGF-D (800 pg/mL ou mais confirma) antes de qualquer biópsia.

ATS/JRS 2016 e 2017 (diagnóstico e manejo da linfangioleiomiomatose); BTS Guideline for pleural disease 2023 (pneumotórax)

---

26 Endocrinologia · Acromegalia escondida atrás de apneia do sono, diabetes e hipertensão: IGF-1 antes da ressonância de sela

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Homem de 52 anos, com hipertensão em uso de losartana, anlodipino e clortalidona, diabetes tipo 2 diagnosticado há 2 anos e apneia obstrutiva do sono (índice de apneia e hipopneia de 38 eventos por hora) em uso de CPAP, foi operado de síndrome do túnel do carpo à direita há 1 ano e agora tem parestesias também na mão esquerda. Refere sudorese excessiva e cefaleia frequente. Conta que precisou alargar a aliança e que o número do sapato passou de 41 para 43 nos últimos anos. Exame: PA 148 × 92 mmHg, IMC 29 kg/m², pele espessa e oleosa, espaçamento entre os incisivos inferiores, mãos largas, campos visuais normais à confrontação. Glicemia de jejum 176 mg/dL, HbA1c 8,1%, potássio 4,2 mEq/L. Para investigar a principal hipótese diagnóstica, o primeiro exame a ser solicitado é:

O DADO QUE DECIDE

o número do sapato passou de 41 para 43 nos últimos anos

Resolução. Hipertensão resistente a três drogas, apneia do sono e diabetes recente formam um rótulo verdadeiro de síndrome metabólica com apneia, que chama o rastreio de hiperaldosteronismo. Mas o caso esconde, no meio, o que nenhuma dessas doenças explica: túnel do carpo bilateral, sudorese, pele espessa e oleosa, diastema e, sobretudo, crescimento de extremidades na vida adulta (aliança e sapato). Hipertensão, diabetes e apneia são, aqui, complicações da acromegalia. A investigação começa pelo bioquímico: IGF-1 sérico, ajustado para idade e sexo, que integra a secreção de GH e é o exame inicial recomendado. Se vier elevado ou duvidoso, confirma-se com a falta de supressão do GH após sobrecarga oral de glicose; só depois a ressonância de sela localiza o adenoma. GH basal isolado não serve, porque a secreção é pulsátil.

A) Ressonância magnética de sela túrcica ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a imagem vem depois da confirmação bioquímica; feita antes, um incidentaloma hipofisário não prova acromegalia, e a ressonância seria o passo seguinte com IGF-1 alto e GH não suprimido.

B) IGF-1 sérico CORRETA
Correta. Crescimento de extremidades na vida adulta, túnel do carpo bilateral, sudorese e diastema: o exame inicial é o IGF-1, ajustado para idade e sexo.

C) GH sérico basal
Errada. A secreção de GH é pulsátil e varia com estresse, sono e jejum; um valor aleatório não confirma nem afasta, e só tem papel dentro de testes dinâmicos.

D) GH após sobrecarga oral de glicose
Errada. É o exame de confirmação quando o IGF-1 vem elevado ou duvidoso; como primeiro passo, e com diabetes descompensado, inverte a ordem.

Para levar. Na suspeita de acromegalia, a ordem é IGF-1, depois GH após sobrecarga de glicose se preciso, e só então ressonância de sela; hipertensão, diabetes e apneia podem ser complicações da doença, e não a explicação do quadro.

Endocrine Society 2014 (Acromegaly: an Endocrine Society clinical practice guideline).

---

27 Cardiologia · Taquicardia regular de QRS largo em pós-infarto estável: taquicardia ventricular

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Homem de 67 anos, com infarto anterior há 6 anos, chega com palpitações há 2 horas. Conta que, aos 30 anos, tinha crises de coração acelerado que cediam ao prender a respiração. Está lúcido, sem dor torácica, PA 128×80 mmHg, perfusão periférica boa, FC 168 bpm regular. ECG: taquicardia regular de QRS largo (160 ms), morfologia de bloqueio de ramo direito com eixo desviado para a esquerda, em DII, ondas P a cerca de 80 bpm que marcham sem relação com os QRS, e alguns complexos de largura intermediária entre o QRS sinusal e o da taquicardia. Manobra vagal sem efeito. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

ondas P a cerca de 80 bpm que marcham sem relação com os QRS

Resolução. Dois rótulos verdadeiros puxam para TSV com aberrância: as crises da juventude que cediam com manobra vagal e a boa tolerância hemodinâmica. Nenhum dos dois serve para separar: estabilidade não exclui taquicardia ventricular, e a história antiga não explica o ritmo de hoje. O que decide é o ECG, mesmo sem os nomes: ondas P que marcham na própria frequência sem relação com os QRS são dissociação atrioventricular, e complexos de largura intermediária são batimentos de fusão; os dois são específicos de origem ventricular. A morfologia de BRD com eixo à esquerda não ajuda, porque é também a aberrância bifascicular mais comum. Além disso, em quem tem cicatriz de infarto, a taquicardia de QRS largo é ventricular em mais de 80% das vezes. Na dúvida, toda taquicardia de QRS largo é tratada como ventricular, e o erro de tratá-la como TSV (com verapamil) pode ser fatal.

A) Flutter atrial 2:1 com aberrância
Errada. O flutter 2:1 teria ondas F a cerca de 300 bpm em relação fixa com o QRS, não P dissociadas.

B) Taquicardia antidrômica por via acessória
Errada. A taquicardia antidrômica é de jovem com pré-excitação e mantém relação 1:1 entre átrio e ventrículo, sem dissociação.

C) Taquicardia ventricular monomórfica CORRETA
Correta. Dissociação AV e batimentos de fusão em pós-infarto: taquicardia ventricular monomórfica de cicatriz, mesmo hemodinamicamente estável.

D) TSV com aberrância de condução ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. A aberrância não produz dissociação AV nem batimentos de fusão; a história de crises vagais na juventude não define o ritmo de hoje.

Para levar. Taquicardia de QRS largo com dissociação AV, batimentos de fusão ou captura, ou em paciente com cicatriz de infarto é ventricular; estabilidade hemodinâmica não serve para diferenciar.

ESC 2022 (ventricular arrhythmias and prevention of sudden cardiac death); AHA 2020 (adult advanced life support); critérios de Brugada (Circulation 1991)

---

28 Oncologia · Hipoglicemia paraneoplásica por IGF-2 em tumor fibroso solitário da pleura

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Homem de 66 anos, não diabético, sem uso de medicamentos ou álcool, tem episódios de confusão e sudorese ao amanhecer há 3 semanas. Em um episódio, a glicemia capilar foi de 38 mg/dL, com melhora após glicose. Perdeu 8 kg em 6 meses. TC: massa de 18 cm no hemitórax direito, de origem pleural, sem lesões hepáticas, adrenais normais. Creatinina 0,9 mg/dL, cortisol matinal 19 µg/dL. Em nova hipoglicemia, de 41 mg/dL, colheu-se sangue antes da glicose. O perfil esperado nessa amostra é:

O DADO QUE DECIDE

massa de 18 cm no hemitórax direito, de origem pleural

Resolução. Hipoglicemia de jejum em não diabético faz pensar em insulinoma, e o rótulo leva a insulina e peptídeo C altos. Mas o paciente tem massa pleural de 18 cm e perda de peso: tumores mesenquimais grandes (tumor fibroso solitário da pleura, sarcomas, hepatocarcinoma) produzem pró-IGF-2 processado de forma incompleta, que ativa o receptor de insulina e aumenta a captação de glicose (síndrome de Doege-Potter). O perfil é de hipoglicemia não mediada por insulina: insulina e peptídeo C suprimidos, beta-hidroxibutirato também suprimido (o IGF-2 inibe a cetogênese como a insulina), IGF-1 baixo e razão IGF-2/IGF-1 acima de 10. Cetona alta com insulina baixa seria jejum ou insuficiência adrenal, e o cortisol de 19 µg/dL é normal. O tratamento é a ressecção do tumor, com corticoide enquanto isso.

A) Insulina alta, peptídeo C alto, beta-hidroxibutirato baixo ARMADILHA
Errada. É a isca: insulina e peptídeo C altos com cetose suprimida são do insulinoma ou da sulfonilureia; a massa pleural gigante aponta produção de IGF-2.

B) Insulina alta, peptídeo C baixo, beta-hidroxibutirato baixo
Errada. Insulina alta com peptídeo C suprimido é insulina exógena (hipoglicemia factícia).

C) Insulina baixa, peptídeo C baixo, beta-hidroxibutirato baixo CORRETA
Correta. Tumor fibroso solitário com hipoglicemia: insulina e peptídeo C suprimidos, mas cetogênese também suprimida pelo IGF-2; a razão IGF-2/IGF-1 acima de 10 confirma.

D) Insulina baixa, peptídeo C baixo, beta-hidroxibutirato alto
Errada. Insulina suprimida com cetona alta é hipoglicemia de jejum prolongado, insuficiência adrenal ou álcool; o IGF-2 suprime a cetogênese.

Para levar. Hipoglicemia com tumor mesenquimal grande: insulina, peptídeo C e beta-hidroxibutirato suprimidos, com razão IGF-2/IGF-1 alta.

Endocrine Society Clinical Practice Guideline: Evaluation and Management of Adult Hypoglycemic Disorders (2009); Dynkevich et al., Tumors, IGF-2, and hypoglycemia (Endocr Rev, 2013)

---

29 Infectologia · Viremia por citomegalovírus sem doença de órgão na aids: não tratar

Omissão **Gabarito B**

Homem de 37 anos, com HIV diagnosticado há 10 dias, CD4 32 células/mm³ e carga viral 350.000 cópias/mL, iniciou tenofovir, lamivudina e dolutegravir, além de sulfametoxazol-trimetoprima. Está assintomático: sem alteração visual, moscas volantes, odinofagia, diarreia ou dor abdominal. Exame físico normal. Antes de iniciar a TARV, foi solicitado PCR quantitativo para citomegalovírus no plasma, que resultou em 2.400 cópias/mL; IgG para CMV reagente. Fundoscopia sob midríase realizada pelo oftalmologista: normal. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

Fundoscopia sob midríase realizada pelo oftalmologista: normal.

Resolução. CD4 de 32 é a faixa da retinite e da colite por CMV, e um PCR positivo no plasma parece pedir tratamento preemptivo, como se faz no transplante. Na pessoa com HIV, porém, viremia por CMV sem doença de órgão não é indicação de tratamento: o preemptivo não mostrou benefício, o ganciclovir causa neutropenia e a profilaxia primária não é recomendada. O que se faz é procurar doença de órgão (fundoscopia, que aqui é normal, e investigação dirigida se surgirem sintomas digestivos ou neurológicos) e garantir a TARV, que é a verdadeira prevenção ao recuperar o CD4. O paciente deve ser orientado a procurar atendimento imediato se tiver alteração visual, e a fundoscopia é repetida periodicamente enquanto o CD4 estiver abaixo de 50.

A) Ganciclovir intravenoso por 21 dias
Errada. Ganciclovir intravenoso é o tratamento da doença de órgão (retinite, colite, esofagite); sem doença de órgão, só traz toxicidade.

B) Manter a TARV, sem anti-CMV CORRETA
Correta. Viremia sem doença de órgão na aids: manter TARV, sem anti-CMV, com vigilância oftalmológica.

C) Valganciclovir oral preemptivo ARMADILHA
Errada. É a armadilha: o preemptivo guiado por PCR é estratégia do transplante, não da pessoa com HIV, em que não reduz doença de órgão.

D) Suspender a TARV e repetir o PCR
Errada. A TARV é a principal proteção contra a doença por CMV; suspendê-la pela viremia inverte a lógica.

Para levar. Na aids, PCR de CMV positivo no sangue não é doença e não se trata: procure doença de órgão (fundoscopia, biópsia se houver sintomas) e mantenha a TARV.

NIH/CDC/IDSA Guidelines for Opportunistic Infections in Adults and Adolescents with HIV (CMV, atualização 2024); PCDT para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos (MS, 2024).

---

30 Hematologia · Limiar transfusional restritivo no internado estável sem doença cardiovascular

Negativo no meio **Gabarito C**

Mulher de 56 anos está no 5º dia de internação por pielonefrite com sepse, sem vasopressor desde ontem, com lactato normal e alimentando-se. Tem hipotireoidismo; não tem doença coronariana nem insuficiência cardíaca e não há sangramento ativo. Refere cansaço ao caminhar no corredor. Exame: FC 92 bpm, PA 118 × 70 mmHg,

SpO2 97% em ar ambiente. Exames: Hb 7,3 g/dL (9,8 na admissão, queda atribuída à hemodiluição e às coletas), VCM 88 fL, plaquetas 190.000/mm³, ferritina 680 ng/mL, saturação de transferrina 14%. A conduta mais adequada em relação à anemia neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

não tem doença coronariana nem insuficiência cardíaca e não há sangramento ativo

Resolução. Hemoglobina de 7,3 com cansaço convida a transfundir uma unidade "para garantir". A estratégia restritiva, porém, é o padrão para o adulto internado estável: transfundir abaixo de 7 g/dL, com limiar de 7,5 em cirurgia cardíaca e de 8 em quem tem doença cardiovascular preexistente. Os negativos no meio do caso decidem: sem doença coronariana, sem insuficiência cardíaca, sem sangramento e com a sepse resolvida, o limiar é 7, e ela está acima dele. Cansaço leve ao deambular é esperado na convalescença e não é instabilidade nem isquemia. A ferritina alta com saturação baixa é a anemia inflamatória da sepse, que melhora com a resolução da infecção, e a alfaepoetina não tem indicação no paciente agudo.

A) Transfundir 1 concentrado de hemácias ARMADILHA
Errada. É a armadilha: uma unidade seria o certo abaixo de 7 g/dL ou com doença cardiovascular e Hb abaixo de 8; aqui nenhum dos dois.

B) Transfundir 2 concentrados de hemácias
Errada. Além de não haver indicação, a transfusão se faz uma unidade por vez, com reavaliação.

C) Não transfundir e reavaliar CORRETA
Correta. Internada estável, sem doença cardiovascular nem sangramento, com Hb de 7,3: acima do limiar restritivo de 7 g/dL.

D) Alfaepoetina subcutânea
Errada. Agente estimulador não tem papel na anemia inflamatória da sepse aguda e aumenta o risco trombótico.

Para levar. No internado estável sem doença cardiovascular e sem sangramento, transfunde-se abaixo de 7 g/dL (8 com doença cardiovascular), uma unidade por vez.

AABB International Guidelines for RBC transfusion 2023 (Carson et al., JAMA 2023); Surviving Sepsis Campaign 2021; Ministério da Saúde, Guia para uso de hemocomponentes (2015).

---

31 Neurologia · Neurite óptica com lesões que realçam e não realçam: esclerose múltipla definida já no primeiro surto

Limiar **Gabarito A**

Mulher de 28 anos apresenta há 6 dias dor ao mover o olho direito e perda visual central nesse olho. Nunca teve sintomas neurológicos. Exame: acuidade 20/100 no olho direito, defeito pupilar aferente relativo à direita, fundo de olho normal, restante do exame normal. RM de encéfalo: nervo óptico direito com hipersinal e realce; três lesões periventriculares ovoides e uma justacortical, sendo uma periventricular com realce pelo gadolínio e as demais sem realce; RM de medula normal. Anti-aquaporina-4 e anti-MOG negativos. Líquor sem bandas oligoclonais. Pelos critérios de McDonald, a conclusão mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

sendo uma periventricular com realce pelo gadolínio e as demais sem realce

Resolução. Um único surto puxa para síndrome clinicamente isolada, à espera do segundo evento. Os critérios de McDonald permitem fechar EM no primeiro surto quando a RM demonstra disseminação no espaço e no tempo. No espaço: lesões em pelo menos duas regiões características (periventricular e justacortical; na revisão de 2024 o nervo óptico também conta). No tempo: a presença simultânea de lesão que realça pelo gadolínio e lesão que não realça prova lesões de idades diferentes, sem precisar de nova RM nem de novo surto. Bandas oligoclonais substituiriam a disseminação no tempo, mas não são necessárias quando a RM já a demonstra, e sua ausência não exclui EM. Os anticorpos negativos afastam NMO e MOGAD, que são os diagnósticos que não podem ser esquecidos antes de iniciar droga modificadora.

A) Esclerose múltipla definida CORRETA

Correta. Disseminação no espaço (periventricular e justacortical) e no tempo (lesões com e sem realce na mesma RM) após um surto compatível.

B) EM provável, repetir RM em 6 meses

Errada. Repetir RM só seria necessário se a disseminação no tempo não estivesse demonstrada; aqui ela já está, e adiar atrasa o tratamento.

C) Síndrome radiologicamente isolada

Errada. Síndrome radiologicamente isolada é achado de RM em quem nunca teve sintoma; ela tem neurite óptica.

D) Síndrome clinicamente isolada ARMADILHA

Errada, é a armadilha. Seria a conclusão se a RM mostrasse só lesões sem realce (sem disseminação no tempo) e sem bandas oligoclonais.

Para levar. McDonald: um surto mais lesões com e sem gadolínio na mesma RM, em duas regiões características, já é EM. Bandas oligoclonais substituem a disseminação no tempo.

Critérios de McDonald 2017 (Thompson et al., Lancet Neurol 2018) e revisão de 2024 (Montalban et al., Lancet Neurol 2025); Consenso brasileiro de EM (ABN 2024).

---

32 Reumatologia · Síndrome antifosfolípide trombótica na gestação: enoxaparina em dose terapêutica com AAS

Grade X / Y **Gabarito D**

Mulher de 32 anos teve trombose venosa profunda femoral esquerda não provocada há 3 anos, com anticoagulante lúpico, anticardiolipina IgG e anti-beta2-glicoproteína I reagentes em títulos altos, confirmados após 12 semanas. Usa varfarina desde então, com INR na faixa terapêutica e sem novos eventos. Não tem LES. Há 5 anos teve um aborto espontâneo com 7 semanas. Hoje, com 6 semanas de amenorreia, teste de gravidez positivo. A varfarina será substituída por enoxaparina. Quanto à dose da enoxaparina e ao AAS em dose baixa durante a gestação, a conduta mais adequada é, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

trombose venosa profunda femoral esquerda não provocada há 3 anos

Resolução. Perda gestacional na história e anticorpos antifosfolípides positivos puxam para o esquema da síndrome obstétrica, com heparina profilática e AAS. Mas um único aborto antes de 10 semanas não define a forma obstétrica (exigem-se três ou mais), e o que manda é a trombose: ela tem síndrome antifosfolípide trombótica, triplo positiva, com anticoagulação por tempo indeterminado. Na gestação, a varfarina deve ser trocada já, porque é teratogênica entre 6 e 12 semanas, e o substituto é a heparina de baixo peso molecular em dose terapêutica, associada a AAS em dose baixa. Anticoagulantes orais diretos são contraindicados na gestação e na síndrome triplo positiva. No puerpério, retoma-se a varfarina, compatível com a amamentação.

A) Dose profilática / sem AAS
Errada nas duas metades. Seria opção na gestante com trombose venosa provocada prévia sem anticorpos antifosfolípides; na síndrome trombótica triplo positiva falta dose e falta AAS.

B) Dose profilática / com AAS ARMADILHA
Errada na primeira metade. É o esquema da síndrome só obstétrica, sem trombose; com trombose prévia, a dose profilática não protege a mãe.

C) Dose terapêutica / sem AAS
Errada na segunda metade. A dose está certa, mas as diretrizes associam AAS em dose baixa na síndrome antifosfolípide trombótica durante a gestação.

D) Dose terapêutica / com AAS CORRETA
Correta. Síndrome antifosfolípide trombótica na gestação: heparina de baixo peso molecular em dose terapêutica associada a AAS em dose baixa.

Para levar. Na gestação, síndrome antifosfolípide trombótica pede heparina de baixo peso molecular em dose terapêutica com AAS; dose profilática com AAS é para a forma só obstétrica. A varfarina sai antes da 6ª semana.

EULAR 2019 recommendations for the management of antiphospholipid syndrome in adults; ACR 2020 Guideline for the Management of Reproductive Health in Rheumatic and Musculoskeletal Diseases.

33

Pneumologia · Quilotórax por linfoma em quem teve tuberculose pleural: citometria antes da toracoscopia

Grade X / Y **Gabarito D**

Mulher de 66 anos, tratada para tuberculose pleural à esquerda há 20 anos, tem dispneia progressiva há 2 meses, sudorese noturna e perda de 7 kg. Nega trauma ou cirurgia torácica. Exame: macicez em dois terços do hemitórax direito, sem linfonodos periféricos palpáveis, baço palpável a 2 cm do rebordo. Toracocentese à direita: líquido leitoso e inodoro, triglicerídeos 420 mg/dL, colesterol 64 mg/dL, proteína 4,1 g/dL, LDH 310 U/L, 3.800 células/mm³ (92% linfócitos), ADA 18 U/L, citologia oncológica negativa. TC: derrame pleural direito livre, pleura fina, sem espessamento; linfonodomegalias mediastinais e retroperitoneais de até 3 cm; espessamento pleural calcificado residual à esquerda. O tipo de derrame e o exame seguinte mais adequado são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE
triglicerídeos 420 mg/dL, colesterol 64 mg/dL

Resolução. Líquido leitoso com tuberculose pleural no passado lembra pseudoquilotórax, o derrame de colesterol das pleurites crônicas. Mas a tuberculose foi à esquerda, o derrame atual é à direita, novo, livre e

com pleura fina, e o laboratório decide: triglicerídeos de 420 mg/dL (acima de 110) com colesterol de 64 é quilotórax; pseudoquilotórax tem colesterol acima de 200, triglicerídeos baixos, cristais de colesterol e pleura espessada de anos. Quilotórax sem trauma, com linfócitos, sintomas B, esplenomegalia e linfonodos mediastinais e retroperitoneais é linfoma até prova em contrário (a causa não traumática mais comum). Com líquido abundante e rico em linfócitos já disponível, o exame seguinte é a citometria de fluxo, que demonstra clonalidade sem procedimento invasivo; a biópsia de linfonodo ou pleura fica para quando a citometria não bastar para o subtipo.

A) Pseudoquilotórax / biópsia pleural por toracoscopia
Errada nas duas metades. Pseudoquilotórax exige colesterol acima de 200 e pleura espessada, e a toracoscopia não é o primeiro exame.

B) Quilotórax / biópsia pleural por toracoscopia ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. Acerta o quilotórax, mas pula para o procedimento invasivo quando o líquido linfocítico já disponível pode mostrar a clonalidade.

C) Pseudoquilotórax / citometria de fluxo do líquido
Errada na classificação. Triglicerídeos de 420 com colesterol de 64 é quilotórax; a tuberculose foi do outro lado.

D) Quilotórax / citometria de fluxo do líquido CORRETA
Correta. Quilotórax (triglicerídeos acima de 110) com linfocitose, sintomas B e adenomegalias: citometria de fluxo do líquido para linfoma.

Para levar. Leitoso com triglicerídeos acima de 110 é quilotórax; colesterol acima de 200 com pleura espessa é pseudoquilotórax. Quilotórax não traumático com linfócitos pede citometria de fluxo antes da toracoscopia.

BTS Guideline for pleural disease 2023; Light RW, Pleural Diseases, 6ª ed. (2013)

---

34 Hepatologia · Hepatite B HBeAg negativo com HBV-DNA alto e ALT elevada: hepatite crônica, e não portador inativo

Grade X / Y **Gabarito D**

Homem de 46 anos tem HBsAg reagente conhecido há 15 anos, sempre com HBeAg não reagente e anti-HBe reagente, e nunca foi tratado. Assintomático, não usa álcool; exame normal. Nos últimos 12 meses: ALT de 92, 78 e 110 U/L (referência até 40 U/L); HBV-DNA 64.000 UI/mL; anti-HCV, anti-HDV e anti-HIV não reagentes; elastografia hepática 8,9 kPa; ultrassonografia sem nódulos; IMC 24 kg/m², sem esteatose. A fase da infecção e a conduta mais adequada são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE
HBV-DNA 64.000 UI/mL

Resolução. HBeAg não reagente com anti-HBe reagente parece portador inativo, e é o rótulo que a grade explora. A fase não se define pelo HBeAg, e sim pelo conjunto: com HBV-DNA de 64.000 UI/mL e ALT persistentemente elevada (2 a 3 vezes o limite), trata-se de hepatite crônica HBeAg negativo, em geral por variantes pré-core ou do promotor basal, que impedem a produção do HBeAg sem impedir a replicação. Nessa fase a doença progride, e o tratamento está indicado (HBV-DNA acima de 2.000 com ALT elevada),

com tenofovir ou entecavir por tempo prolongado. A elastografia de 8,9 kPa sugere fibrose significativa e reforça a indicação. Infecção crônica HBeAg negativo exige DNA abaixo de 2.000 e ALT normal.

A) Infecção crônica HBeAg negativo / seguimento sem antiviral ARMADILHA
Errada. É a isca: infecção crônica HBeAg negativo exige HBV-DNA abaixo de 2.000 UI/mL e ALT normal; aqui ambos estão altos.

B) Hepatite crônica HBeAg negativo / seguimento sem antiviral
Errada. Acerta a fase e erra a conduta: hepatite crônica HBeAg negativo com DNA e ALT altos progride e tem indicação de antiviral.

C) Infecção crônica HBeAg negativo / tenofovir
Errada. Erra a fase: se fosse infecção crônica, não haveria indicação de tenofovir.

D) Hepatite crônica HBeAg negativo / tenofovir CORRETA
Correta. HBeAg negativo com HBV-DNA de 64.000 UI/mL e ALT persistentemente alta: hepatite crônica HBeAg negativo, tratar com tenofovir.

Para levar. Anti-HBe reagente não significa inatividade: HBV-DNA acima de 2.000 com ALT elevada é hepatite crônica HBeAg negativo, e se trata.

PCDT para Hepatite B e Coinfecções (Ministério da Saúde, 2017); EASL Clinical Practice Guidelines on hepatitis B (2025); AASLD Hepatitis B Guidance (2018)

35

Nefrologia · Pielonefrite ambulatorial ainda febril em 40 horas · nenhum exame de imagem ou de controle antes de 72 horas

Cronologia **Gabarito D**

Mulher de 31 anos, sem comorbidades, com teste de gravidez negativo, foi diagnosticada com pielonefrite há 40 horas (febre de 39,5 °C, dor lombar direita e punho-percussão dolorosa) e está em uso de ciprofloxacino 500 mg de 12 em 12 horas por via oral, com urocultura colhida antes da primeira dose. Retorna hoje: teve pico febril de 38,3 °C pela manhã, menor que os anteriores, a dor lombar melhorou, aceita bem a dieta e não tem vômitos. Exame: PA 118/74 mmHg, FC 92 bpm, bom estado geral. Exames: creatinina 0,7 mg/dL, leucócitos 12.400/mm³ (eram 17.900). A urocultura mostrou Escherichia coli sensível ao ciprofloxacino, que será mantido. Quanto a exames complementares, o mais adequado neste momento é:

O DADO QUE DECIDE
há 40 horas

Resolução. Febre ainda presente no segundo dia leva o apressado à imagem para procurar abscesso ou obstrução, exatamente o que ele fez numa pielonefrite ambulatorial que 71% acertaram. Mas na pielonefrite a febre leva de 48 a 72 horas para ceder mesmo com antibiótico adequado, e o que indica imagem é a falta de melhora clínica após 48 a 72 horas, a piora, a sepse, a suspeita de obstrução (cálculo, anúria, cólica) ou a recorrência precoce. Com 40 horas, curva febril em queda, dor melhorando, tolerância oral, leucocitose caindo e E. coli sensível ao antibiótico em uso, o tratamento está funcionando. Culturas de controle também não acrescentam: o germe já está isolado e a urocultura após o tratamento não é indicada na mulher não gestante que melhora. A conduta é manter o ciprofloxacino (sete dias no total), sem exames adicionais, e reavaliar se a febre persistir além de 72 horas.

A) Hemoculturas e nova urocultura

Errada. Hemoculturas e nova urocultura caberiam na sepse ou na falha terapêutica; com germe isolado, sensível e evolução favorável, não mudam nada.

B) Tomografia de abdome com contraste ARMADILHA

Errada, é a armadilha. A tomografia seria o exame na febre que persiste após 72 horas, na piora clínica ou na suspeita de abscesso ou obstrução; com 40 horas e melhora, é exame a mais.

C) Ultrassonografia de vias urinárias

Errada. A ultrassonografia tem o mesmo critério de indicação (falta de resposta ou suspeita de obstrução) e não muda a conduta numa paciente que está melhorando.

D) Nenhum exame complementar agora CORRETA

Correta. Com 40 horas de tratamento, melhora clínica e germe sensível, febre residual é esperada: nenhum exame agora, reavaliar se persistir após 72 horas.

Para levar. Na pielonefrite, febre até 48 a 72 horas de antibiótico adequado é esperada; imagem só sem melhora após esse prazo, com piora ou com sinal de obstrução, e cultura de controle não se pede em quem melhora.

IDSA e ESCMID, tratamento de cistite e pielonefrite agudas não complicadas em mulheres (2011); EAU Guidelines on Urological Infections (2025); ACR Appropriateness Criteria, Acute Pyelonephritis (2022).

---

36 Endocrinologia · Hipercalemia após adrenalectomia por aldosteronoma: suspender o antagonista e liberar sal

Grade X / Y **Gabarito D**

Homem de 52 anos, com hiperaldosteronismo primário por adenoma esquerdo confirmado por cateterismo adrenal, usava espironolactona 100 mg/dia, anlodipino 10 mg/dia e cloreto de potássio 1,8 g/dia antes da adrenalectomia laparoscópica esquerda, há três semanas. Na alta, as três medicações foram mantidas até a consulta. Hoje: PA 122/76 mmHg, FC 74 bpm. Exames: sódio 134 mEq/L, potássio 6,1 mEq/L, creatinina 1,5 mg/dL (era 1,0 antes da cirurgia), aldosterona plasmática abaixo de 3 ng/dL, renina baixa. ECG com ondas T apiculadas, sem alargamento de QRS. Além de suspender o cloreto de potássio e tratar a hipercalemia, quanto à espironolactona e à ingestão de sal, a conduta é, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

aldosterona plasmática abaixo de 3 ng/dL

Resolução. O paciente foi tratado anos para excesso de aldosterona, e a inércia é continuar: manter a espironolactona e a restrição de sal, a dieta do hipertenso. Retirada a fonte, o estado se inverteu: a adrenal contralateral, suprimida por anos de renina baixa, demora semanas a meses para voltar, e há hipoaldosteronismo transitório, com aldosterona abaixo de 3 ng/dL, hipercalemia e sódio baixo. A creatinina que sobe é a TFG real desmascarada depois do fim da hiperfiltração do excesso mineralocorticoide. A conduta é suspender espironolactona e potássio já no pós-operatório e liberar o sal da dieta, que oferece sódio ao néfron distal e favorece a excreção de potássio; se a hipercalemia persistir, fludrocortisona temporária.

A) Manter / restrição de sal ARMADILHA

Errada. Erra nas duas metades: mantém o antagonista de um hormônio que já falta e restringe o sódio de que o néfron precisa para excretar potássio.

B) Manter / dieta liberal em sal

Errada. O sal liberado está certo, mas manter espironolactona com aldosterona abaixo de 3 ng/dL é tratar um excesso que não existe mais.

C) Suspender / restrição de sal

Errada. Suspender está certo, mas restringir sal agrava a hipercalemia e a hiponatremia neste momento.

D) Suspender / dieta liberal em sal CORRETA

Correta. Hipoaldosteronismo transitório pós-adrenalectomia: suspender espironolactona e potássio e liberar o sal.

Para levar. Depois da adrenalectomia por aldosteronoma, o problema vira falta de aldosterona: suspenda espironolactona e potássio, libere o sal e vigie o potássio; fludrocortisona se persistir.

Endocrine Society, Management of Primary Aldosteronism 2016 (Funder et al.); Primary Aldosteronism Surgical Outcome (PASO) consensus 2017.

---

37 Cardiologia · Endocardite com vegetação grande e AVC isquêmico: cirurgia urgente sem esperar 4 semanas

Cronologia **Gabarito A**

Homem de 52 anos, com prolapso mitral conhecido, está internado há 6 dias com endocardite por Staphylococcus aureus sensível à oxacilina em valva mitral nativa, em uso de oxacilina, com hemoculturas negativas desde o 3º dia. No 5º dia teve hemiparesia braquial direita que regrediu parcialmente; tomografia e ressonância mostram infarto cortical frontal de 2 cm, sem transformação hemorrágica. Glasgow 15. Ecocardiograma transesofágico de hoje: vegetação móvel de 16 mm no folheto anterior mitral, insuficiência mitral moderada, sem abscesso, FE 60%. Sem sinais de insuficiência cardíaca. A conduta mais adequada em relação à cirurgia é:

O DADO QUE DECIDE

infarto cortical frontal de 2 cm, sem transformação hemorrágica

Resolução. AVC na endocardite parece mandar adiar a cirurgia por medo da anticoagulação da circulação extracorpórea, e esperar 4 semanas é a armadilha. Esse adiamento vale para AVC hemorrágico ou para isquêmico extenso com coma; num infarto isquêmico pequeno, sem hemorragia, com Glasgow 15, a cirurgia indicada não deve ser adiada. E ela está indicada: vegetação de 10 mm ou mais que já embolizou apesar de antibiótico adequado é indicação de cirurgia urgente (em dias), porque o risco de nova embolia é maior nas duas primeiras semanas e cai depois. Esperar uma segunda embolia ou tratar só com antibiótico deixa uma vegetação de 16 mm, móvel, por S. aureus, no período de maior risco.

A) Cirurgia urgente, nos próximos dias CORRETA

Correta. Vegetação acima de 10 mm com embolia sob antibiótico indica cirurgia urgente, e AVC isquêmico pequeno sem hemorragia nem coma não a adia.

B) Cirurgia após 4 semanas do AVC ARMADILHA

Errada, e é a armadilha. Adiar 4 semanas é para AVC hemorrágico ou isquêmico extenso com dano neurológico grave.

C) Antibiótico por 6 semanas, sem cirurgia

Errada. Seria aceitável com vegetação pequena, sem embolia e sem complicação; aqui há indicação cirúrgica embólica.

D) Cirurgia só se houver nova embolia

Errada. A embolia que indica a cirurgia já aconteceu; esperar outra expõe ao maior risco, que está nas primeiras duas semanas.

Para levar. Endocardite com vegetação de 10 mm ou mais e embolia sob antibiótico: cirurgia urgente. AVC isquêmico sem hemorragia e sem coma não adia a cirurgia; AVC hemorrágico adia por cerca de 4 semanas.

ESC 2023 (endocarditis); AHA Scientific Statement 2015 (infective endocarditis in adults); Duke-ISCVID 2023

---

38 Infectologia · Espondilodiscite com bacteremia por S. aureus em boa evolução: sem biópsia vertebral e sem RM de controle

Grade X / Y **Gabarito D**

Homem de 63 anos, diabético, que tratou furunculose em coxa há 1 mês, procura atendimento por dor lombar progressiva há 3 semanas, pior à noite, e febre há 5 dias. Nega trauma. Exame: T 38,4 °C, dor à percussão de L3 e L4, força, sensibilidade e reflexos preservados nos membros inferiores, esfíncteres preservados. Hemoculturas: Staphylococcus aureus sensível à oxacilina em 2 de 2 amostras. Ecocardiograma transesofágico sem vegetações. RM de coluna lombar: espondilodiscite L3-L4 com edema dos corpos vertebrais adjacentes e pequeno flegmão paravertebral, sem abscesso epidural ou compressão neural. Iniciada oxacilina. Duas semanas depois, está afebril, com dor em melhora, hemoculturas de controle negativas e PCR caindo de 18 para 4 mg/dL. Quanto à biópsia vertebral e à RM de controle ao fim do tratamento, as indicações são, respectivamente:

> O DADO QUE DECIDE
>
> *está afebril, com dor em melhora, hemoculturas de controle negativas e PCR caindo de 18 para 4 mg/dL*

Resolução. Osteomielite vertebral pede, em regra, identificação do agente, e a biópsia guiada por imagem é o reflexo; ao fim do tratamento, a RM 'para ver se curou' parece prudente. A diretriz da IDSA dispensa as duas neste cenário. A biópsia existe para descobrir o agente, e ele já está no sangue: com hemocultura positiva para S. aureus (também S. lugdunensis ou Brucella) e imagem compatível, a biópsia não é recomendada. A RM de controle também não: as alterações de imagem persistem, e podem até parecer piores, por semanas apesar da cura, e a resposta se avalia pela clínica e pela PCR, como aqui (afebril, dor em melhora, PCR de 18 para 4 mg/dL). A RM se repete só com piora clínica, dor persistente, déficit novo ou PCR que não cai. O tratamento total é de 6 semanas, sem necessidade de estender para 12 na evolução favorável.

A) Indicada / indicada

Errada. Biópsia seria indicada com hemoculturas negativas, e RM de controle com piora clínica ou PCR que não cai; nenhum dos dois cenários está presente.

B) Indicada / dispensável
Errada. Acerta a RM, mas indica uma biópsia cujo único objetivo, identificar o agente, já foi cumprido pelas hemoculturas com S. aureus.

C) Dispensável / indicada ARMADILHA
Errada. É a armadilha: acerta a biópsia, mas pede RM de controle em paciente que melhora; a imagem demora a regredir e não guia a duração.

D) Dispensável / dispensável CORRETA
Correta. S. aureus na hemocultura dispensa biópsia, e a boa evolução clínica e da PCR dispensa RM de controle.

Para levar. Osteomielite vertebral com hemocultura positiva para S. aureus: sem biópsia; na boa evolução clínica e da PCR, sem RM de controle; 6 semanas de antibiótico.

IDSA Clinical Practice Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Native Vertebral Osteomyelitis in Adults (2015); Bernard L et al., 6 versus 12 semanas de antibiótico na osteomielite vertebral (Lancet, 2015).

39

Hematologia · Macrocitose pela hidroxiureia na doença falciforme: sinal de adesão, não de carência

Droga a deduzir **Gabarito B**

Mulher de 27 anos, com anemia falciforme (HbSS), é acompanhada no hemocentro. Há 1 ano, após três internações por crise vaso-oclusiva e uma síndrome torácica aguda, passou a tomar "uma cápsula diária que reduz as crises", com redução importante das dores. Usa também ácido fólico. É vegetariana estrita há 5 anos, sem suplementos. Assintomática. Exames: Hb 9,4 g/dL (basal anterior de 7,8), VCM 118 fL (era 88), reticulócitos 4% (eram 12%), leucócitos 5.800/mm³, neutrófilos 3.100/mm³, plaquetas 260.000/mm³, LDH 380 U/L (era 790) e hemoglobina fetal de 22% (era 6%). A explicação mais provável para a elevação do VCM é:

O DADO QUE DECIDE
hemoglobina fetal de 22% (era 6%)

Resolução. A droga não foi nomeada, mas uma cápsula diária que reduz crises na anemia falciforme, iniciada após síndrome torácica aguda, é a hidroxiureia. O rótulo verdadeiro é a dieta vegetariana estrita sem suplementação, que puxa para carência de B12. Os números contam outra história: a carência de B12 pioraria a anemia, aumentaria a LDH pela eritropoese ineficaz e poderia baixar neutrófilos e plaquetas, e aqui a Hb subiu, a LDH caiu pela metade e os reticulócitos caíram porque a hemólise diminuiu. A hidroxiureia induz hemoglobina fetal (de 6% para 22%) e macrocitose por inibir a ribonucleotídeo redutase, e o VCM subindo junto com a HbF é o marcador de adesão e de efeito. Não há o que tratar; dosar B12 numa vegetariana é razoável no seguimento, mas não é a explicação do quadro.

A) Deficiência de vitamina B12 pela dieta ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a dieta é verdadeira, mas a carência de B12 pioraria a anemia e elevaria a LDH, e aqui a Hb subiu e a LDH caiu.

B) Efeito esperado da hidroxiureia CORRETA
Correta. Hidroxiureia (droga a deduzir) eleva HbF e VCM e reduz hemólise: VCM alto com Hb melhor e HbF de 22% é efeito esperado e sinal de adesão.

C) Síndrome mielodisplásica secundária
Errada. SMD secundária daria citopenias e displasia, não melhora da Hb com redução da hemólise.

D) Deficiência de folato por hemólise
Errada. Ela usa ácido fólico, e a hemólise diminuiu; carência de folato pioraria a anemia.

Para levar. Hidroxiureia eleva a HbF e o VCM e reduz reticulócitos e LDH: macrocitose com Hb melhor e HbF alta é adesão ao tratamento, não carência.

ASH 2020 guidelines for sickle cell disease; NHLBI 2014 Evidence-Based Management of Sickle Cell Disease; PCDT Doença Falciforme, Ministério da Saúde (2018).

40

Hepatologia · Nódulo hepático em homem usuário de anabolizante: adenoma pela fase hepatobiliar e ressecção independentemente do tamanho

Limiar **Gabarito D**

Homem de 29 anos, fisiculturista, usa estanozolol e oxandrolona há 4 anos. Ultrassonografia feita por dor abdominal vaga mostrou nódulo hepático. RM com contraste hepatoespecífico: lesão única de 3,6 cm no segmento VI, com realce arterial, hipointensa na fase hepatobiliar, com áreas de gordura intralesional e sem cicatriz central; fígado sem sinais de hepatopatia crônica e sem sangramento. Alfafetoproteína 2 ng/mL; sorologias para hepatites B e C negativas. Exame físico normal. O diagnóstico mais provável e a conduta, além de suspender os anabolizantes, são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

Homem de 29 anos

Resolução. Jovem com nódulo hipervascular e fígado normal lembra hiperplasia nodular focal, e quem reconhece o adenoma lembra a regra dos 5 cm. A fase hepatobiliar separa as duas: a hiperplasia nodular focal tem hepatócitos funcionantes e capta o contraste hepatoespecífico (iso ou hiperintensa), enquanto o adenoma fica hipointenso; a gordura intralesional e a ausência de cicatriz central reforçam adenoma. A regra de observar adenoma menor que 5 cm após suspender o hormônio vale para mulheres. Em homens, o risco de transformação maligna é bem maior (cerca de 10 vezes), com frequência por mutação ativadora da beta-catenina, que os anabolizantes favorecem; por isso a recomendação é ressecção em qualquer tamanho. Suspender os anabolizantes é obrigatório, mas não substitui a cirurgia, e a biópsia não mudaria a conduta no homem.

A) Hiperplasia nodular focal / RM em 6 meses
Errada. A hiperplasia nodular focal capta o contraste hepatoespecífico e costuma ter cicatriz central; e, mesmo se fosse ela, não exigiria imagem seriada.

B) Hiperplasia nodular focal / ressecção
Errada nas duas metades: a fase hepatobiliar hipointensa afasta hiperplasia nodular focal, que, quando confirmada, não se resseca.

C) Adenoma hepatocelular / RM em 6 meses ARMADILHA
Errada. É a isca: acerta o diagnóstico e aplica a regra da mulher (observar abaixo de 5 cm após suspender o hormônio); no homem, o risco de malignização manda ressecar.

D) Adenoma hepatocelular / ressecção CORRETA

Correta. Hipointensa na fase hepatobiliar, com gordura e sem cicatriz: adenoma; em homem, de qualquer tamanho, ressecção, além de suspender os anabolizantes.

Para levar. Na RM com contraste hepatoespecífico, hiperplasia nodular focal capta e adenoma não; adenoma na mulher com menos de 5 cm se observa após suspender o estrogênio, no homem se resseca sempre.

EASL Clinical Practice Guidelines on the management of benign liver tumours (2016); ACG Clinical Guideline: Diagnosis and Management of Focal Liver Lesions (2014)

---

41 Reumatologia · Artrite reumatoide antiga com formigamento nas mãos: mielopatia por subluxação atlantoaxial, e não túnel do carpo

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Mulher de 63 anos tem artrite reumatoide soropositiva há 19 anos, erosiva, com deformidades em mãos, em uso de leflunomida 20 mg/dia e prednisona 5 mg/dia. Há 4 meses refere formigamento nas mãos, pior à noite, dor occipital e sensação de choque que desce pela coluna ao fletir o pescoço; nas últimas semanas deixa cair objetos e tropeça com frequência. Aguarda artroplastia de quadril sob anestesia geral. Exame físico: sinovite discreta em punhos, sinal de Tinel positivo nos dois punhos, força grau 4 em mãos, reflexos bicipitais e patelares vivos, sinal de Hoffmann positivo bilateralmente, reflexo cutaneoplantar em extensão à direita, sensibilidade vibratória reduzida nos pés. Exames: VHS 42 mm/h, PCR 1,8 mg/dL, glicemia, vitamina B12 e TSH normais. O diagnóstico que explica o quadro neurológico é:

O DADO QUE DECIDE

sinal de Hoffmann positivo bilateralmente, reflexo cutaneoplantar em extensão à direita

Resolução. Formigamento noturno nas mãos com Tinel positivo nos punhos de quem tem artrite reumatoide é túnel do carpo para quase todo mundo, e a sinovite do punho torna isso em parte verdadeiro. Mas o túnel do carpo não explica sinais de neurônio motor superior: reflexos vivos, Hoffmann bilateral e Babinski, além de dor occipital, sinal de Lhermitte e alteração da marcha. Na artrite reumatoide erosiva de longa data, a sinovite atlantoaxial destrói o ligamento transverso e o processo odontoide, e a subluxação comprime a medula cervical alta. A confirmação é por radiografia cervical em flexão e extensão e ressonância magnética, e a mielopatia indica avaliação neurocirúrgica para fixação. O diagnóstico muda a cirurgia programada: a intubação com hiperextensão cervical pode provocar lesão medular, e a via aérea precisa ser manejada com a coluna protegida.

A) Mononeurite múltipla por vasculite

Errada. A vasculite reumatoide causa déficits assimétricos em territórios de nervos, com reflexos diminuídos; aqui os reflexos estão vivos e há Babinski.

B) Mielopatia por subluxação atlantoaxial CORRETA

Correta. Artrite reumatoide erosiva de longa data com dor occipital, Lhermitte e sinais de neurônio motor superior nos quatro membros: mielopatia cervical alta.

C) Polineuropatia pela leflunomida

Errada. A neuropatia pela leflunomida é sensitiva distal, com reflexos diminuídos; não explica Hoffmann nem Babinski.

D) Síndrome do túnel do carpo bilateral ARMADILHA

Errada. Explica formigamento noturno e Tinel, e pode coexistir, mas não causa reflexos vivos, Hoffmann, Babinski, Lhermitte e alteração da marcha.

Para levar. Na artrite reumatoide de longa data, formigamento nas mãos com reflexos vivos, Hoffmann ou Lhermitte é mielopatia por instabilidade atlantoaxial: imagem cervical antes de qualquer intubação.

Kelley & Firestein's Textbook of Rheumatology, 11ª ed. (2021); Harrison's Principles of Internal Medicine, 21ª ed. (2022).

---

42 Pneumologia · Espirometria: obstrução reversível em tabagista não é DPOC

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Homem de 52 anos, tabagista ativo (35 maços-ano), tem tosse e chiado há 2 anos, com piora no inverno e ao sentir cheiro de tinta, e despertares noturnos por falta de ar. Refere rinite desde a juventude. Exame: sibilos expiratórios esparsos, SpO2 96% em ar ambiente. Eosinófilos 410/mm³. Espirometria: antes do broncodilatador, VEF1/CVF 0,65, VEF1 2,20 L (64% do previsto) e CVF 3,40 L; após salbutamol, VEF1/CVF 0,75, VEF1 2,80 L (81% do previsto) e CVF 3,74 L. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

após salbutamol, VEF1/CVF 0,75

Resolução. Tabagista de 35 maços-ano com tosse e chiado leva ao diagnóstico de DPOC quase por reflexo, e a resposta ao broncodilatador parece só um detalhe, já que a DPOC também pode responder. Mas o GOLD exige relação VEF1/CVF abaixo de 0,70 após o broncodilatador, e ela foi para 0,75: não há limitação persistente ao fluxo aéreo, e sem isso não há DPOC nem sobreposição. A obstrução é variável e reverte (VEF1 subiu 600 mL, cerca de 17% do previsto, acima do limiar de 10% da ATS/ERS 2022), com sintomas noturnos, gatilhos, rinite e eosinófilos de 410: asma. O tabagismo segue sendo o problema a tratar, e a espirometria deve ser repetida no seguimento, mas hoje o diagnóstico é asma e o tratamento começa com corticoide inalatório.

A) DPOC com resposta ao broncodilatador ARMADILHA

Errada, e é a armadilha. DPOC pode ter resposta ao broncodilatador, mas exige relação abaixo de 0,70 após ele; 0,75 afasta.

B) Asma em tabagista ativo CORRETA

Correta. Obstrução que normaliza após broncodilatador (relação 0,75, VEF1 81%), com sintomas noturnos, gatilhos e eosinofilia: asma.

C) Sobreposição de asma e DPOC

Errada. Sobreposição exige obstrução persistente após broncodilatador com traços de asma; a obstrução aqui não persiste.

D) Relação preservada com VEF1 reduzido

Errada. Relação preservada com VEF1 reduzido exige VEF1 pós-broncodilatador abaixo de 80%; foi de 81%.

Para levar. DPOC exige VEF1/CVF abaixo de 0,70 depois do broncodilatador; obstrução que normaliza é asma, mesmo no tabagista.

GOLD 2025; GINA 2024; ATS/ERS 2022 (interpretação de testes de função pulmonar)

---

43 Nefrologia · Síndrome nefrótica na artrite reumatoide de longa data em uso recente de naproxeno · amiloidose AA

Rótulo verdadeiro **Gabarito D**

Mulher de 61 anos, com artrite reumatoide soropositiva há 22 anos, de controle irregular (PCR persistentemente entre 30 e 60 mg/L), em uso de prednisona 5 mg/dia. Proteinúria de 1,2 g/24 h detectada há dois anos, sem seguimento. Há dois meses começou naproxeno por piora das dores e, há quatro semanas, tem edema progressivo. Exame: PA 118/72 mmHg, edema 3+, fígado a 4 cm do rebordo costal, sem macroglossia, sem púrpura periorbitária. Exames: albumina 2,1 g/dL, proteinúria de 24 h de 7,2 g, creatinina 1,4 mg/dL, urina sem hematúria e sem leucocitúria; eletroforese e imunofixação séricas sem componente monoclonal; relação kappa/lambda das cadeias leves livres de 1,3. Ultrassonografia: rins de 13,5 cm. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

Proteinúria de 1,2 g/24 h detectada há dois anos

Resolução. Síndrome nefrótica que se instala semanas após começar naproxeno parece lesão mínima por AINE (ou membranosa), e o rótulo da droga é verdadeiro. Mas a proteinúria já existia dois anos antes do anti-inflamatório: o AINE pode ter piorado o quadro, não o iniciou. Há artrite reumatoide de 22 anos com inflamação persistente (PCR entre 30 e 60), síndrome nefrótica com sedimento brando, rins grandes (13,5 cm, quando a DRC costuma encolhê-los) e hepatomegalia: é a amiloidose secundária, AA, formada a partir da proteína amiloide A sérica produzida pela inflamação crônica. A AL fica muito improvável sem componente monoclonal na imunofixação e com relação kappa/lambda normal, e faltam macroglossia e púrpura periorbitária. Confirma-se com vermelho Congo (gordura abdominal ou rim) e tipagem, e o tratamento é controlar a inflamação (biológico, com boa resposta ao anti-IL-6), não quimioterapia.

A) Nefropatia membranosa por AINE
Errada. A membranosa por AINE também começaria depois da droga e não explica rins grandes e hepatomegalia.

B) Amiloidose AL
Errada. A AL exige clone plasmocitário: imunofixação negativa e relação kappa/lambda normal tornam o diagnóstico muito improvável.

C) Lesão mínima por AINE ARMADILHA
Errada, é a armadilha. A lesão mínima por AINE começa semanas após a droga num rim antes normal; aqui a proteinúria precede o naproxeno em dois anos, e não há leucocitúria de nefrite intersticial.

D) Amiloidose AA CORRETA
Correta. Inflamação crônica de décadas, nefrótica com sedimento brando, rins aumentados e hepatomegalia, sem clone: amiloidose AA.

Para levar. Síndrome nefrótica com sedimento brando e rins grandes em doença inflamatória crônica mal controlada é amiloidose AA até prova em contrário; a cronologia da proteinúria tira o AINE recente do papel de causa.

Lachmann et al., NEJM 2007 (Natural history and outcome in systemic AA amyloidosis); KDIGO 2021 (Glomerular Diseases); Harrison 21ª ed. (Amyloidosis).

---

44 Neurologia · Síndrome do um e meio no idoso diabético: paralisia do olhar conjugado mais OIN do mesmo lado

Rótulo verdadeiro **Gabarito D**

Homem de 73 anos, diabético e hipertenso, nota visão dupla súbita ao acordar. Exame: no olhar para a esquerda, nenhum dos dois olhos ultrapassa a linha média; no olhar para a direita, o olho direito abduz com nistagmo e o olho esquerdo não ultrapassa a linha média. Convergência preservada, com adução de ambos os olhos. Pupilas isocóricas e fotorreagentes, sem ptose, força e sensibilidade normais nos membros. Glicemia 212 mg/dL, HbA1c 9,4%. A topografia mais provável da lesão é:

O DADO QUE DECIDE

no olhar para a esquerda, nenhum dos dois olhos ultrapassa a linha média

Resolução. Diabetes descompensado e diplopia súbita no idoso puxam para mononeuropatia isquêmica do VI, e esse é o rótulo verdadeiro. Mas a lesão do VI nervo tira só a abdução do olho do mesmo lado; aqui, no olhar para a esquerda, nenhum dos olhos se move, isto é, há paralisia do olhar conjugado para a esquerda, que é lesão do núcleo do VI ou da FRPP esquerda (o núcleo do VI contém os interneurônios que cruzam para o III contralateral). No olhar para a direita, o olho esquerdo não aduz e o direito abduz com nistagmo: é oftalmoplegia internuclear esquerda, lesão do FLM esquerdo, do lado do olho que não aduz. Paralisia do olhar para um lado mais OIN do mesmo lado é a síndrome do um e meio, com lesão pontina dorsal paramediana unilateral, e a única movimentação horizontal que resta é a abdução do olho contralateral. No idoso vascular, a causa é em geral infarto lacunar pontino; a convergência preservada confirma que o III nervo e o reto medial estão íntegros.

A) Nervo abducente esquerdo ARMADILHA
Errada, é a armadilha. A paralisia do VI esquerdo só impediria a abdução do olho esquerdo; o olho direito aduziria no olhar para a esquerda.

B) Ponte direita: núcleo do VI e FLM
Errada. A lesão pontina direita produziria o quadro em espelho: olhar para a direita paralisado e OIN direita.

C) FLM esquerdo isolado
Errada. O FLM esquerdo isolado explica só a adução falha do olho esquerdo; não explica a paralisia do olhar conjugado para a esquerda.

D) Ponte esquerda: núcleo do VI e FLM CORRETA
Correta. Paralisia do olhar para a esquerda (núcleo do VI ou FRPP esquerda) mais OIN esquerda (FLM esquerdo): síndrome do um e meio por lesão pontina esquerda.

Para levar. Um olho que não aduz é FLM do mesmo lado; os dois olhos que não vão para um lado é núcleo do VI ou FRPP daquele lado. Os dois juntos são o um e meio, na ponte do lado da paralisia do olhar.

Walsh and Hoyt Clinical Neuro-Ophthalmology, 7ª ed.; Harrison 22ª ed., cap. Neuro-Ophthalmology.

---

45 Endocrinologia · Coma mixedematoso sem exames de tireoide: hidrocortisona antes da levotiroxina

Dado omitido **Gabarito C**

Mulher de 74 anos é trazida pela filha, em julho, por sonolência progressiva há uma semana, após pneumonia tratada em casa. Há 18 anos fez tratamento com iodo radioativo para tireoide acelerada e perdeu o seguimento; não toma remédios regularmente. Exame: Glasgow 9, temperatura axilar 34,2 °C, FC 48 bpm, PA 92/58 mmHg, FR 10 irpm, face infiltrada, macroglossia, pele seca e fria, edema não depressível em pernas, relaxamento lento do reflexo aquileu. Exames: sódio 121 mEq/L, glicemia 62 mg/dL, pH 7,28, pCO2 62 mmHg, CPK 1.480 U/L, creatinina 1,4 mg/dL. Os exames de tireoide foram colhidos e o resultado sai amanhã. A conduta medicamentosa mais adequada agora é:

O DADO QUE DECIDE

Há 18 anos fez tratamento com iodo radioativo para tireoide acelerada e perdeu o seguimento

Resolução. Falta o exame que todos esperam ver (TSH e T4 livre), e o reflexo de confirmar antes de tratar atrasa uma emergência com mortalidade de 25 a 50%. O diagnóstico se faz pelo que o caso dá: iodo radioativo sem seguimento, hipotermia, bradicardia, hipoventilação com hipercapnia, hiponatremia, hipoglicemia, CPK alta e mixedema, precipitados por infecção no inverno. O tratamento começa agora e tem ordem: hidrocortisona em dose de estresse (100 mg venosa a cada 8 horas) antes ou junto com a levotiroxina venosa (ataque de 200 a 400 µg), porque pode haver insuficiência adrenal coexistente, e o hormônio tireoidiano aumenta o consumo de cortisol e precipita crise adrenal. A hipoglicemia e a hipotensão reforçam a suspeita. Via oral é inadequada pela absorção intestinal comprometida.

A) Aguardar TSH e T4 livre para tratar
Errada. Seria aceitável em hipotireoidismo sem descompensação; no coma mixedematoso, esperar o laboratório aumenta a mortalidade.

B) Levotiroxina venosa isolada em ataque ARMADILHA
Errada. A levotiroxina está certa, mas sem hidrocortisona prévia arrisca precipitar crise adrenal numa paciente hipotensa e hipoglicêmica.

C) Hidrocortisona e levotiroxina venosas CORRETA
Correta. Hidrocortisona em dose de estresse e levotiroxina venosa em ataque, nessa ordem, sem esperar o resultado.

D) Levotiroxina oral plena, sem corticoide
Errada. Absorção intestinal reduzida no mixedema e falta de cobertura adrenal tornam a via oral sem corticoide inadequada.

Para levar. Coma mixedematoso é diagnóstico clínico: trate antes do TSH, com hidrocortisona primeiro e levotiroxina venosa em seguida.

ATA Guidelines for the Treatment of Hypothyroidism 2014; Diretriz SBEM de hipotireoidismo 2013.

---

46 Infectologia · Bacteremia por E. coli ESBL sensível a piperacilina-tazobactam no antibiograma

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Mulher de 66 anos, diabética, internada há 5 dias por abscesso hepático piogênico de 6 cm, drenado por via percutânea no 1º dia, com choque séptico já resolvido. Iniciou ceftriaxona e metronidazol na admissão, trocados no 2º dia por piperacilina-tazobactam, quando hemoculturas e cultura do abscesso mostraram Escherichia coli produtora de betalactamase de espectro estendido (ESBL), sensível a piperacilina-tazobactam (CIM 4 mg/L), ertapenem, meropenem e amicacina, e resistente a ceftriaxona, cefepima e ciprofloxacino. Sorologia para ameba negativa. Está afebril há 48 horas, sem vasopressor, com hemocultura de controle negativa e dreno com débito em queda. Creatinina 1,1 mg/dL, albumina 3,4 g/dL. Em relação ao antimicrobiano, a conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

Escherichia coli produtora de betalactamase de espectro estendido (ESBL)

Resolução. O antibiograma diz sensível e a paciente melhorou: a regra de não trocar o que funciona puxa para manter a piperacilina-tazobactam. Mas, para ESBL fora do trato urinário, o resultado in vitro engana: a enzima é produzida em grande quantidade no foco (efeito de inóculo), e no ensaio MERINO a piperacilina-tazobactam teve mortalidade maior que o meropenem na bacteremia por E. coli e Klebsiella resistentes à ceftriaxona. Por isso a IDSA não recomenda piperacilina-tazobactam nessas infecções, mesmo com sensibilidade, e indica carbapenêmico. Com a paciente estável, sem choque e com albumina razoável, o ertapenem (uma dose diária, espectro mais estreito) é a escolha, com meropenem reservado ao doente crítico. Ciprofloxacino é resistente, e amicacina não deve ser base de tratamento de bacteremia com foco abdominal.

A) Manter piperacilina-tazobactam até o fim ARMADILHA
Errada. É a armadilha: o laudo sensível e a melhora tranquilizam, mas para ESBL fora do trato urinário a piperacilina-tazobactam teve pior desfecho (MERINO) e não é recomendada.

B) Trocar para ertapenem CORRETA
Correta. ESBL em bacteremia de foco abdominal pede carbapenêmico; estável, o ertapenem basta.

C) Trocar para ciprofloxacino oral
Errada. Quinolona oral seria opção de descalonamento se a cepa fosse sensível; ela é resistente ao ciprofloxacino.

D) Associar amicacina ao esquema atual
Errada. Associar aminoglicosídeo aumenta nefrotoxicidade e não corrige a falha do betalactâmico inadequado; não é base para bacteremia.

Para levar. E. coli ou Klebsiella ESBL fora do trato urinário: carbapenêmico mesmo com piperacilina-tazobactam sensível no antibiograma; ertapenem no paciente estável.

IDSA Guidance on the Treatment of Antimicrobial-Resistant Gram-Negative Infections (2024); Harris PNA et al., ensaio MERINO (JAMA, 2018).

47

Cardiologia · Dor torácica rotulada de ansiedade: angina com três critérios pede teste para DAC

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Mulher de 62 anos, com transtorno de ansiedade generalizada em uso de sertralina, hipertensa e ex-tabagista, refere há 2 meses dor em aperto retroesternal ao subir a ladeira de casa ou carregar compras, que cede em 3 a 5 minutos de repouso. Diz que a dor piora quando está nervosa e foi liberada duas vezes da emergência com diagnóstico de crise de ansiedade, com ECG e troponina normais nas duas vezes. Exame normal, PA 134×82 mmHg. ECG de repouso normal e ecocardiograma normal. O próximo exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

ao subir a ladeira de casa ou carregar compras, que cede em 3 a 5 minutos de repouso

Resolução. O transtorno de ansiedade é verdadeiro, e duas altas da emergência com esse rótulo e com ECG e troponina normais compõem a narrativa que a banca quer que ele compre, como já comprou antes. A dor tem os três critérios de angina definida: retroesternal em aperto, desencadeada por esforço e aliviada com repouso em minutos; o fato de piorar com emoção não a descaracteriza, porque estresse aumenta o consumo de oxigênio. Mulher de 62 anos, hipertensa e ex-tabagista, com angina definida, tem probabilidade pré-teste intermediária, e ECG, troponina e ecocardiograma de repouso normais não excluem doença coronária estável. O próximo passo é um teste não invasivo (anatômico, como a angiotomografia, ou funcional com imagem). O cateterismo direto seria o degrau a mais, reservado para alta probabilidade, angina refratária ou teste de alto risco.

A) Nenhum; ajustar o tratamento da ansiedade ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. Aceita o rótulo de ansiedade diante de uma angina com os três critérios; ECG, troponina e eco de repouso normais não afastam doença estável.

B) Teste não invasivo para doença coronária CORRETA
Correta. Angina definida com probabilidade intermediária: teste não invasivo, anatômico ou funcional, para confirmar e estratificar.

C) Cineangiocoronariografia
Errada. Cateterismo direto é para probabilidade muito alta, sintomas refratários ou teste não invasivo de alto risco; aqui é o degrau a mais.

D) Holter de 24 horas
Errada. O Holter investiga arritmia e palpitação; não diagnostica angina de esforço.

Para levar. Angina com os três critérios (retroesternal, desencadeada por esforço ou emoção, aliviada por repouso ou nitrato) em quem tem fatores de risco merece teste para DAC, mesmo com ansiedade diagnosticada e ECG, troponina e eco de repouso normais.

ESC 2024 (chronic coronary syndromes); AHA/ACC 2021 (chest pain); Diretriz de Doença Coronária Estável da SBC (2014)

---

48 Gastroenterologia · Vigilância após 1 a 2 adenomas tubulares menores que 10 mm: 7 a 10 anos

Rótulo verdadeiro **Gabarito D**

Homem de 56 anos, sem antecedente familiar de câncer colorretal, faz a primeira colonoscopia de rastreamento, com preparo adequado e exame completo até o ceco. Foram ressecados por completo dois pólipos de 5 e 7 mm, cujo histopatológico mostrou adenomas tubulares com displasia de baixo grau. O intervalo até a próxima colonoscopia é:

O DADO QUE DECIDE

dois pólipos de 5 e 7 mm

Resolução. A palavra adenoma basta para muitos marcarem vigilância curta, de 3 anos, e é o rótulo que a questão usa. O intervalo depende de número, tamanho e histologia: 1 a 2 adenomas tubulares menores que 10 mm, ressecados por completo em colonoscopia de qualidade, têm risco de neoplasia avançada próximo ao de quem teve colonoscopia normal, e a vigilância é de 7 a 10 anos. Três anos é para 5 a 10 adenomas, adenoma de 10 mm ou mais, componente viloso, displasia de alto grau ou lesão serrilhada de 10 mm ou mais. Intervalos de 6 meses ou 1 ano são para ressecção fragmentada de lesão grande ou mais de 10 adenomas.

A) 6 meses

Errada. Seis meses é o controle da ressecção fragmentada de lesão de 20 mm ou mais, para checar recidiva no leito.

B) 1 ano

Errada. Um ano se reserva a mais de 10 adenomas ou à suspeita de síndrome hereditária, e não a dois adenomas pequenos.

C) 3 anos ARMADILHA

Errada. É a isca: 3 anos é para adenoma avançado (10 mm ou mais, viloso ou displasia de alto grau) ou para 5 a 10 adenomas.

D) 7 a 10 anos CORRETA

Correta. Dois adenomas tubulares menores que 10 mm, com displasia de baixo grau e exame de qualidade: nova colonoscopia em 7 a 10 anos.

Para levar. Vigilância pós-polipectomia: 1 a 2 adenomas tubulares pequenos, 7 a 10 anos; adenoma avançado ou 5 a 10 adenomas, 3 anos.

US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer: Recommendations for Follow-Up After Colonoscopy and Polypectomy (2020)

---

49 Hematologia · Mieloma pelos critérios SLiM: razão de cadeias leves acima de 100 em assintomático

Limiar **Gabarito B**

Homem de 62 anos, assintomático, é encaminhado por pico monoclonal achado em exame de rotina. Sem dor óssea e sem infecções de repetição. Exames: Hb 13,6 g/dL, creatinina 0,9 mg/dL, cálcio 9,6 mg/dL, pico monoclonal IgA lambda de 2,1 g/dL, cadeia leve livre lambda de 1.480 mg/L e kappa de 9 mg/L (razão envolvida/não envolvida 164), medula óssea com 22% de plasmócitos clonais. Ressonância de corpo inteiro sem lesões focais e tomografia de baixa dose sem lesões líticas. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

razão envolvida/não envolvida 164

Resolução. Sem anemia, hipercalcemia, lesão renal ou lesão óssea, ele não tem CRAB, e o apressado classifica como mieloma latente. Com plasmócitos de 22%, pico de 2,1 g/dL e razão de cadeias leves acima de 20, seria latente de alto risco (critério 20/2/20), e o daratumumabe, que reduziu progressão nesse grupo, viraria a finalista. O limiar que decide vem antes: desde 2014 o IMWG define mieloma ativo também pelos biomarcadores SLiM, que preveem progressão de cerca de 80% em 2 anos: plasmócitos clonais de 60% ou mais, razão de cadeias leves envolvida/não envolvida de 100 ou mais (com a envolvida de pelo menos 100 mg/L) ou mais de uma lesão focal na ressonância. Razão de 164 com lambda de 1.480 mg/L é mieloma múltiplo, e o tratamento é o do mieloma, não observação nem prevenção.

A) Observação com reavaliação trimestral
Errada. Observação seria para mieloma latente de baixo risco; a razão de 164 já define mieloma ativo.

B) Tratamento do mieloma múltiplo CORRETA
Correta. Razão de cadeias leves envolvida/não envolvida de 100 ou mais é critério SLiM: mieloma ativo mesmo sem CRAB, com indicação de tratamento.

C) Bifosfonato isolado
Errada. Bifosfonato isolado não trata o clone e não se indica como terapia do mieloma latente ou ativo.

D) Daratumumabe para mieloma latente ARMADILHA
Errada. É a armadilha: o daratumumabe para latente de alto risco pressupõe que não há critério SLiM; aqui o limiar de 100 foi cruzado.

Para levar. SLiM-CRAB: plasmócitos de 60% ou mais, razão de cadeias leves de 100 ou mais ou mais de uma lesão focal na ressonância definem mieloma ativo, mesmo sem CRAB.

IMWG 2014 updated criteria (Rajkumar et al., Lancet Oncol 2014); modelo 20/2/20 de risco do mieloma latente (Mayo/IMWG, 2020); NCCN Multiple Myeloma 2025.

---

50 Reumatologia · Espondilite anquilosante com doença desmielinizante a deduzir: inibidor de IL-17 e não anti-TNF

Droga a deduzir **Gabarito A**

Mulher de 33 anos tem espondilite anquilosante com sacroiliíte bilateral na ressonância e HLA-B27 reagente, com dor lombar inflamatória, BASDAI 6,4 e PCR 3,1 mg/dL, apesar do uso sequencial, em dose plena, de naproxeno e de celecoxibe por 4 semanas cada. Não tem artrite periférica, psoríase, uveíte ou sintomas

intestinais, e a calprotectina fecal é normal. Acompanha na neurologia por dois surtos prévios (neurite óptica à esquerda e síndrome sensitiva medular), com lesões periventriculares e justacorticais na ressonância, e está em uso de teriflunomida, estável. O tratamento mais adequado para a espondilite é:

O DADO QUE DECIDE

está em uso de teriflunomida

Resolução. Falha de dois AINEs em dose plena com doença ativa indica biológico, e o anti-TNF é o primeiro que vem à cabeça. A doença neurológica não foi nomeada, mas dois surtos em locais distintos com lesões periventriculares e justacorticais, tratados com teriflunomida, são esclerose múltipla. Os inibidores de TNF são contraindicados na doença desmielinizante, porque podem desencadeá-la ou agravá-la. O inibidor de IL-17 (secuquinumabe ou ixequizumabe) é eficaz na doença axial e não tem esse problema; ele seria evitado com doença inflamatória intestinal ativa, que a calprotectina normal e a ausência de sintomas afastam. A sulfassalazina não age no esqueleto axial, e o corticoide sistêmico não é recomendado na espondiloartrite axial.

A) Secuquinumabe CORRETA
Correta. Doença axial ativa após dois AINEs, com esclerose múltipla e sem doença intestinal: inibidor de IL-17.

B) Adalimumabe ARMADILHA
Errada. Seria a escolha na espondilite com uveíte recorrente ou doença intestinal, mas é contraindicado na doença desmielinizante deduzida pela teriflunomida.

C) Sulfassalazina
Errada. Só tem papel na artrite periférica; sem sinovite periférica, não age na coluna.

D) Prednisona 10 mg/dia contínua
Errada. Corticoide sistêmico não é recomendado na doença axial e não muda o curso.

Para levar. Na espondiloartrite axial, doença desmielinizante afasta o anti-TNF e favorece o inibidor de IL-17; doença intestinal faz o oposto (anti-TNF monoclonal, nunca IL-17).

ASAS-EULAR 2022 recommendations for axial spondyloarthritis; SBR 2019 recomendações para espondilite anquilosante; bulas dos inibidores de TNF (doença desmielinizante).

---

51 Emergência · Golpe de calor por esforço em usuário de haloperidol

Negativo no meio | Gabarito A

Homem de 27 anos, com esquizofrenia estável em uso de haloperidol na mesma dose há 3 anos, corria uma prova de 10 km às 11 horas, com temperatura ambiente de 34 °C, quando caiu no 9º km. Chega à tenda médica 10 minutos depois, agitado e desorientado. Temperatura retal 41,4 °C, FC 138 bpm, PA 104 × 60 mmHg, FR 30 irpm, pele quente e úmida. Pupilas isocóricas, tônus muscular normal, sem rigidez, sem clônus e reflexos simétricos, sem rigidez de nuca. Glicemia 96 mg/dL, sódio 136 mEq/L, CK 2.400 U/L. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

tônus muscular normal, sem rigidez, sem clônus

Resolução. Antipsicótico com febre de 41 °C, confusão e CK alta lembra síndrome neuroléptica maligna, e o haloperidol é verdadeiro. Mas a síndrome neuroléptica se instala ao longo de dias, em geral após início ou aumento de dose, e tem rigidez em cano de chumbo como achado central; aqui a dose é estável há 3 anos, o início foi abrupto durante esforço intenso no calor e o tônus é normal. Hipertermia acima de 40 °C com disfunção do sistema nervoso central durante exercício em ambiente quente é golpe de calor por esforço; a pele ainda úmida não afasta, porque o suor costuma persistir na forma por esforço, e a CK alta é da rabdomiólise do esforço. A conduta é resfriar já, no local, por imersão em água gelada até cerca de 39 °C, antes de transportar ou investigar; antitérmico e dantroleno não funcionam.

A) Golpe de calor por esforço CORRETA
Correta. Hipertermia acima de 40 °C com encefalopatia durante esforço no calor, sem rigidez: golpe de calor por esforço, tratado com imersão em água gelada.

B) Síndrome neuroléptica maligna ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. Exige rigidez generalizada e evolução em dias após mudança de dose; dose estável há 3 anos e tônus normal derrubam.

C) Meningite bacteriana
Errada. Meningite não explica o início abrupto no esforço e cursa com rigidez de nuca, ausente.

D) Síndrome serotoninérgica
Errada. Exige droga serotoninérgica, clônus e hiper-reflexia, ausentes; haloperidol não é serotoninérgico.

Para levar. Hipertermia acima de 40 °C com encefalopatia no esforço sob calor é golpe de calor: resfriar por imersão antes de qualquer outra coisa. Sem rigidez, não é síndrome neuroléptica maligna.

Wilderness Medical Society 2019 (doenças pelo calor); ACSM 2023 (golpe de calor por esforço)

---

52 Neurologia · Primeira crise não provocada com RM e EEG normais: não iniciar droga anticrise

Omissão **Gabarito B**

Homem de 32 anos, engenheiro, teve crise tônico-clônica generalizada única à tarde, no escritório, presenciada por colegas, com 2 minutos de duração e confusão por 20 minutos. Dormiu bem na véspera, não bebe, não usa drogas nem medicações. Nega crises prévias, abalos ao acordar, episódios de desligamento, trauma ou infecção recente; sem história familiar de epilepsia. Exame neurológico normal. Glicemia, sódio, cálcio e magnésio normais. RM de encéfalo com protocolo para epilepsia normal e EEG com privação de sono normal. Não dirige profissionalmente. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

RM de encéfalo com protocolo para epilepsia normal e EEG com privação de sono normal

Resolução. Uma crise tônico-clônica no trabalho pede tratamento para quem reage à crise, não ao risco, e o levetiracetam, bem tolerado, parece não ter custo. Depois de uma primeira crise não provocada, o risco de recorrência em 2 anos é de cerca de 21% a 45%, e ele é maior com EEG epileptiforme, lesão na imagem, crise durante o sono ou déficit neurológico. Sem nenhum desses fatores (RM, EEG com privação, exame e contexto normais), o risco fica abaixo do limiar de 60% que define epilepsia pela ILAE, e iniciar droga reduz a recorrência precoce sem mudar o prognóstico de longo prazo, ao custo de efeitos adversos. A conduta é não iniciar anticrise, orientar sobre sono, álcool e atividades de risco, e explicar as restrições legais para dirigir;

tratamento após uma segunda crise. A decisão pode ser compartilhada com quem tem ocupação de alto risco, o que não é o caso.

A) Valproato por 6 meses
Errada. Valproato seria opção em epilepsia generalizada idiopática em homem (mioclonia ao acordar, ausências, EEG com poliponta-onda), negada aqui.

B) Não iniciar droga anticrise CORRETA
Correta. Primeira crise não provocada, sem fator de risco de recorrência: observar e orientar, sem droga.

C) Levetiracetam por 2 anos ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Levetiracetam é bem tolerado e parece não ter custo, mas iniciar após a primeira crise só se justifica com EEG epileptiforme, lesão estrutural, crise no sono ou déficit; nenhum está presente, e tratar agora reduz só a recorrência precoce.

D) Fenitoína até novo EEG
Errada. Fenitoína não tem papel na primeira crise com investigação normal, e manter droga 'até novo EEG' não tem base.

Para levar. Primeira crise não provocada com EEG, RM e exame normais: não iniciar droga. Iniciar se EEG epileptiforme, lesão estrutural, crise no sono ou déficit (risco de recorrência acima de 60%).
AAN/AES 2015 (primeira crise não provocada); ILAE 2014 (definição prática de epilepsia).

---

53 Infectologia · Elevação de transaminases durante o RHZE: limiar para suspender

Limiar **Gabarito C**

Mulher de 48 anos, na 3ª semana de RHZE em dose por peso para tuberculose pulmonar, comparece à consulta de rotina. Está assintomática: sem náuseas, vômitos, dor abdominal ou icterícia, e com apetite preservado. Não consome álcool e não usa outras medicações. ALT antes do tratamento: 22 U/L. Exames de hoje: ALT 152 U/L e AST 128 U/L (limite superior da normalidade de 40 U/L para ambas), bilirrubina total 0,9 mg/dL, fosfatase alcalina normal, INR 1,0. Anti-HIV, HBsAg e anti-HCV não reagentes. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE
Está assintomática: sem náuseas, vômitos, dor abdominal ou icterícia

Resolução. Transaminases quase quatro vezes o normal no início do RHZE assustam e puxam a suspensão. O critério do Ministério da Saúde para suspender o esquema por hepatotoxicidade é: transaminases de 5 vezes o limite superior ou mais sem sintomas, de 3 vezes ou mais com sintomas, ou icterícia. Aqui a ALT está em 3,8 vezes, sem sintomas, sem icterícia e com bilirrubina e INR normais: o esquema é mantido, com orientação sobre sinais de alarme e novas enzimas em curto prazo (em geral semanais até estabilizar). Elevação discreta e assintomática é comum nas primeiras semanas e costuma regredir com adaptação. Se cruzar o limiar, suspende-se tudo e, após a normalização, reintroduz-se em sequência (rifampicina com etambutol, depois isoniazida, depois pirazinamida).

A) Suspender o esquema até normalizar ARMADILHA
Errada. É a armadilha: suspender seria a conduta com ALT de 5 vezes o normal ou mais sem sintomas, ou 3 vezes com sintomas ou icterícia; ela está assintomática com 3,8 vezes.

B) Suspender só a pirazinamida

Errada. Retirar a pirazinamida de início, sem critério de suspensão, encurta a eficácia do esquema sem necessidade.

C) Manter RHZE e repetir enzimas CORRETA

Correta. ALT abaixo de 5 vezes o normal, sem sintomas e sem icterícia: manter o esquema e monitorar as enzimas.

D) Trocar por esquema sem rifampicina

Errada. Esquema sem rifampicina é para intolerância ou contraindicação documentada, e prolonga o tratamento.

Para levar. Hepatotoxicidade do RHZE: suspenda com transaminases de 5 vezes ou mais sem sintomas, 3 vezes ou mais com sintomas, ou icterícia; abaixo disso, mantenha e monitore.

Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil (MS, 2019, atualizado); ATS/CDC/IDSA Treatment of Drug-Susceptible Tuberculosis (2016).

54

Nefrologia · Rabdomiólise por esforço com hipercalemia e hipocalcemia assintomáticas · hidratação sem cálcio

Omissão **Gabarito A**

Homem de 24 anos, militar, previamente hígido, apresenta dor muscular difusa e urina escura após marcha de 30 km sob calor intenso no dia anterior. Exame: lúcido, PA 124/76 mmHg, FC 96 bpm, temperatura 37,5 °C, mucosas secas, sem sinais de Chvostek ou Trousseau, sem parestesias. Exames: CPK 68.000 U/L, creatinina 1,6 mg/dL, ureia 48 mg/dL, potássio 5,7 mEq/L, cálcio total 7,2 mg/dL, albumina 4,2 g/dL, fósforo 6,1 mg/dL, bicarbonato 21 mEq/L. Urina: fita com sangue 3+ e 2 hemácias por campo. ECG: ritmo sinusal, sem alterações. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

ECG: ritmo sinusal, sem alterações

Resolução. Potássio de 5,7 e cálcio de 7,2 parecem pedir gluconato de cálcio, e a creatinina subindo com CPK de 68.000 leva alguns à diálise, exatamente o que ele fez numa rabdomiólise anterior. Mas o cálcio intravenoso tem duas indicações aqui e nenhuma está presente: ECG com alteração de hipercalemia e hipocalcemia sintomática (tetania, convulsão, arritmia). Na rabdomiólise, o cálcio baixo resulta da deposição de fosfato de cálcio no músculo necrosado; repor sem necessidade aumenta essa deposição e predispõe à hipercalcemia de rebote na recuperação, quando o cálcio é remobilizado. O tratamento que protege o rim e baixa o potássio é cristaloide isotônico vigoroso, ajustado para diurese de cerca de 200 a 300 mL/h, com monitorização seriada do potássio e do ECG. Bicarbonato e manitol não mostraram benefício sobre a hidratação isolada, e o bicarbonato ainda reduz o cálcio ionizado. Diálise só com hipercalemia refratária, acidose grave, oligúria com congestão ou uremia.

A) Cristaloide intravenoso vigoroso CORRETA

Correta. Rabdomiólise com potássio de 5,7, ECG normal e hipocalcemia assintomática: hidratação isotônica vigorosa, sem cálcio.

B) Bicarbonato de sódio e manitol
Errada. Alcalinização e manitol não superaram a hidratação isolada, e o bicarbonato reduz o cálcio ionizado, agravando a hipocalcemia.

C) Hemodiálise de urgência
Errada. Não há hipercalemia refratária, acidose grave nem sobrecarga: a diurese ainda pode ser sustentada com volume.

D) Gluconato de cálcio e cristaloide ARMADILHA
Errada, é a armadilha. O cálcio estaria indicado com ECG alterado ou hipocalcemia sintomática; sem isso, ele se deposita no músculo lesado e favorece a hipercalcemia de rebote.

Para levar. Na rabdomiólise, hidratação isotônica vigorosa é o tratamento; não reponha cálcio na hipocalcemia assintomática nem dê cálcio na hipercalemia com ECG normal.

Bosch, Poch e Grau, NEJM 2009 (Rhabdomyolysis and acute kidney injury); Harrison 21ª ed. (Rhabdomyolysis); UK Kidney Association (Renal Association), Treatment of Acute Hyperkalaemia in Adults (2020).

---

55 Endocrinologia · Hipotireoidismo e gestação confirmada: aumentar a levotiroxina antes do primeiro TSH

Qualificador **Gabarito A**

Mulher de 33 anos, com hipotireoidismo por tireoidite de Hashimoto em uso de levotiroxina 100 µg/dia, com TSH de 1,6 µUI/mL há dois meses, descobre-se grávida, com seis semanas, pelo atraso menstrual e beta-hCG positivo. Assintomática. A primeira consulta de pré-natal está marcada para daqui a três semanas. Até lá, em relação à levotiroxina, a conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE
Até lá, em relação à levotiroxina

Resolução. TSH de 1,6 há dois meses parece autorizar manter a dose e reavaliar na consulta, e é o que o apressado marca. O qualificador do comando pede a conduta para as próximas três semanas, que coincidem com o período em que a demanda de T4 sobe rapidamente (aumento da globulina ligadora de tiroxina pelo estrogênio, estímulo do hCG perdido numa glândula sem reserva, transferência ao feto) e em que o feto depende só do T4 materno para o desenvolvimento neurológico. Por isso a mulher com hipotireoidismo tratado deve aumentar a dose em cerca de 25 a 30% assim que a gestação é confirmada, o equivalente a duas doses extras por semana, e dosar TSH em quatro semanas. Dobrar a dose é excessivo, e liotironina não atravessa a placenta adequadamente para o cérebro fetal.

A) Aumentar cerca de 30% da dose já CORRETA
Correta. Gestação confirmada em hipotireoidea tratada: aumentar cerca de 25 a 30% (duas doses extras por semana) já, e TSH em quatro semanas.

B) Dobrar a dose e dosar T4 total
Errada. O aumento é de 25 a 30%, não 100%; dobrar induz tireotoxicose.

C) Trocar por liotironina na gestação
Errada. Liotironina não fornece T4 ao cérebro fetal; a levotiroxina é o tratamento na gestação.

D) Manter a dose e dosar TSH no pré-natal ARMADILHA

Errada. Seria a conduta em eutireoidiana sem tratamento; com hipotireoidismo tratado, esperar três semanas deixa o primeiro trimestre descoberto.

Para levar. Hipotireoidea em levotiroxina que engravida: aumente cerca de 30% (duas doses extras por semana) no dia da confirmação, sem esperar o TSH.

ATA Guidelines for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and the Postpartum 2017.

---

56 Oncologia · Colite imunomediada grau 3 por pembrolizumabe com antibiótico recente: suspender e corticoide

Rótulo verdadeiro **Gabarito A**

Homem de 63 anos com carcinoma pulmonar de não pequenas células em uso de pembrolizumabe (6º ciclo há 2 semanas), tratado há 3 semanas com amoxicilina-clavulanato por sinusite, tem há 5 dias 9 evacuações aquosas por dia (basal: 1), com cólica e sem sangue. Exame: Tax 37,4 °C, FC 102 bpm, PA 112 × 70 mmHg, abdome doloroso difusamente, sem peritonite. Exames: PCR 96 mg/L, potássio 3,2 mEq/L, creatinina 1,3 mg/dL; pesquisa de toxinas A/B e PCR para C. difficile negativas; coprocultura e painel molecular fecal negativos; calprotectina 820 µg/g. TC: espessamento difuso do cólon, sem perfuração. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

pesquisa de toxinas A/B e PCR para C. difficile negativas

Resolução. Antibiótico há 3 semanas e diarreia aquosa armam colite por C. difficile, e vancomicina oral empírica mantendo a imunoterapia parece prudente. Mas toxinas e PCR para C. difficile são negativos, o painel fecal é negativo, a calprotectina está muito alta e a TC mostra colite difusa em quem recebe pembrolizumabe: colite imunomediada. São 8 evacuações acima do basal, o que é grau 3 (7 ou mais acima do basal): suspende-se a imunoterapia e inicia-se metilprednisolona intravenosa de 1 a 2 mg/kg/dia, com hidratação e correção do potássio. Infliximabe ou vedolizumabe entram se não houver resposta em 2 a 3 dias, e não no lugar do corticoide. Loperamida isolada mascara colite grave e arrisca megacólon.

A) Suspender a imunoterapia e corticoide IV CORRETA

Correta. Colite grau 3 por inibidor de checkpoint, com infecção afastada: suspender o pembrolizumabe e iniciar corticoide intravenoso de 1 a 2 mg/kg/dia.

B) Infliximabe isolado, sem corticoide

Errada. Infliximabe é o resgate da colite refratária ao corticoide após 2 a 3 dias, e não a primeira linha isolada.

C) Loperamida, mantendo a imunoterapia

Errada. Loperamida isolada é aceitável só no grau 1; no grau 3 mascara a gravidade e arrisca megacólon.

D) Vancomicina oral, mantendo a imunoterapia ARMADILHA

Errada. É a isca: o antibiótico recente sugere C. difficile, mas toxinas e PCR negativos o afastam, e manter a imunoterapia agrava a colite.

Para levar. Colite por imunoterapia grau 3 (7 ou mais evacuações acima do basal): suspender e corticoide de 1 a 2 mg/kg; sem resposta em 3 dias, infliximabe ou vedolizumabe.

ASCO Guideline: Management of Immune-Related Adverse Events in Patients Treated With Immune Checkpoint Inhibitor Therapy (2021); ESMO Clinical Practice Guideline: management of toxicities from immunotherapy (2022)

---

57 Cardiologia · Cardiomiopatia hipertrófica com gradiente abaixo de 50 mmHg e síncope inexplicada: CDI, não redução septal

Limiar **Gabarito B**

Mulher de 26 anos, com cardiomiopatia hipertrófica diagnosticada há 4 anos, em uso de bisoprolol 5 mg, teve há 2 meses perda súbita de consciência em repouso, sentada, sem pródromos, com recuperação espontânea em 1 minuto. Sem morte súbita na família. Exame: PA 112×70 mmHg, FC 58 bpm, sopro sistólico 2/6 em borda esternal esquerda. Ecocardiograma: espessura septal máxima de 27 mm, átrio esquerdo de 46 mm, gradiente na via de saída do VE de 18 mmHg em repouso e de 34 mmHg com Valsalva, FE 68%. Holter: dois episódios de taquicardia ventricular não sustentada, de 6 e 8 batimentos. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

gradiente na via de saída do VE de 18 mmHg em repouso e de 34 mmHg com Valsalva

Resolução. Betabloqueador é o tratamento que ele associa à cardiomiopatia hipertrófica, e aumentar a dose parece o passo prudente: é a armadilha. A pergunta, porém, é de morte súbita, e não de sintoma. Síncope inexplicada recente (em repouso, sem pródromos), taquicardia ventricular não sustentada, parede de 27 mm, átrio de 46 mm e idade jovem colocam o risco estimado em 5 anos bem acima de 6% no escore da ESC, e síncope inexplicada é, sozinha, fator maior na diretriz americana: o cardiodesfibrilador está indicado. A redução septal (ablação ou miectomia) trata obstrução sintomática com gradiente de 50 mmHg ou mais, e aqui o gradiente máximo é 34 mmHg (30 mmHg ou mais já define a forma obstrutiva, mas não basta para intervir). Nem betabloqueador nem amiodarona previnem morte súbita na cardiomiopatia hipertrófica.

A) Ablação septal alcoólica
Errada. A redução septal exige gradiente de 50 mmHg ou mais com sintomas refratários; 34 mmHg com Valsalva está abaixo do limiar.

B) Cardiodesfibrilador implantável CORRETA
Correta. Síncope arrítmica provável e TVNS, com risco estimado acima de 6% em 5 anos: CDI para prevenção primária.

C) Aumentar o betabloqueador e repetir o Holter ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. O betabloqueador controla sintomas e gradiente, mas não previne morte súbita; repetir Holter adia a decisão.

D) Amiodarona oral
Errada. A amiodarona não reduz morte súbita na cardiomiopatia hipertrófica e não substitui o CDI.

Para levar. Na cardiomiopatia hipertrófica, CDI responde ao risco de morte súbita (síncope inexplicada, TVNS, parede de 30 mm ou mais, história familiar, aneurisma apical, FE abaixo de 50%); redução septal responde à obstrução sintomática com gradiente de 50 mmHg ou mais.

ESC 2023 (cardiomyopathies, HCM Risk-SCD); AHA/ACC 2024 (hypertrophic cardiomyopathy)

---

58 Hematologia · TVP provocada por cirurgia ortopédica: 3 meses de anticoagulação e nenhuma pesquisa de trombofilia

Omissão **Gabarito C**

Homem de 33 anos, previamente hígido, teve trombose venosa profunda poplítea direita no 9º dia após reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito, com imobilização gessada. Tratado com rivaroxabana, completou 3 meses, com trombo recanalizado ao Doppler e sem sintomas. Não há história familiar de trombose. Exame físico normal; hemograma, função renal e hepática normais. Ele pergunta por exames "para ver se o sangue é grosso" e se deve continuar o remédio. A conduta mais adequada é:

> O DADO QUE DECIDE
>
> *no 9º dia após reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito, com imobilização gessada*

Resolução. Jovem de 33 anos com trombose puxa para pesquisa de trombofilia, e o paciente ainda pede o exame. A pergunta certa é se o resultado mudaria a conduta, e aqui não muda: a trombose foi provocada por fator transitório maior (cirurgia ortopédica com imobilização gessada), cujo risco de recorrência após 3 meses de tratamento é baixo, por volta de 1% ao ano. A diretriz da ASH de 2023 recomenda não pesquisar trombofilia após TEV provocado por cirurgia, porque a maioria das alterações hereditárias (fator V Leiden, mutação da protrombina em heterozigose) não justifica anticoagulação estendida nesse contexto e o resultado gera ansiedade e tratamento a mais. O tratamento é de 3 meses e para. Estender, com dose plena ou reduzida, é para TEV não provocado ou fator de risco persistente.

A) Manter anticoagulação indefinidamente
Errada. Anticoagulação indefinida cabe ao TEV não provocado de baixo risco hemorrágico ou à SAF; o risco do sangramento aqui supera o benefício.

B) Pesquisar trombofilia antes de decidir ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a pesquisa não mudaria a decisão após TEV cirúrgico e é desaconselhada pela ASH 2023.

C) Suspender sem pesquisar trombofilia CORRETA
Correta. TEV provocado por fator transitório maior: 3 meses de anticoagulação, suspensão e nenhuma pesquisa de trombofilia.

D) Rivaroxabana 10 mg por mais 1 ano
Errada. A dose reduzida estendida é estratégia para TEV não provocado ou com fator persistente após a fase inicial, não para TEV cirúrgico.

Para levar. TEV provocado por fator transitório maior (cirurgia, gesso) trata-se por 3 meses e para; pesquisar trombofilia não muda a conduta e não se faz.

ASH 2020 guidelines for the treatment of VTE (Ortel et al.); ASH 2023 guidelines on thrombophilia testing (Middeldorp et al.); ESC 2019 guidelines on acute pulmonary embolism; CHEST 2021 Antithrombotic Therapy for VTE.

---

59 Reumatologia · Suspensão do denosumabe: zoledronato para evitar o efeito rebote

Qualificador **Gabarito D**

Mulher de 70 anos usa denosumabe 60 mg a cada 6 meses há 5 anos, sem fraturas, com T-escore atual de -1,9 em colo femoral, e o tratamento será interrompido. Para prevenir a perda óssea acelerada e as fraturas vertebrais múltiplas após a suspensão, recomenda-se:

O DADO QUE DECIDE

Para prevenir a perda óssea acelerada e as fraturas vertebrais múltiplas após a suspensão

Resolução. A analogia com o bisfosfonato, que permite férias porque fica retido no osso, leva a suspender o denosumabe e só observar. O denosumabe não se acumula no osso: quando o efeito acaba, há um rebote da reabsorção, com perda rápida de massa e risco de fraturas vertebrais múltiplas a partir de 7 a 16 meses após a última dose. Por isso ele não deve ser interrompido sem terapia de transição com bisfosfonato, em geral zoledronato cerca de 6 meses após a última aplicação, com dosagem de marcador de reabsorção ou densitometria para decidir nova dose. Teriparatida logo após o denosumabe acelera a perda óssea no quadril, e espaçar a aplicação apenas antecipa o rebote.

A) Teriparatida logo após a última dose
Errada. A transição de denosumabe para teriparatida causa perda óssea transitória no quadril e não previne o rebote vertebral.

B) Reduzir para uma aplicação anual
Errada. Aplicação anual deixa o efeito acabar entre as doses e expõe ao mesmo rebote.

C) Observar e repetir densitometria em 2 anos ARMADILHA
Errada. Seria aceitável após bisfosfonato em baixo risco (férias); após denosumabe, observar deixa o rebote acontecer.

D) Zoledronato cerca de 6 meses após a última dose CORRETA
Correta. Zoledronato cerca de 6 meses após a última dose consolida o ganho e reduz o rebote; pode ser preciso repetir conforme os marcadores.

Para levar. Denosumabe não tem férias: ao suspender, faça bisfosfonato (zoledronato cerca de 6 meses após a última dose) para evitar o rebote com fraturas vertebrais múltiplas.

ECTS 2021 position statement on denosumab discontinuation (Tsourdi et al.); Manual Brasileiro de Osteoporose: orientações práticas (2021); Endocrine Society 2019/2020 osteoporosis guideline.

Mulher de 58 anos, que nunca fumou, tem adenocarcinoma de pulmão com metástases ósseas e hepáticas, diagnosticado por biópsia hepática. ECOG 1. Ressonância de crânio: duas metástases assintomáticas de 6 mm. Imuno-histoquímica: PD-L1 expresso em 85% das células tumorais. Painel molecular por sequenciamento de nova geração: deleção do éxon 19 do EGFR; ALK, ROS1 e KRAS sem alterações. O tratamento de primeira linha mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

deleção do éxon 19 do EGFR

Resolução. PD-L1 de 85% é o critério de imunoterapia isolada em primeira linha, e quem lembra só dessa regra marca pembrolizumabe. Mas a regra vale para tumores sem alteração molecular acionável. Com mutação sensibilizante do EGFR (deleção do éxon 19), a imunoterapia tem resposta pobre mesmo com PD-L1 alto, e o uso prévio de anti-PD-1 aumenta a pneumonite grave quando o inibidor de tirosina-quinase vem depois. A primeira linha é baseada no osimertinibe (FLAURA; isolado ou, pelo FLAURA2, associado a platina e pemetrexede), que tem boa penetração no sistema nervoso central e trata as metástases cerebrais pequenas e assintomáticas sem radiocirurgia imediata. Por isso o painel molecular deve vir antes de iniciar imunoterapia em adenocarcinoma, sobretudo em não fumantes.

A) Pembrolizumabe isolado ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. Pembrolizumabe isolado é para PD-L1 de 50% ou mais sem driver acionável; com EGFR mutado, resposta é pobre e a toxicidade com TKI posterior aumenta.

B) Quimioterapia com pembrolizumabe
Errada. Quimioimunoterapia é para doença sem driver, independentemente do PD-L1; não é a escolha com EGFR sensibilizante.

C) Osimertinibe oral CORRETA
Correta. Adenocarcinoma estádio IV com deleção do éxon 19 do EGFR: osimertinibe (isolado ou com quimioterapia), ativo também nas metástases cerebrais assintomáticas.

D) Radiocirurgia e depois quimioterapia
Errada. Radiocirurgia imediata é para metástases sintomáticas ou maiores; com TKI de boa penetração cerebral, metástases pequenas e assintomáticas podem ser acompanhadas.

Para levar. Em adenocarcinoma avançado, o driver acionável manda mais que o PD-L1: EGFR sensibilizante pede osimertinibe, não imunoterapia.

ESMO 2023 (CPNPC metastático com alteração oncogênica); FLAURA (N Engl J Med 2018 e 2020); FLAURA2 (N Engl J Med 2023)

61 Infectologia · Bacteremia sustentada por estafilococo coagulase-negativo em portador de marca-passo com loja limpa e transtorácico normal: ecocardiograma transesofágico

Negativo no meio **Gabarito B**

Homem de 71 anos, com marca-passo bicameral implantado há 14 meses por bloqueio atrioventricular total, diabético, procura o pronto-socorro por febre intermitente, calafrios e astenia há 3 semanas. Não tem cateter venoso, prótese valvar nem procedimento recente. Exame: T 38,3 °C, FC 70 bpm em ritmo de marca-passo, PA 126 × 74 mmHg, loja do gerador sem dor, hiperemia, flutuação ou erosão da pele, sem sopros e sem estigmas periféricos de endocardite. Leucócitos 11.800/mm³, PCR 9,6 mg/dL, EAS normal, radiografia de tórax sem alterações. Três pares de hemoculturas periféricas, colhidos em horários diferentes antes de antibiótico: Staphylococcus epidermidis resistente à oxacilina em todos os frascos, com o mesmo antibiograma. Ecocardiograma transtorácico: valvas sem vegetações, eletrodos mal avaliados pela janela acústica. O próximo exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

Staphylococcus epidermidis resistente à oxacilina em todos os frascos

Resolução. O estafilococo coagulase-negativo costuma ser contaminante, a loja do gerador está limpa e o transtorácico não mostrou vegetação: tudo parece dispensar investigação. Mas três pares colhidos em momentos diferentes, todos com a mesma cepa, não são contaminação: é bacteremia verdadeira e sustentada, e em portador de dispositivo cardíaco eletrônico implantável o estafilococo coagulase-negativo é justamente um dos principais agentes de infecção do dispositivo. A infecção sistêmica do marca-passo muitas vezes não dá sinal na loja, porque está nos eletrodos intravasculares, e o transtorácico tem baixa sensibilidade para vegetação de eletrodo. Por isso a diretriz europeia de 2023 recomenda o ecocardiograma transesofágico em toda suspeita de endocardite relacionada a dispositivo, qualquer que seja o resultado do transtorácico; o PET-CT entra depois, quando o transesofágico é inconclusivo. Confirmada a infecção do dispositivo, a conduta é a retirada completa do sistema, com vancomicina.

A) PET-CT com FDG

Errada. PET-CT é o exame seguinte quando o transesofágico é inconclusivo, ou para avaliar a loja e procurar êmbolos; ir direto a ele é pular um degrau.

B) Ecocardiograma transesofágico CORRETA

Correta. Bacteremia sustentada por estafilococo coagulase-negativo em portador de marca-passo: transesofágico para procurar vegetação em eletrodo e valva, mesmo com transtorácico normal.

C) Nenhum exame adicional ARMADILHA

Errada. É a armadilha: seria a conduta com um único frasco positivo, que sugere contaminação; três pares com a mesma cepa em portador de marca-passo são bacteremia verdadeira, e loja limpa não afasta infecção dos eletrodos.

D) Novo transtorácico em 7 dias

Errada. Repetir o transtorácico mantém um exame de baixa sensibilidade para eletrodos, e a investigação de bacteremia sustentada não espera 7 dias.

Para levar. Portador de marca-passo ou CDI com bacteremia estafilocócica sustentada, inclusive por coagulase-negativo: ecocardiograma transesofágico, mesmo com loja limpa e transtorácico normal.

ESC Guidelines for the management of endocarditis (2023); Duke-ISCVID Criteria for Infective Endocarditis (Clin Infect Dis, 2023); EHRA international consensus document on cardiac implantable electronic device infections (Europace, 2020).

---

62 Nefrologia · Glomerulonefrite com anti-PR3 reagente e complemento baixo na endocardite subaguda · não é vasculite ANCA

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Homem de 47 anos, com prolapso de valva mitral, fez tratamento dentário há dois meses. Há seis semanas tem febre vespertina, perda de 6 kg e artralgias e, há dez dias, petéquias em membros inferiores e urina escura. Exame: temperatura 38,1 °C, PA 138/84 mmHg, sopro sistólico mitral 3+/6+, esplenomegalia discreta. Hemoculturas: Streptococcus mitis em três de três amostras. Ecocardiograma transtorácico: prolapso mitral com insuficiência moderada, sem vegetação definida. Exames: hemoglobina 9,6 g/dL, creatinina 2,8 mg/dL (1,0 há três meses), urina com hemácias dismórficas e cilindros hemáticos, proteinúria de 24 h de 1,4 g, C3 52 mg/dL (90 a 180), C4 14 mg/dL (10 a 40), fator reumatoide reagente e anti-PR3 reagente (28 U/mL, positivo acima de 10). O diagnóstico da lesão renal é:

O DADO QUE DECIDE

C3 52 mg/dL (90 a 180)

Resolução. Anti-PR3 reagente com glomerulonefrite de progressão rápida, petéquias e artralgia monta uma granulomatose com poliangiite, e o passo seguinte seria pulso e ciclofosfamida. Mas o ANCA é falso amigo na endocardite: a infecção crônica estimula autoanticorpos, e anti-PR3 em título baixo aparece numa parcela relevante das endocardites subagudas, com fator reumatoide também reagente. Quem separa é o complemento, junto com as culturas: a vasculite ANCA é pauci-imune e cursa com C3 normal, e aqui o C3 está consumido, padrão de glomerulonefrite por imunocomplexo infeccioso; e há bacteremia persistente por estreptococo do grupo viridans (critério maior de Duke) com valvopatia predisponente, febre e fenômenos imunológicos (glomerulonefrite, fator reumatoide), o que fecha endocardite definida mesmo com o transtorácico sem vegetação, cuja sensibilidade é limitada; o transesofágico é o passo seguinte. O tratamento da lesão renal é o da endocardite: antibiótico dirigido e avaliação cirúrgica da valva. Imunossupressão aqui pode ser fatal.

A) Vasculite associada ao ANCA ARMADILHA

Errada, é a armadilha. Seria o diagnóstico com ANCA positivo, C3 normal e culturas negativas; com bacteremia persistente por viridans numa valva doente, o anti-PR3 é epifenômeno da infecção, e o transtorácico normal não afasta endocardite.

B) Glomerulonefrite da endocardite CORRETA

Correta. Endocardite subaguda com C3 consumido, sedimento nefrítico e anti-PR3 de título baixo: glomerulonefrite por imunocomplexo da endocardite, tratada com antibiótico.

C) Crioglobulinemia mista

Errada. A crioglobulinemia consome C4 de forma desproporcional e se associa sobretudo à hepatite C; o C4 está normal e a causa infecciosa está demonstrada.

D) Nefrite intersticial por antibiótico
Errada. Nefrite intersticial daria leucocitúria e cilindros leucocitários, não hemácias dismórficas e cilindros hemáticos, e o quadro renal começou antes de qualquer antibiótico.

Para levar. ANCA positivo com glomerulonefrite e complemento baixo: procure endocardite antes de imunossuprimir; a vasculite ANCA é pauci-imune e tem C3 normal.

ESC 2023 (Endocardite infecciosa) e critérios de Duke-ISCVID 2023; KDIGO 2021 (Glomerular Diseases), glomerulonefrite associada a infecção; KDIGO 2024 (ANCA-Associated Vasculitis).

---

63 Gastroenterologia · Hemorragia digestiva alta de baixo risco pelo escore de Glasgow-Blatchford: endoscopia ambulatorial após a alta

Omissão **Gabarito B**

Homem de 34 anos, sem comorbidades, procura o pronto-socorro por um episódio de fezes enegrecidas pela manhã, após 5 dias de ibuprofeno para lombalgia. Sem hematêmese, síncope ou tontura; sem hepatopatia, cardiopatia ou uso de anticoagulante. Exame: PA 128 × 78 mmHg, FC 82 bpm, sem hipotensão postural, abdome indolor, toque retal com fezes castanhas. Exames: hemoglobina 14,6 g/dL, ureia 32 mg/dL, creatinina 0,9 mg/dL, INR 1,0, plaquetas 260.000/mm³. Mora perto do hospital e tem acompanhante. Quanto à endoscopia digestiva alta, o momento mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE
hemoglobina 14,6 g/dL, ureia 32 mg/dL

Resolução. Melena após anti-inflamatório leva à internação para endoscopia em 24 horas, o que parece o mínimo seguro. O escore de Glasgow-Blatchford aqui é 1: só a melena pontua; hemoglobina de 14,6 em homem, ureia de 32 mg/dL (abaixo de 39 mg/dL), PA sistólica de 128, FC de 82, sem síncope, hepatopatia ou cardiopatia. Escore de 0 ou 1 identifica risco muito baixo de necessidade de intervenção ou morte, e as diretrizes recomendam alta com endoscopia ambulatorial, que é segura e evita internação. A endoscopia continua necessária para achar e tratar a causa (úlcera por AINE, pesquisa de H. pylori), mas não precisa ser feita internado. Até ela, suspende-se o ibuprofeno e prescreve-se IBP oral.

A) Em até 12 horas, internado
Errada. Endoscopia em até 12 horas é para o doente de alto risco que segue instável após a reanimação; aqui a hemodinâmica é normal.

B) Ambulatorial, após a alta CORRETA
Correta. Glasgow-Blatchford de 1 (só a melena), estável e com suporte: alta com IBP oral e endoscopia ambulatorial.

C) Em até 24 horas, internado ARMADILHA
Errada. É a isca: endoscopia em até 24 horas, internado, é para Glasgow-Blatchford acima de 1; com escore 1, a internação não melhora desfechos.

D) Dispensável, com IBP empírico
Errada. Baixo risco muda o lugar da endoscopia, e não sua indicação: ela define a causa, orienta a duração do IBP e a pesquisa de H. pylori.

Para levar. Hemorragia digestiva alta com Glasgow-Blatchford de 0 ou 1: alta e endoscopia ambulatorial; acima disso, internação e endoscopia em até 24 horas.

ESGE Guideline: Endoscopic diagnosis and management of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage (2021); ACG Clinical Guideline: Upper Gastrointestinal and Ulcer Bleeding (2021)

---

64 Neurologia · Dor dorsal suspeita de metástase vertebral, sem déficit: RM de toda a coluna antes de corticoide e radioterapia

Negativo no meio **Gabarito B**

Homem de 67 anos, com adenocarcinoma de próstata com metástases ósseas em bloqueio androgênico, procura o ambulatório por dor dorsal torácica há 3 semanas, em faixa, que piora ao deitar, à tosse e ao espirro e o acorda de madrugada. Nega fraqueza, alteração urinária ou intestinal. Exame: dor à percussão de T8, força 5/5, reflexos normais, sem nível sensitivo, Babinski ausente. Radiografia de coluna torácica sem colapso vertebral. Cintilografia óssea de 4 meses atrás: captação em bacia e costelas. RM de coluna lombossacra feita há 3 semanas, pedida pelo ortopedista no início da dor: discopatia degenerativa, sem lesões ósseas. O próximo passo mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

Nega fraqueza, alteração urinária ou intestinal.

Resolução. Dor dorsal radicular em faixa, pior ao deitar e à manobra de Valsalva, noturna, num paciente com câncer e metástase óssea é dor de metástase vertebral com risco de compressão medular, e nem a radiografia normal (o colapso aparece tarde) nem a RM lombossacra normal afastam: esta não incluiu o segmento doloroso, T8. O negativo no meio decide o porte da conduta: sem fraqueza, sem disfunção esfincteriana e com exame normal, não há compressão estabelecida a tratar às cegas; o que se faz é a RM de toda a coluna, com prioridade (em até 1 semana; em até 24 horas se surgir sintoma neurológico). A coluna inteira, porque metástases em vários níveis são comuns e mudam o planejamento. Dexametasona em dose alta e radioterapia entram quando a RM confirma compressão ou quando já há déficit, situação em que o corticoide começa antes mesmo da imagem. Esperar 2 semanas com analgesia é o erro inverso, e a cintilografia não avalia o canal.

A) Dexametasona e radioterapia empíricas
Errada. Seria a conduta com déficit neurológico (dexametasona imediata, antes mesmo da imagem) ou com compressão confirmada; sem déficit, tratar às cegas antes da RM é fazer mais e no escuro.

B) RM de toda a coluna CORRETA
Correta. Dor sugestiva de metástase vertebral sem déficit: RM de toda a coluna com prioridade, que define compressão, níveis e conduta.

C) Analgesia e reavaliação em 2 semanas ARMADILHA
Errada, é a armadilha. A radiografia e a RM lombossacra normais tranquilizam, mas a RM não viu T8; dor noturna em faixa, pior ao deitar, em paciente com metástase óssea não pode esperar, porque a compressão pode se instalar no intervalo. Seria a conduta na dor mecânica sem bandeira vermelha.

D) Nova cintilografia óssea
Errada. A cintilografia mostra captação óssea, mas não avalia o canal medular nem a compressão.

Para levar. Câncer com dor dorsal noturna, pior ao deitar: RM de toda a coluna (em até 1 semana sem déficit; em até 24 horas com déficit, e então dexametasona antes da imagem).

NICE NG234 2023 (compressão medular metastática); ASCO/ASTRO 2022.

---

65 Endocrinologia · Hiperprolactinemia acima de 100 por risperidona: trocar o antipsicótico

Limiar **Gabarito C**

Homem de 29 anos, com esquizofrenia estável há dois anos em uso de risperidona 6 mg/dia, queixa-se de disfunção erétil e redução da libido há oito meses. A prolactina antes da risperidona, dosada em internação psiquiátrica, era de 11 ng/mL. Sem cefaleia ou alteração visual. Exame: ginecomastia bilateral discreta, testículos de volume normal, campimetria de confrontação normal. Exames: prolactina 142 ng/mL (até 15) em duas dosagens, testosterona total 210 ng/dL (300 a 1.000), LH 1,8 UI/L, TSH 1,6 µUI/mL, creatinina 0,9 mg/dL. O psiquiatra concorda em ajustar o tratamento. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

A prolactina antes da risperidona, dosada em internação psiquiátrica, era de 11 ng/mL

Resolução. A regra de que droga raramente eleva a prolactina acima de 100 ng/mL é útil, mas a risperidona (e a paliperidona) são a exceção: bloqueiam D2 com força e atravessam mal a barreira, ficando na hipófise, e produzem valores de 100 a 200 ng/mL ou mais. Usar o limiar como absoluto leva à ressonância. O dado que decide é a cronologia: prolactina normal antes do antipsicótico, e hiperprolactinemia surgindo com ele. Quando o início coincide com a droga e ela pode ser trocada, troca-se, em conjunto com o psiquiatra, por um antipsicótico poupador de prolactina como o aripiprazol, e redosa-se; imagem fica para quando a troca não for possível e a relação temporal não estiver clara. Cabergolina pode piorar a psicose, e testosterona isolada trata o efeito e mantém a causa.

A) Cabergolina mantendo a risperidona
Errada. Agonista dopaminérgico antagoniza o antipsicótico e pode descompensar a psicose; é reserva para quando a troca não for possível.

B) Testosterona mantendo a risperidona
Errada. Corrige o hipogonadismo sem tratar a causa e não reverte a ginecomastia; fica para quando o antipsicótico não puder ser mudado.

C) Trocar a risperidona por aripiprazol CORRETA
Correta. Hiperprolactinemia sintomática que começou com a risperidona, com prolactina normal antes: trocar por aripiprazol e redosar.

D) Ressonância magnética de sela ARMADILHA
Errada. Seria a conduta com prolactina já alta antes do antipsicótico, sintomas de massa, ou quando a droga não pode ser trocada.

Para levar. Prolactina acima de 100 não exclui droga: risperidona e paliperidona passam disso. Se a elevação começou com o antipsicótico, troque-o (aripiprazol) antes de pensar em imagem ou cabergolina.

Endocrine Society, Hyperprolactinemia 2011; Pituitary Society consensus on prolactinomas 2023.

---

66 Cardiologia · Hipertensão estágio 2 no diabético: combinação inicial e meta abaixo de 130×80

Grade X / Y **Gabarito D**

Homem de 52 anos, com diabetes tipo 2 há 5 anos em uso de metformina, sem doença cardiovascular estabelecida, tem PA de consultório de 162×100 mmHg em três consultas, confirmada por MAPA (média de 24 horas de 154×96 mmHg). Relação albumina/creatinina urinária de 80 mg/g, TFG 82 mL/min, potássio 4,3 mEq/L. Já tenta medidas não farmacológicas há 3 meses. O tratamento inicial e a meta pressórica de consultório são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

Relação albumina/creatinina urinária de 80 mg/g

Resolução. Hipertensão estágio 2 (PA de 160×100 ou mais) se trata desde o início com combinação de duas classes, de preferência em comprimido único, porque a monoterapia raramente leva à meta e atrasa o controle. Bloqueador do sistema renina-angiotensina é obrigatório pela albuminúria (80 mg/g, moderadamente aumentada), e o par preferencial é com bloqueador de canal de cálcio (ou tiazídico). A meta é a parte que costuma ficar pela metade: a diretriz brasileira de 2020 fixa PA abaixo de 130×80 no alto risco cardiovascular, o que inclui o diabético com albuminúria, e a ESC 2024 mira sistólica de 120 a 129 mmHg para a maioria dos tratados. Quem acerta a combinação e mantém a meta antiga de 140×90 cai na armadilha.

A) Monoterapia com BRA / abaixo de 130×80
Errada na primeira metade. A meta está certa, mas estágio 2 começa com combinação; a monoterapia é para estágio 1 de baixo risco ou para o idoso frágil.

B) Monoterapia com BRA / abaixo de 140×90
Errada nas duas metades: monoterapia e meta antiga.

C) BRA associado a BCC / abaixo de 140×90 ARMADILHA
Errada na segunda metade, e é a armadilha. A combinação está certa, mas a meta de 140×90 foi abandonada para o diabético com albuminúria.

D) BRA associado a BCC / abaixo de 130×80 CORRETA
Correta. Combinação de BRA com BCC desde o início e meta abaixo de 130×80, pela albuminúria e pelo diabetes.

Para levar. Hipertensão estágio 2, ou estágio 1 de risco alto: combinação inicial de duas classes (IECA ou BRA com BCC ou tiazídico), de preferência em comprimido único; meta abaixo de 130×80 no alto risco, e sempre no diabético e no renal com albuminúria.

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (SBC/SBH/SBN 2020); ESC 2024 (hypertension); ADA Standards of Care 2026

---

67 Hematologia · Esquizócitos na sepse: CIVD x PTT pelo coagulograma, e crioprecipitado no sangramento

Grade X / Y **Gabarito D**

Homem de 61 anos, no 3º dia de internação por choque séptico de foco urinário por E. coli, em uso de noradrenalina, evolui com rebaixamento do nível de consciência, sangramento em sítios de cateter e petéquias. Exames: Hb 8,8 g/dL, plaquetas 31.000/mm³ (162.000 na admissão), esquizócitos em 1,5% das hemácias, LDH 780 U/L, creatinina 2,9 mg/dL, INR 2,2, TTPa 52 s (controle 30 s), fibrinogênio 88 mg/dL e D-dímero acima de 20 vezes o limite superior. O diagnóstico e a medida hemostática mais adequada são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

fibrinogênio 88 mg/dL

Resolução. Esquizócitos, plaquetopenia grave, alteração neurológica e lesão renal montam a pêntade da PTT, e a plasmaférese vem como reflexo. Esquizócitos, porém, aparecem em qualquer microangiopatia, inclusive na coagulação intravascular disseminada, e o que separa as duas é o coagulograma: a PTT consome plaquetas, mas não fatores, e tem TP, TTPa e fibrinogênio normais. Aqui INR de 2,2, TTPa alargado, fibrinogênio de 88 e D-dímero mais de 20 vezes acima do limite, num choque séptico, são consumo de fatores: CIVD, com escore ISTH bem acima de 5. O tratamento é o da sepse, e no paciente que sangra se repõe o que falta: crioprecipitado (ou concentrado de fibrinogênio) para fibrinogênio abaixo de 150, plaquetas abaixo de 50.000 e plasma para o INR alargado. A plasmaférese não tem papel na CIVD.

A) PTT / plasmaférese ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a PTT não alarga INR e TTPa nem consome fibrinogênio; esquizócitos sozinhos não fazem o diagnóstico.

B) PTT / crioprecipitado
Errada. Erra as duas metades: não é PTT, e na PTT o crioprecipitado não teria papel.

C) CIVD / plasmaférese
Errada. O diagnóstico está certo, mas plasmaférese não trata a CIVD; o tratamento é a causa e a reposição no sangramento.

D) CIVD / crioprecipitado CORRETA
Correta. Consumo de fatores e de fibrinogênio na sepse é CIVD, e com sangramento e fibrinogênio de 88 a reposição é com crioprecipitado.

Para levar. Esquizócitos com plaquetopenia não são exclusivos da PTT: coagulograma alargado e fibrinogênio baixo na sepse é CIVD; trate a causa e, se sangra, reponha fibrinogênio (crioprecipitado), plaquetas e plasma.

ISTH 2013 harmonized guidance on DIC (Wada et al.); BSH 2009 guidelines on DIC; Surviving Sepsis Campaign 2021.

---

68 Reumatologia · Massa pancreática com IgG4 sérica alta: afastar adenocarcinoma antes da prova com corticoide

Rótulo verdadeiro **Gabarito A**

Homem de 67 anos procura atendimento por icterícia indolor progressiva há 4 semanas, com prurido, colúria e perda de 4 kg. Recebeu diagnóstico de diabetes há 3 meses. Nega etilismo. Há 1 ano teve aumento indolor das

glândulas lacrimais, que regrediu espontaneamente. Exame físico: ictérico, vesícula não palpável, sem massas abdominais. Exames: bilirrubina total 9,4 mg/dL (direta 8,1), fosfatase alcalina 610 U/L, GGT 840 U/L, lipase normal, CA 19-9 de 168 U/mL (VR < 37), IgG4 sérica de 410 mg/dL (VR < 135). TC de abdome com contraste: aumento da cabeça do pâncreas com área hipoatenuante de 2,8 cm, dilatação do ducto pancreático principal a montante de 6 mm com atrofia do corpo e da cauda, e dilatação das vias biliares intra e extra-hepáticas. O próximo passo mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

dilatação do ducto pancreático principal a montante de 6 mm com atrofia do corpo e da cauda

Resolução. IgG4 três vezes acima do limite, homem idoso, diabetes recente e dacrioadenite prévia formam um rótulo forte de pancreatite autoimune tipo 1, e a prova com prednisona parece o atalho. Mas a imagem é de massa focal com dilatação do ducto a montante e atrofia do parênquima distal, achados que favorecem adenocarcinoma; na pancreatite autoimune o ducto costuma estar afilado, sem dilatação a montante. A IgG4 sérica se eleva em cerca de 10% dos adenocarcinomas de pâncreas (valores acima de duas vezes o limite são raros no câncer, mas não o excluem), e o CA 19-9 sobe com a colestase, então nenhum dos dois decide. Nos critérios internacionais, imagem atípica exige excluir câncer com tecido antes de qualquer corticoide, e a ecoendoscopia com biópsia por agulha é o exame que faz isso e ainda pode mostrar a histologia linfoplasmocitária. A prova com corticoide só é aceitável depois de afastada a neoplasia, com reavaliação de imagem em 2 semanas; usá-la antes pode atrasar uma ressecção curativa.

A) Ecoendoscopia com biópsia por agulha CORRETA
Correta. Massa focal com ducto dilatado a montante e atrofia distal exige afastar adenocarcinoma com tecido antes de tratar como doença por IgG4.

B) PET-CT de corpo inteiro
Errada. A captação ocorre nas duas doenças e não substitui o tecido; seria útil para estadiar depois da confirmação.

C) Repetir IgG4 sérica em 4 semanas
Errada. A IgG4 sérica não separa as duas doenças e repeti-la só adia o exame que decide.

D) Prova terapêutica com prednisona ARMADILHA
Errada. Seria aceitável com imagem de pâncreas difusamente aumentado em salsicha, sem dilatação ductal, e câncer afastado por biópsia; aqui adiaria um tumor ressecável.

Para levar. IgG4 sérica alta não autoriza corticoide numa massa pancreática: ducto dilatado a montante e atrofia distal pedem ecoendoscopia com biópsia antes da prova terapêutica.

International Consensus Diagnostic Criteria for Autoimmune Pancreatitis (ICDC, 2011); ACR/EULAR 2019 classification criteria for IgG4-related disease (critérios de exclusão).

---

69 Geriatria · Quedas por hipotensão ortostática medicamentosa rotuladas como labirintite

Omissão **Gabarito A**

Mulher de 81 anos, hipertensa, com incontinência de urgência e insônia, teve três quedas nos últimos 2 meses, todas ao levantar da cama à noite para urinar, uma com fratura de punho. Usa losartana 50 mg/dia há 5 anos, oxibutinina 5 mg duas vezes ao dia há 3 meses, amitriptilina 25 mg à noite há 2 meses, para insônia, e

betaistina, iniciada após a segunda queda por labirintite. Refere tontura de quem vai desmaiar, sem vertigem rotatória. Exame: PA deitada 142 × 80 mmHg e, após 3 minutos em pé, 112 × 66 mmHg, com FC de 76 para 98 bpm; Dix-Hallpike negativo; marcha lenta, sem sinais extrapiramidais. MEEM 24 (era 28 há 1 ano). A conduta mais adequada para reduzir novas quedas é:

> **O DADO QUE DECIDE**
> *PA deitada 142 × 80 mmHg e, após 3 minutos em pé, 112 × 66 mmHg*

Resolução. A labirintite já está no prontuário e a tontura parece confirmá-la. Mas ela descreve pré-síncope, não vertigem, o Dix-Hallpike é negativo e a PA cai 30 mmHg em pé com aumento compensatório da FC: hipotensão ortostática não neurogênica, cuja causa mais provável são as drogas novas. Amitriptilina (bloqueio alfa e anticolinérgico) e oxibutinina (anticolinérgica) estão nos critérios de Beers para evitar no idoso, causam ortostatismo, sedação e confusão (o MEEM caiu de 28 para 24) e começaram junto com as quedas. A medida de maior impacto é retirar, não acrescentar: suspender as duas (com alternativa não anticolinérgica para a bexiga e higiene do sono ou TCC para a insônia). Fludrocortisona e donepezila tratariam efeitos das drogas com mais drogas.

A) Suspender amitriptilina e oxibutinina CORRETA
Correta. Ortostatismo e queda cognitiva após amitriptilina e oxibutinina, ambas na lista de Beers: desprescrever é a intervenção que reduz quedas.

B) Iniciar donepezila 5 mg/dia
Errada. O declínio cognitivo recente coincide com dois anticolinérgicos; iniciar anticolinesterásico sem retirá-los é cascata de prescrição.

C) Iniciar fludrocortisona 0,1 mg/dia
Errada. Fludrocortisona é para hipotensão ortostática neurogênica sintomática depois de retirar as drogas causadoras; aqui elas ainda estão em uso.

D) Reabilitação vestibular e manter betaistina ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. Reabilitação vestibular é para vertigem de origem vestibular; aqui a tontura é pré-síncope ortostática, e betaistina também não tem papel.

Para levar. Queda no idoso: medir PA deitado e em pé e revisar a lista de drogas pelo Beers; desprescrever vem antes de tratar o efeito adverso com outra droga.

Critérios de Beers AGS 2023; World Guidelines for Falls Prevention 2022

---

70 Infectologia · Febre amarela grave x leptospirose após enchente

Rótulo verdadeiro | Gabarito C

Homem de 31 anos, trabalhador rural do interior de Minas Gerais, procura atendimento no 6º dia de doença. Há 10 dias limpou a casa após uma enchente, com água até os joelhos. Há 15 dias passou um fim de semana acampado em área de mata onde foram encontrados macacos mortos. Não tem registro de vacinação. O quadro começou com febre alta súbita, cefaleia, mialgia intensa e dor lombar; melhorou no 3º dia por cerca de 24 horas e, a seguir, voltou a febre, com vômitos, icterícia e sangramento gengival. Exame: T 38,9 °C, FC 64 bpm, PA 108 x 70 mmHg, ictérico 3+/4+, sem sufusão conjuntival, panturrilhas indolores. AST 4.800 U/L, ALT 3.100 U/L,

bilirrubina total 9,2 mg/dL (direta 7,4), creatinina 2,9 mg/dL, potássio 4,6 mEq/L, CK 210 U/L, plaquetas 52.000/mm³, leucócitos 3.100/mm³, INR 2,4. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

AST 4.800 U/L, ALT 3.100 U/L

Resolução. A enchente é verdadeira, e icterícia com insuficiência renal e sangramento após contato com água de enchente é a forma ictero-hemorrágica da leptospirose. O laboratório desmente: na leptospirose a icterícia é rubínica com transaminases pouco elevadas (raramente acima de 200 a 500 U/L), CK alta, leucocitose com desvio e potássio baixo ou normal na lesão renal poliúrica. Aqui as transaminases passam de 3.000 U/L com AST maior que ALT, há leucopenia, CK normal, bradicardia relativa (FC de 64 com 38,9 °C), curso bifásico com remissão de 24 horas e exposição a mata com epizootia em macacos, em pessoa não vacinada: febre amarela na fase de intoxicação. O manejo é de suporte em terapia intensiva, com notificação imediata e avaliação para transplante hepático nos casos de insuficiência hepática aguda.

A) Dengue com acometimento hepático
Errada. Dengue pode elevar transaminases, mas raramente acima de 1.000 com icterícia intensa e insuficiência renal neste padrão, e não tem a epizootia.

B) Hepatite A fulminante
Errada. Hepatite A fulminante eleva muito as transaminases, mas não explica a insuficiência renal, o curso bifásico nem a exposição com epizootia.

C) Febre amarela grave CORRETA
Correta. Não vacinado, mata com macacos mortos, curso bifásico, bradicardia relativa e transaminases acima de 3.000 com AST maior que ALT.

D) Leptospirose, forma ictero-hemorrágica ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a enchente aponta leptospirose, mas transaminases acima de 3.000 U/L, leucopenia, CK normal e bradicardia relativa não são dela.

Para levar. Ictérico febril com transaminases acima de 1.000 U/L, AST maior que ALT, leucopenia e bradicardia relativa é febre amarela; leptospirose tem transaminases modestas, CK alta e leucocitose.

Manual de Manejo Clínico da Febre Amarela (MS, 2020); Leptospirose: diagnóstico e manejo clínico (MS, 2014); Guia de Vigilância em Saúde (MS, 6ª edição, 2023).

71

Gastroenterologia · Pancreatite aguda em portador de insuficiência cardíaca deduzida pelas drogas: hidratação moderada guiada por reavaliação

Droga a deduzir | Gabarito A

Homem de 67 anos, em uso de sacubitril-valsartana, carvedilol, espironolactona, dapagliflozina e furosemida 40 mg/dia, chega com dor epigástrica em faixa há 8 horas e vômitos. Lipase 1.900 U/L; ultrassonografia com colelitíase, sem dilatação de vias biliares. Exame: Tax 37,2 °C, FC 98 bpm, PA 112 × 70 mmHg, FR 20 irpm, SpO2 95% em ar ambiente, mucosas secas, jugulares não túrgidas a 45 graus, sem estertores, sem edema; enchimento capilar de 3 s. Exames: hematócrito 46%, ureia 58 mg/dL, creatinina 1,4 mg/dL (basal 1,1), lactato 2,0 mmol/L, glicemia 128 mg/dL, bicarbonato 23 mEq/L. A reposição volêmica inicial mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

sacubitril-valsartana, carvedilol, espironolactona, dapagliflozina e furosemida

Resolução. A reposição agressiva (20 mL/kg em bolus e 3 mL/kg/h) foi por anos a regra da pancreatite, e é a isca. O estudo WATERFALL mostrou que ela aumenta a sobrecarga hídrica sem melhorar desfechos; a recomendação atual é hidratação moderada com Ringer lactato: 10 mL/kg em bolus se houver hipovolemia e 1,5 mL/kg/h, reavaliando com frequência (diurese, ureia, hematócrito, sinais de congestão). A lista de drogas, sem diagnóstico nomeado, descreve insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida em terapia quádrupla, o que torna a sobrecarga ainda mais perigosa. Mas ele está hipovolêmico (mucosas secas, ureia e hematócrito altos, creatinina acima do basal, sem congestão), e restringir líquido agravaria a hipoperfusão pancreática e renal.

A) Ringer lactato 10 mL/kg e 1,5 mL/kg/h CORRETA

Correta. Hipovolemia em portador de insuficiência cardíaca de fração reduzida: bolus de 10 mL/kg e 1,5 mL/kg/h de Ringer lactato, com reavaliação frequente.

B) Ringer lactato 20 mL/kg e 3 mL/kg/h ARMADILHA

Errada. É a isca: a reposição agressiva aumentou a sobrecarga sem benefício no WATERFALL, e o risco é maior com insuficiência cardíaca de fração reduzida.

C) Soro fisiológico 250 mL/h fixos por 48 horas

Errada. Soro fisiológico em ritmo fixo por 48 horas ignora a reavaliação e favorece acidose hiperclorêmica; o cristaloide preferido é o Ringer lactato.

D) Restrição hídrica pela insuficiência cardíaca

Errada. A insuficiência cardíaca não justifica restrição em quem está hipovolêmico e sem congestão; a hipoperfusão piora a necrose e a lesão renal.

Para levar. Pancreatite aguda: Ringer lactato moderado (10 mL/kg se hipovolêmico e 1,5 mL/kg/h) guiado por reavaliação; nem agressivo, nem restrição.

WATERFALL trial (N Engl J Med, 2022); ACG Guideline: Management of Acute Pancreatitis (2024)

72

Neurologia · Degeneração combinada subaguda por óxido nitroso com B12 sérica normal e sem anemia

Dado omitido

Gabarito C

Homem de 23 anos, estudante, tem há 3 semanas formigamento ascendente nos pés e nas mãos e, há 1 semana, desequilíbrio que piora no escuro. Nega viagens e sexo desprotegido; conta que, nos últimos 4 meses, usa com os amigos 'balões' de festa quase todo fim de semana. Exame: vibratória e propriocepção abolidas até os joelhos, Romberg presente, reflexos patelares vivos, aquileus abolidos, Babinski bilateral. Hemoglobina 14,1 g/dL, VCM 91 fL, vitamina B12 sérica 410 pg/mL (VR 200 a 900), cobre sérico e VDRL normais, HIV não reagente. RM de medula: hipersinal em T2 nos cordões posteriores de C2 a C6, em 'V invertido'. A etiologia mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

usa com os amigos 'balões' de festa quase todo fim de semana

Resolução. Faltam os dois achados mais famosos da deficiência de B12: não há anemia nem macrocitose, e a B12 sérica é normal. Quem procura esses dados descarta a vitamina e vai para EM no adulto jovem. Mas o quadro é de degeneração combinada subaguda: cordões posteriores (vibratória, propriocepção, Romberg) e laterais (Babinski), com hipersinal posterior em 'V invertido' na RM cervical e neuropatia associada (aquileus abolidos). Os balões de festa são óxido nitroso recreativo, que oxida o cobalto da cobalamina e inativa a B12 funcionalmente: a dosagem sérica fica normal, e o que sobe é o ácido metilmalônico e a homocisteína. A anemia costuma faltar porque o tempo de exposição é curto para a medula. A conduta é suspender o óxido nitroso e repor B12 por via parenteral, que melhora o déficit se iniciada cedo. Cobre normal afasta a mielopatia por cobre, que dá o mesmo quadro.

A) Esclerose múltipla, forma medular ARMADILHA
Errada, é a armadilha. EM medular dá lesões curtas, periféricas e assimétricas, não hipersinal simétrico e contínuo de cordões posteriores, e não explica a neuropatia.

B) Mielopatia por deficiência de cobre
Errada. A mielopatia por cobre é clínica e radiologicamente idêntica, mas exige cobre baixo (zinco em excesso, pós-bariátrica); o cobre está normal.

C) Inativação da B12 pelo óxido nitroso CORRETA
Correta. Uso frequente de óxido nitroso, mielopatia de cordões posteriores e laterais com neuropatia e 'V invertido' na RM, com B12 sérica normal por inativação funcional.

D) Mielite transversa pós-viral
Errada. A mielite transversa dá nível sensitivo e alteração esfincteriana de instalação em dias, com lesão que ocupa toda a secção da medula.

Para levar. Óxido nitroso inativa a B12: degeneração combinada com B12 sérica normal e sem anemia. Confirmar com ácido metilmalônico e homocisteína e tratar com B12 parenteral.

BSH 2014 (deficiência de cobalamina); Garakani et al., Am J Addict 2016 (neurotoxicidade do óxido nitroso); Harrison 22ª ed.

73

Nefrologia · Doença renal policística com história familiar de aneurisma roto e Mayo 1D · rastrear aneurisma e iniciar tolvaptana

Grade X / Y **Gabarito A**

Mulher de 34 anos, com doença renal policística autossômica dominante, vem a consulta de seguimento. A mãe iniciou hemodiálise aos 52 anos pela mesma doença, e um tio materno, também portador da doença, morreu aos 45 anos de hemorragia subaracnóidea por ruptura de aneurisma. Está assintomática, com PA de 126/80 mmHg em uso de losartana. Exames: creatinina 1,0 mg/dL, TFGe 76 mL/min/1,73 m², potássio 4,4 mEq/L. Ressonância de abdome: volume renal total ajustado à altura compatível com a classe 1D de Mayo. Quanto ao rastreamento de aneurisma intracraniano e à tolvaptana, as condutas são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

morreu aos 45 anos de hemorragia subaracnóidea por ruptura de aneurisma

Resolução. O rastreamento universal de aneurisma não é recomendado na doença renal policística, e quem sabe disso marca não rastrear sem ler a história familiar. Mas a regra tem exceção: história familiar de aneurisma intracraniano ou de hemorragia subaracnóidea (além de evento prévio, profissão de alto risco ou cirurgia de grande porte planejada) indica rastreamento com angiorressonância sem contraste, porque nesse

grupo a prevalência de aneurisma chega a cerca de 20%, o dobro da dos demais. Quanto à tolvaptana, o antagonista V2 reduz o crescimento dos cistos e a perda de função em quem tem risco de progressão rápida, e a classe de Mayo 1C a 1E com TFGe acima de 25 é o critério mais usado; a mãe em diálise aos 52 anos reforça o risco. Ela tem as duas indicações. A tolvaptana exige monitorização de transaminases pela hepatotoxicidade e orientação sobre a poliúria.

A) Rastrear aneurisma / iniciar tolvaptana CORRETA
Correta. História familiar de aneurisma roto indica rastreamento, e Mayo 1D com TFGe de 76 indica tolvaptana.

B) Rastrear aneurisma / não iniciar tolvaptana
Errada. Rastrear está certo, mas Mayo 1D é risco de progressão rápida e TFGe de 76 está bem acima do limite de 25: a tolvaptana está indicada.

C) Não rastrear / iniciar tolvaptana ARMADILHA
Errada, é a armadilha. A tolvaptana está certa, mas a regra de não rastrear vale para quem não tem história familiar; um tio com hemorragia subaracnóidea por aneurisma muda a indicação.

D) Não rastrear / não iniciar tolvaptana
Errada. Erra nas duas metades: seria a conduta numa classe 1A ou 1B sem história familiar de aneurisma.

Para levar. Na doença renal policística, rastreie aneurisma intracraniano só com história familiar (ou outro fator de risco) e indique tolvaptana na progressão rápida (Mayo 1C a 1E) com TFGe acima de 25.

KDIGO 2025 (Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease); Irazabal et al., JASN 2015 (classificação de imagem de Mayo).

74

Endocrinologia · Hemocromatose HFE no paciente metabólico: saturação de transferrina acima de 45% com homozigose C282Y pede flebotomia, e não só perda de peso

Rótulo verdadeiro | Gabarito B

Homem de 47 anos, com obesidade (IMC 35 kg/m²), diabetes tipo 2 há 4 anos, hipertrigliceridemia e esteatose hepática, bebe duas latas de cerveja nos fins de semana. Há um ano, uma ferritina de 860 ng/mL foi atribuída à síndrome metabólica e ele foi orientado a perder peso, o que não conseguiu. Nega transfusões, artralgia, hiperpigmentação ou disfunção erétil. Exames atuais: hemoglobina 15,6 g/dL, ferritina 910 ng/mL, ferro sérico 212 µg/dL, saturação de transferrina 74% (repetida em jejum: 71%), AST 38 U/L, ALT 56 U/L, plaquetas 236.000/mm³, PCR 3 mg/L. Pesquisa do gene HFE: homozigose C282Y. Elastografia hepática transitória: 5,8 kPa. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE
saturação de transferrina 74% (repetida em jejum: 71%)

Resolução. Obesidade, diabetes, esteatose e álcool são verdadeiros e explicam muitas ferritinas altas, e foi assim que a de 860 ng/mL foi rotulada há um ano. O que separa as duas situações é a saturação de transferrina: a hiperferritinemia dismetabólica tem saturação normal (abaixo de 45%), e aqui ela está em 74% e em 71% em jejum, com homozigose C282Y. É hemocromatose HFE com sobrecarga de ferro, e a síndrome metabólica é comorbidade, não explicação. O tratamento é flebotomia semanal (cerca de 500 mL, conforme a hemoglobina) até ferritina de 50 a 100 ng/mL, seguida de manutenção. A biópsia não é necessária para diagnosticar no homozigoto C282Y, e o estadiamento da fibrose pesa sobretudo com ferritina acima de 1.000

ng/mL, transaminases muito altas ou plaquetas baixas; com ferritina de 910, plaquetas normais e elastografia de 5,8 kPa, fibrose avançada é improvável. Quelante oral fica para quem não pode fazer flebotomia.

A) Biópsia hepática antes de tratar
Errada. Seria considerada para estadiar fibrose com ferritina acima de 1.000 ng/mL, plaquetas baixas ou elastografia alterada; não é necessária para diagnosticar nem para iniciar o tratamento.

B) Flebotomias semanais CORRETA
Correta. Homozigose C282Y com saturação de 74% e ferritina de 910 ng/mL: flebotomias semanais até ferritina de 50 a 100 ng/mL.

C) Perda de peso, sem flebotomia ARMADILHA
Errada. É a armadilha: seria a conduta da hiperferritinemia dismetabólica, com saturação de transferrina abaixo de 45%; com 74% e homozigose C282Y, a sobrecarga de ferro é real.

D) Deferasirox por via oral
Errada. Quelante é a escolha na sobrecarga transfusional ou quando anemia ou instabilidade impedem a flebotomia; com hemoglobina de 15,6 g/dL, a flebotomia é mais eficaz, barata e segura.

Para levar. A saturação de transferrina separa os dois quadros também no sentido inverso: síndrome metabólica com saturação acima de 45% e homozigose C282Y é hemocromatose, tratada com flebotomia até ferritina de 50 a 100 ng/mL.

EASL Clinical Practice Guidelines on haemochromatosis (2022); ACG Clinical Guideline: Hereditary Hemochromatosis (2019).

---

75 Hematologia · PTI do adulto com FAN em título baixo: a investigação que muda o tratamento é o H. pylori

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Mulher de 39 anos, natural de Minas Gerais, teve PTI diagnosticada há 1 mês, com plaquetas de 24.000/mm³ e petéquias em pernas, e está em prednisona 1 mg/kg/dia há 2 semanas, com plaquetas atuais de 58.000/mm³. Tem hipotireoidismo por tireoidite de Hashimoto, em levotiroxina. Sem artralgias, fotossensibilidade, úlceras orais ou serosite. Exames: Hb 13,2 g/dL, leucócitos 7.100/mm³, urina tipo 1 normal, creatinina normal, FAN 1:80 com padrão nuclear pontilhado fino, sorologias para HIV e hepatites B e C negativas, imunoglobulinas normais. A investigação adicional com maior potencial de mudar o tratamento é:

O DADO QUE DECIDE

Sem artralgias, fotossensibilidade, úlceras orais ou serosite

Resolução. FAN positivo numa mulher jovem com plaquetopenia imune e tireoidite autoimune puxa para lúpus, e o reflexo é pedir anti-DNA e complemento. O negativo no exame clínico desarma o rótulo: sem artrite, fotossensibilidade, úlceras, serosite ou alteração urinária, um FAN de 1:80 com padrão pontilhado fino é achado frequente na PTI e na autoimunidade tireoidiana e não muda a conduta. O que pode mudar o tratamento é o H. pylori: em regiões de alta prevalência, como o Brasil, a erradicação eleva as plaquetas numa parte dos adultos com PTI, e os consensos de H. pylori incluem a PTI entre as indicações de pesquisar e tratar. O mielograma não é necessário com resposta ao corticoide e quadro isolado, e o anticorpo antiplaquetário tem sensibilidade baixa e não orienta conduta.

A) Mielograma com biópsia
Errada. Medula se faz com atipia (outras citopenias, idade avançada, falha terapêutica); ela respondeu ao corticoide.

B) Anti-DNA nativo e complemento ARMADILHA
Errada. É a armadilha: sem nenhum critério clínico de LES, FAN em título baixo não justifica a investigação nem muda o tratamento da PTI.

C) Pesquisa de H. pylori CORRETA
Correta. Na PTI do adulto, pesquisar e erradicar H. pylori pode elevar as plaquetas e é recomendado pelos consensos de H. pylori.

D) Anticorpos antiplaquetários
Errada. O anticorpo antiplaquetário tem baixa sensibilidade e não confirma nem afasta PTI; não orienta conduta.

Para levar. Na PTI do adulto, pesquise e trate H. pylori (pode subir as plaquetas); FAN em título baixo sem clínica de LES é comum e não muda a conduta.

ASH 2019 guidelines for ITP; International Consensus Report on ITP 2019 (Provan et al.); Maastricht VI/Florence consensus report 2022.

---

76 Cardiologia · Síncope reflexa de baixo risco com abalos: alta sem exames

Omissão **Gabarito C**

Mulher de 23 anos, estudante, desmaiou em pé numa fila de banco em dia quente, após 40 minutos sem se alimentar; antes sentiu calor, náusea, visão escurecida e sudorese. Ficou inconsciente por cerca de 20 segundos, com dois abalos dos braços, sem liberação esfincteriana nem confusão depois. Teve episódio semelhante aos 16 anos, em coleta de sangue. O pai teve infarto aos 68 anos. Sem palpitações, sem síncope ao esforço ou deitada, sem morte súbita na família. PA 110×70 mmHg sem queda postural, FC 72 bpm, exames neurológico e cardiovascular normais. ECG: ritmo sinusal, PR 160 ms, QRS 88 ms, QTc 410 ms, sem pré-excitação. Hemoglobina normal, beta-hCG negativo. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE
sem morte súbita na família

Resolução. O infarto do pai e os abalos dos braços são os dois dados plantados para fazê-lo pedir mais: o primeiro empurra para o coração, o segundo para a convulsão. Infarto do pai aos 68 anos não é história familiar de morte súbita (que importa abaixo dos 40 anos e sem explicação), e alguns abalos breves durante a síncope são comuns (síncope convulsiva), sem confusão pós-ictal nem liberação esfincteriana. O restante é síncope reflexa de baixo risco: gatilho (ortostatismo prolongado, calor, jejum), pródromos autonômicos, episódio prévio com coleta de sangue, exame e ECG normais. Pela estratificação, ela recebe alta com explicação, hidratação e manobras de contrapressão, sem eco, Holter ou teste de inclinação, que não mudariam a conduta.

A) Teste de inclinação
Errada. O teste de inclinação é para síncope recorrente sem diagnóstico ou para separar de pseudossíncope; aqui o diagnóstico clínico já está feito.

B) Eletroencefalograma e ressonância de crânio
Errada. Abalos breves na síncope são comuns e não indicam epilepsia sem pós-ictal, mordedura lateral ou liberação.

C) Alta com orientação, sem novos exames CORRETA
Correta. Síncope reflexa de baixo risco com ECG normal: alta, orientação e manobras de contrapressão.

D) Ecocardiograma e Holter ambulatoriais ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. Eco e monitorização são para síncope com marcador de risco (esforço, decúbito, palpitação, cardiopatia, ECG alterado, morte súbita familiar precoce); não há nenhum.

Para levar. Síncope com gatilho, pródromos autonômicos, exame e ECG normais e sem marcador de risco é reflexa de baixo risco: alta sem exames. Abalos breves não fazem crise, e infarto de parente idoso não é morte súbita familiar.

ESC 2018 (syncope); ACC/AHA/HRS 2017 (syncope)

---

77 Infectologia · Ventriculite associada a derivação ventricular externa no idoso: os agentes a cobrir

Rótulo verdadeiro **Gabarito A**

Homem de 68 anos, diabético, no 9º dia de pós-operatório de clipagem de aneurisma da artéria comunicante anterior, com derivação ventricular externa ainda instalada, evolui com febre de 38,9 °C, piora do nível de consciência (Glasgow de 14 para 11) e rigidez de nuca. Líquor colhido pelo cateter: 1.850 células/mm³ (90% neutrófilos), proteína 220 mg/dL, glicose 18 mg/dL (glicemia 160 mg/dL), Gram sem bactérias visíveis. Os agentes que o esquema empírico deve cobrir prioritariamente são:

O DADO QUE DECIDE
com derivação ventricular externa ainda instalada

Resolução. A idade acima de 50 anos e o diabetes trazem a regra do empírico da meningite comunitária: cobrir pneumococo, meningococo e Listeria com ceftriaxona e ampicilina. Mas esta é uma meningite associada a cuidados de saúde, com derivação ventricular externa há 9 dias, e a microbiologia é outra: estafilococos (coagulase-negativos e S. aureus, inclusive resistentes à oxacilina) e bacilos Gram-negativos hospitalares, entre eles Pseudomonas e Acinetobacter. O empírico é vancomicina com betalactâmico antipseudomonas de boa penetração no SNC (cefepima, ceftazidima ou meropenem, conforme a epidemiologia local), além de retirar ou trocar o cateter. Gram sem bactérias não muda a cobertura.

A) Estafilococos e Gram-negativos hospitalares CORRETA
Correta. Meningite com derivação ventricular externa é infecção hospitalar: estafilococos e Gram-negativos hospitalares, com vancomicina e cefepima ou meropenem.

B) Pneumococo, meningococo e Listeria ARMADILHA
Errada. É a armadilha: seria a cobertura da meningite comunitária acima de 50 anos; o cateter define outra microbiologia.

C) Anaeróbios e estreptococos orais
Errada. Anaeróbios e estreptococos orais são os agentes do abscesso cerebral de foco odontogênico ou sinusal.

D) Criptococo e Candida
Errada. Fungos entram em imunossupressão grave ou em cateter prolongado com Gram e culturas sugestivas, não como cobertura inicial aqui.

Para levar. Meningite com derivação, cateter ou pós-neurocirurgia é hospitalar: vancomicina mais betalactâmico antipseudomonas, e não o esquema comunitário por idade.

IDSA Clinical Practice Guidelines for Healthcare-Associated Ventriculitis and Meningitis (2017).

---

78 Reumatologia · Polimialgia reumática sem sinais de arterite: dose inicial de prednisona

Limiar | Gabarito C

Mulher de 71 anos refere dor e rigidez em ombros, pescoço e quadris há 7 semanas, com rigidez matinal de 2 horas e dificuldade para vestir-se. Nega cefaleia, claudicação mandibular, alterações visuais, febre e perda de peso. Tem diabetes tipo 2 com HbA1c 7,1% e osteopenia. Exame físico: dor à mobilização ativa e passiva dos ombros, sem sinovite periférica, força preservada, artérias temporais normais. Exames: VHS 58 mm/h, PCR 3,8 mg/dL, CK, TSH, cálcio e eletroforese de proteínas normais, fator reumatoide e anti-CCP não reagentes. Ultrassonografia: bursite subdeltóidea bilateral. A conduta inicial mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

Nega cefaleia, claudicação mandibular, alterações visuais

Resolução. Polimialgia reumática lembra a arterite de células gigantes, e quem mistura as duas dá dose de arterite (1 mg/kg) ou pede biópsia de temporal. Sem cefaleia, claudicação mandibular, sintomas visuais ou artéria temporal alterada, não há indicação de biópsia nem de dose alta. A dose inicial recomendada para polimialgia é de 12,5 a 25 mg/dia de prednisona, e diabetes e osteopenia pedem a faixa mais baixa, como 15 mg. A resposta costuma ser rápida, em dias, e falta de resposta deve fazer rever o diagnóstico; o desmame é lento, e o metotrexato pode ser associado cedo quando há alto risco de efeitos do corticoide. Doses de 7,5 mg ou menos são insuficientes para o início, e doses acima de 30 mg só acrescentam toxicidade.

A) Prednisona 1 mg/kg/dia ARMADILHA
Errada. É a dose da arterite de células gigantes; sem sinais cranianos, expõe uma diabética com osteopenia a toxicidade sem benefício.

B) Prednisona 40 mg/dia
Errada. Doses acima de 30 mg/dia não se recomendam na polimialgia isolada; 40 a 60 mg/dia é faixa de arterite de células gigantes, sem sinal craniano aqui.

C) Prednisona 15 mg/dia CORRETA
Correta. Polimialgia sem sinais de arterite: prednisona entre 12,5 e 25 mg/dia, na faixa baixa por diabetes e osteopenia.

D) Prednisona 5 mg/dia
Errada. Abaixo da faixa inicial; serve na fase de desmame, não para induzir resposta.

Para levar. Polimialgia reumática isolada: prednisona 12,5 a 25 mg/dia, na faixa baixa com diabetes ou osteoporose. Dose de 1 mg/kg e biópsia são para arterite de células gigantes.

EULAR/ACR 2015 recommendations for the management of polymyalgia rheumatica; EULAR/ACR 2012 provisional classification criteria for polymyalgia rheumatica.

---

79 Pneumologia · Exacerbação de DPOC com acidose respiratória e sonolência: VNI, não intubação

Limiar **Gabarito B**

Homem de 72 anos, com DPOC grave (VEF1 32% do previsto), chega com piora da dispneia e do escarro há 3 dias. Está sonolento, mas desperta ao chamado e obedece a comandos (Glasgow 14), com tosse eficaz e sem vômitos. PA 146 × 88 mmHg, FC 108 bpm, FR 30 irpm, uso de musculatura acessória e respiração paradoxal. Em cateter de O2 a 2 L/min, SpO2 89%. Gasometria: pH 7,27, PaCO2 72 mmHg, PaO2 58 mmHg, HCO3 33 mEq/L. Iniciados broncodilatadores, prednisona e antibiótico. A medida ventilatória mais adequada neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

desperta ao chamado e obedece a comandos (Glasgow 14), com tosse eficaz e sem vômitos

Resolução. Sonolência, pH de 7,27 e respiração paradoxal assustam e empurram para a intubação. Mas a indicação de VNI na exacerbação é exatamente acidose respiratória (pH até 7,35 com PaCO2 acima de 45) com dispneia grave e fadiga, e ela reduz intubação e mortalidade. A sonolência aqui é da hipercapnia e costuma melhorar com a VNI. O que contraindicaria são os limiares que o caso nega: incapacidade de proteger a via aérea, rebaixamento importante sem resposta, vômitos, instabilidade hemodinâmica. Com Glasgow 14, tosse eficaz e PA estável, inicia-se VNI em ambiente monitorizado, com gasometria em 1 a 2 horas e intubação se piorar. O alvo de saturação é 88 a 92%: mais O2 aumenta a PaCO2.

A) Intubação orotraqueal e ventilação mecânica ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. Intubação é para falha da VNI, parada respiratória, rebaixamento sem resposta, vômitos ou instabilidade; nenhum está presente.

B) Ventilação não invasiva com dois níveis de pressão CORRETA
Correta. pH 7,27 com PaCO2 72, fadiga e via aérea protegida: VNI com dois níveis de pressão e reavaliação gasométrica em 1 a 2 horas.

C) Cateter nasal de alto fluxo
Errada. Alto fluxo é alternativa para quem não tolera VNI; na acidose hipercápnica a VNI tem mais evidência.

D) Aumentar o O2 para SpO2 acima de 94%
Errada. Na DPOC hipercápnica o alvo é 88 a 92%; hiperóxia piora a hipercapnia e a acidose.

Para levar. Exacerbação de DPOC com pH até 7,35 e PaCO2 acima de 45: VNI, mesmo com sonolência, se a via aérea está protegida e não há vômitos nem instabilidade.

GOLD 2025; ERS/ATS 2017 (VNI na insuficiência respiratória aguda); Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica AMIB/SBPT 2013

---

80 Oncologia · Neurotoxicidade induzida por opioide após aumento de dose e lesão renal

Cronologia **Gabarito C**

Mulher de 72 anos com câncer de mama metastático para ossos, em cuidados paliativos domiciliares, usava morfina oral 60 mg/dia com bom controle da dor. Há 10 dias a dose foi aumentada para 120 mg/dia por dor no quadril; há 5 dias passou a ingerir pouco líquido e a vomitar. Há 2 dias tem abalos musculares, sonolência alternada com agitação, alucinações visuais e dor generalizada ao toque leve, que piora a cada dose de resgate. Exame: Tax 36,5 °C, mioclonias multifocais, pupilas mióticas, FR 14 irpm, sem déficit focal. Exames: creatinina 2,6 mg/dL (era 0,8 há 1 mês), cálcio corrigido 9,8 mg/dL, sódio 138 mEq/L, glicemia 104 mg/dL. A causa mais provável do quadro é:

O DADO QUE DECIDE

creatinina 2,6 mg/dL (era 0,8 há 1 mês)

Resolução. Dor que piora apesar de mais opioide sugere progressão da doença, e a resposta instintiva é subir a dose de novo. Mas a cronologia monta outra coisa: dose dobrada há 10 dias, desidratação por vômitos há 5 e creatinina que foi de 0,8 a 2,6. A lesão renal acumula metabólitos da morfina (sobretudo morfina-3-glicuronídeo), que produzem neurotoxicidade induzida por opioide: mioclonias multifocais, alucinações, delirium flutuante e hiperalgesia (dor ao toque leve que piora com o resgate). O cálcio corrigido normal afasta hipercalcemia, e o quadro não é focal. A conduta é hidratar, reduzir a dose e fazer rotação para opioide sem metabólito renal ativo (fentanil ou metadona), e não aumentar a morfina.

A) Hipercalcemia da malignidade
Errada. Hipercalcemia daria confusão e desidratação em câncer de mama com metástase óssea, mas o cálcio corrigido é 9,8 mg/dL.

B) Progressão da dor óssea metastática ARMADILHA
Errada. É a isca: tratar como dor mal controlada leva a mais morfina, que alimenta a hiperalgesia e as mioclonias.

C) Neurotoxicidade induzida por opioide CORRETA
Correta. Aumento de dose, lesão renal por desidratação, mioclonias, alucinações e hiperalgesia: neurotoxicidade por acúmulo de metabólitos da morfina.

D) Metástases cerebrais
Errada. Metástase cerebral daria cefaleia, déficit focal ou crise; não explica mioclonias multifocais com hiperalgesia ligadas à função renal.

Para levar. Mioclonias, delirium e dor que piora com o resgate em quem usa morfina e perde função renal: neurotoxicidade por opioide; hidratar e fazer rotação do opioide.

ESMO Clinical Practice Guidelines: Management of cancer pain in adult patients (2018); Caraceni et al., EAPC recommendations on the use of opioids in cancer pain (Lancet Oncol, 2012)